

Bunga Rampai

KEPERAWATAN KELUARGA DALAM PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

M. Agung Akbar
Imran Yaman
Yenny B. Makahaghi

Editor: Imran Yaman



BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN KELUARGA DALAM PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

Penulis:

Ns. M. Agung Akbar, S.Kep., M.Kep.

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Yenny B. Makahaghi, S.Kep., M.Kes.

Editor:

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Pendekatan Multidisipliner

Penulis: Ns. M. Agung Akbar, S.Kep., M.Kep.

Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Yenny B. Makahaghi, S.Kep., M.Kes.

Editor: Imran Yaman, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantiyoso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-57-2

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Pendekatan Multidisipliner ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dan pengalaman akademisi serta praktisi di bidang keperawatan keluarga yang menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif lintas profesi dalam memberikan pelayanan yang holistik dan berpusat pada keluarga. Di tengah dinamika tantangan kesehatan masyarakat, pendekatan multidisipliner menjadi semakin penting untuk memastikan intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Isi buku ini mencakup berbagai topik penting, mulai dari konsep kolaborasi interprofesional dalam asuhan keperawatan keluarga, intervensi terhadap gangguan mental dan emosional dalam konteks keluarga, hingga integrasi psikologi keluarga dalam proses keperawatan. Masing-masing bab disusun secara sistematis, tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menekankan pada aplikasi praktis serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Harapannya, pembaca dapat memperoleh wawasan menyeluruh tentang peran perawat dalam tim multidisipliner dan bagaimana keperawatan keluarga dapat ditingkatkan melalui pendekatan lintas bidang keilmuan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi, serta semua pihak yang mendukung proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan keluarga. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN PENDEKATAN KOLABORASI INTERPROFESIONAL..... 1

Ns. M. Agung Akbar, S.Kep., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan keluarga	3
C. Keluarga sebagai Fokus Utama dalam Pendekatan Kolaborasi	6
D. Perspektif Pasien dan Keluarga terhadap Kolaborasi Tim Interprofesional dalam Layanan Kesehatan	10
E. Manfaat Kolaborasi Interprofessional dalam Keperawatan Keluarga	16
F. Profesional Kesehatan sebagai Tim Kolaborasi.....	22
G. Perawat sebagai Pemimpin dalam Perawatan Berbasis Tim.....	29
H. Tantangan Kolaborasi Interprofessional dalam Keperawatan Keluarga	32
I. Referensi	34

CHAPTER 2 INTERVENSI KEPERAWATAN KELUARGA UNTUK PENYAKIT MENTAL DAN GANGGUAN EMOSIONAL: KOLABORASI LINTAS PROFESI..... 43

Imran Yaman S.Kep Ns M.Kes	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Konsep Dasar Penyakit Mental dan Gangguan Emosional dalam Keluarga	46
C. Model Intervensi Keperawatan Keluarga untuk Penyakit Mental dan Gangguan Emosional.....	48
D. Strategi Intervensi Keperawatan Berbasis Keluarga	52
E. Kolaborasi Lintas Profesi dalam Intervensi Keperawatan Keluarga	55
F. Hambatan dan Tantangan dalam Kolaborasi Lintas Profesi dalam Intervensi Keperawatan Berbasis Keluarga	60
G. Simpulan	63
H. Referensi	64
I. Glosarium.....	65

CHAPTER 3 INTEGRASI PSIKOLOGI KELUARGA DALAM ASUHAN KEPERAWATAN.....	67
Ns. Yenny B. Makahaghi, S.Kep., M.Kes.....	67
A. Pendahuluan/Prolog	67
B. Konsep Dasar Psikologi Keluarga dalam Keperawatan.....	69
C. Peran Psikologi Keluarga dalam Asuhan Keperawatan	71
D. Identifikasi Masalah Psikologis dalam Keluarga dalam Konteks Praktik Keperawatan.....	74
E. Strategi Integrasi Psikologi Keluarga dalam Proses Keperawatan	76
F. Peran Perawat dalam Integrasi Psikologi Keluarga dalam Asuhan Keperawatan.....	79
G. Hambatan dan Tantangan dalam Integrasi Psikologi Keluarga dalam Keperawatan.....	82
H. Simpulan	84
I. Referensi	86
J. Glosarium.....	87
PROFIL PENULIS	91

CHAPTER 1

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN PENDEKATAN KOLABORASI INTERPROFESIONAL

Ns. M. Agung Akbar, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan kolaborasi interprofesional merupakan inovasi penting dalam pelayanan kesehatan modern. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Dalam dunia keperawatan, keluarga dipandang sebagai unit penting yang memengaruhi kesehatan individu (Sigmon et al., 2023). Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memahami dinamika keluarga sebagai dasar dalam memberikan asuhan yang holistik. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, pendekatan kolaboratif ini mampu menjawab tantangan kompleks dalam pengelolaan kesehatan keluarga. Fokus utama pendekatan ini adalah menciptakan solusi kesehatan yang efektif melalui kerja sama lintas profesi (Wiarsih et al., 2023).

Kolaborasi interprofesional dalam asuhan keperawatan keluarga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing profesi. Setiap profesi memiliki keahlian spesifik yang dapat saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga (Granrud et al., 2019). Perawat, sebagai koordinator utama dalam tim, bertugas untuk memastikan komunikasi yang efektif antarprofesi. Dokter memberikan intervensi medis, sementara ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial mendukung dengan intervensi yang relevan sesuai kebutuhan keluarga. Dengan pemahaman peran yang jelas, setiap anggota tim dapat berkontribusi maksimal untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan profesional (Dahlke et al., 2020).

Kompleksitas masalah kesehatan keluarga menjadi tantangan utama dalam implementasi pendekatan kolaborasi interprofesional. Setiap keluarga memiliki karakteristik unik yang membutuhkan strategi asuhan yang disesuaikan. Permasalahan seperti penyakit kronis, kesehatan mental, atau akses terhadap layanan kesehatan seringkali memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi antarprofesi memungkinkan identifikasi masalah secara lebih menyeluruh dan solusi yang lebih inovatif. Dengan pendekatan ini, keluarga tidak hanya menerima asuhan keperawatan yang berkualitas tetapi juga dukungan dari berbagai aspek yang

mendukung kesejahteraan mereka. Keseluruhan proses ini memberikan dampak positif baik bagi keluarga maupun tenaga kesehatan (Verspuy & Van Bogaert, 2018).

Penerapan pendekatan kolaborasi interprofesional juga membawa perubahan signifikan dalam cara perawat memberikan asuhan. Perawat kini tidak hanya bertugas secara individu, tetapi juga menjadi bagian dari tim lintas disiplin yang memiliki visi yang sama (Hoffman & Cowdery, 2021). Pendekatan ini menuntut perawat untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen yang baik. Dalam konteks ini, perawat juga bertindak sebagai pendidik bagi keluarga, membantu mereka memahami pentingnya perawatan preventif dan pengelolaan kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, perawat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lingkungan kesehatan yang berorientasi pada keluarga (Martin et al., 2022).

Selain itu, pendekatan kolaborasi interprofesional menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses asuhan. Keluarga tidak hanya menjadi objek perawatan tetapi juga subjek yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Perawat dan anggota tim lainnya bekerja sama dengan keluarga untuk menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pendekatan ini memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada keluarga dalam menjaga kesehatan mereka. Dengan melibatkan keluarga secara aktif, hasil asuhan yang dicapai cenderung lebih berkelanjutan dan sesuai dengan harapan mereka (Orchard et al., 2018).

Pentingnya pendekatan kolaborasi interprofesional semakin terasa dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini. Perubahan gaya hidup, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, serta kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan menjadi isu yang memerlukan solusi lintas profesi (Norris et al., 2015). Dalam menghadapi masalah ini, kolaborasi interprofesional memberikan peluang untuk mengintegrasikan berbagai perspektif ke dalam satu pendekatan yang terkoordinasi. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi lebih efektif tetapi juga lebih efisien. Hal ini juga memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Sakai et al., 2017).

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi pendekatan kolaborasi interprofesional. Tenaga kesehatan harus dibekali dengan keterampilan kolaboratif sejak awal pendidikan mereka. Kurikulum pendidikan keperawatan, misalnya, harus mencakup pengembangan kemampuan komunikasi antarprofesi, manajemen konflik, dan pemahaman lintas budaya. Dengan pembekalan ini, tenaga kesehatan akan lebih siap untuk bekerja dalam tim yang beragam. Selain itu, pelatihan berkelanjutan di

tempat kerja juga menjadi langkah penting untuk memastikan kemampuan kolaborasi tetap terasah seiring dengan perkembangan zaman (Cacchione, 2020).

Keberhasilan pendekatan kolaborasi interprofesional juga memerlukan dukungan dari kebijakan dan regulasi yang jelas. Pemerintah dan organisasi kesehatan harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan pendekatan ini. Hal ini mencakup pengaturan tanggung jawab antarprofesi, pengakuan peran masing-masing profesi, serta pengembangan insentif yang mendorong kerja sama. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, penerapan kolaborasi interprofesional cenderung sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, sinergi antara tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendekatan ini (Will et al., 2019).

Dampak positif dari pendekatan kolaborasi interprofesional tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam tim yang kolaboratif, tenaga kesehatan memiliki kesempatan untuk saling belajar dan bertukar pengetahuan (Wiarsih et al., 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga memperkuat hubungan profesional. Kerja sama lintas profesi juga mengurangi beban kerja yang sering dirasakan oleh perawat ketika harus menangani masalah kesehatan keluarga secara sendiri. Dengan saling berbagi tanggung jawab, kepuasan kerja tenaga kesehatan dapat meningkat secara signifikan (Sørensen et al., 2020).

Sebagai kesimpulan, pendekatan kolaborasi interprofesional dalam asuhan keperawatan keluarga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal melalui kerja sama lintas profesi. Dengan melibatkan keluarga secara aktif, pendekatan ini tidak hanya menciptakan solusi kesehatan yang efektif tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat antara tenaga kesehatan dan keluarga. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, holistik, dan berkelanjutan.

B. Konsep Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan keluarga

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang semakin diakui sebagai landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam konteks keperawatan keluarga.

1. Pengertian Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Keluarga

Kolaborasi interprofesional dapat didefinisikan sebagai kerja sama antara berbagai profesi dalam bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terkoordinasi, berpusat pada pasien, dan berbasis keluarga (Wiarsih et al., 2023). Dalam konteks keperawatan keluarga, kolaborasi ini bertujuan untuk memadukan

pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu guna memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga secara holistik (Keshmiri, 2021). Pendekatan ini mencakup komunikasi efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan aktif keluarga sebagai mitra dalam perawatan (Will et al., 2019).

Keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pemberian pelayanan kesehatan (Friedman & Bowden, 2010). Oleh karena itu, kolaborasi antarprofesi diperlukan untuk memahami dinamika keluarga, mengenali kebutuhan spesifik setiap anggota, dan merancang intervensi yang sesuai (Karam et al., 2022). Dengan bekerja secara sinergis, tim kolaborasi interprofesional dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam menangani berbagai tantangan kesehatan yang kompleks (Karam et al., 2022).

2. Prinsip Dasar Kolaborasi Interprofesional

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam kolaborasi interprofesional, khususnya dalam keperawatan keluarga. Pertama, kesetaraan di antara anggota tim, di mana setiap profesi dihargai atas kontribusinya tanpa memandang hierarki. Kedua, komunikasi terbuka yang memungkinkan pertukaran informasi secara transparan dan efektif untuk menghindari miskomunikasi. Ketiga, fokus pada pasien dan keluarga, yang berarti keputusan diambil berdasarkan kebutuhan dan preferensi keluarga, bukan semata-mata dari sudut pandang profesional kesehatan (Sigmon et al., 2023).

Prinsip lainnya adalah kerja tim berbasis saling percaya, di mana setiap anggota tim saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pengambilan keputusan bersama menjadi elemen penting, di mana keluarga dilibatkan secara aktif dalam menyusun rencana perawatan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan tetapi juga memperkuat hubungan antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan (Lalonde et al., 2014).

3. Tujuan Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Keluarga

Tujuan utama kolaborasi interprofesional dalam keperawatan keluarga adalah memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memastikan bahwa setiap kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi (Orchard et al., 2017b). Selain itu, kolaborasi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan mengurangi duplikasi tugas dan memastikan koordinasi yang baik di antara anggota tim.
- Memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses perawatan, sehingga mereka merasa lebih diberdayakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka.

- Meningkatkan hasil kesehatan melalui pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menangani masalah kesehatan secara menyeluruh.
 - Mengurangi beban kerja individu pada tenaga kesehatan, dengan membagi tanggung jawab secara merata di antara anggota tim.
 - Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, yang sering kali dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan tim kesehatan.
- (Sigmon et al., 2023; Waltz et al., 2023)

4. Implementasi Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Keluarga

Penerapan kolaborasi interprofesional dalam keperawatan keluarga melibatkan beberapa langkah strategis yang harus diintegrasikan ke dalam praktik pelayanan kesehatan. Berikut adalah komponen utama implementasi kolaborasi interprofesional:

a. Identifikasi Peran dan Tanggung Jawab

Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab mereka secara jelas untuk mencegah tumpang tindih tugas dan memastikan efektivitas kerja sama. Misalnya, dokter bertanggung jawab untuk menetapkan diagnosis medis, sementara perawat mengoordinasikan pelaksanaan rencana perawatan di rumah. Ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial juga memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan kebutuhan keluarga (Karam et al., 2022).

b. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi menjadi fondasi dari keberhasilan kolaborasi interprofesional. Setiap anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan pasien, keluarga, dan rekan kerja untuk memastikan semua informasi relevan tersampaikan. Penggunaan bahasa sederhana, mendengarkan secara aktif, dan menghindari jargon medis adalah strategi yang dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga (Kurniasih et al., 2024).

c. Rapat Tim yang Terkoordinasi

Rapat tim yang teratur dan terkoordinasi menjadi langkah penting untuk membahas perkembangan pasien, mengevaluasi intervensi, dan menyusun rencana perawatan selanjutnya. Dalam konteks keperawatan keluarga, rapat ini juga melibatkan keluarga sebagai mitra aktif yang memberikan perspektif tentang kebutuhan dan preferensi mereka (Kurniasih et al., 2024).

d. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga

Keluarga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra dalam perawatan. Oleh karena itu, edukasi tentang cara mengelola kondisi kesehatan, menggunakan peralatan medis, dan mendukung anggota keluarga lainnya

menjadi bagian integral dari implementasi kolaborasi. Dengan pemberdayaan ini, keluarga dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga kesehatan mereka (Sirimsi et al., 2022).

e. Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kolaborasi interprofesional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Umpan balik dari pasien dan keluarga juga menjadi alat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses evaluasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara keluarga dan tim kesehatan (van Staalduinen et al., 2023).

C. Keluarga sebagai Fokus Utama dalam Pendekatan Kolaborasi

Keluarga dipandang sebagai fokus utama yang tidak dapat diabaikan. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung kesehatan setiap anggotanya. Keberhasilan kolaborasi interprofesional dalam keperawatan keluarga sangat bergantung pada sejauh mana keluarga dilibatkan dalam proses perawatan. Pentingnya keterlibatan aktif mereka, serta strategi untuk memastikan keluarga tetap menjadi pusat perhatian dalam pendekatan kolaborasi (Friedman & Bowden, 2010).

1. Memahami keluarga sebagai sistem, keluarga sebagai klien, dan keluarga sebagai konteks

Dengan segala dinamika dan perannya, keluarga menjadi pusat perhatian dalam banyak pendekatan kesehatan modern, khususnya dalam keperawatan keluarga. Dalam konteks ini, memahami bagaimana keluarga dapat dilihat dan didekati melalui berbagai perspektif menjadi hal yang sangat penting bagi para profesional kesehatan. Tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam keperawatan keluarga: keluarga sebagai sistem, keluarga sebagai klien, dan keluarga sebagai konteks (Friedman & Bowden, 2010).

a. *Family as a System* (Keluarga sebagai Sistem)

Pendekatan ini memandang keluarga sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Dalam kerangka ini, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain. Setiap perubahan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga akan berdampak pada seluruh sistem keluarga (Friedman & Bowden, 2010). Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga sakit, dinamika keluarga secara keseluruhan dapat berubah, seperti penyesuaian dalam peran, tanggung jawab, dan pola komunikasi.

Dalam keperawatan, pendekatan keluarga sebagai sistem mengarahkan perhatian pada bagaimana interaksi dan hubungan di dalam keluarga memengaruhi kesehatan anggotanya. Perawat tidak hanya fokus pada individu yang sakit tetapi juga pada dampak kondisi tersebut terhadap keluarga secara keseluruhan. Misalnya, jika seorang ibu mengalami penyakit kronis, perawat akan mengevaluasi bagaimana hal itu memengaruhi peran ayah sebagai pasangan dan tanggung jawab anak-anak dalam keluarga (Sittner et al., 2007).

Pendekatan ini juga mendorong identifikasi pola dukungan yang ada di dalam keluarga. Misalnya, anggota keluarga yang lebih dewasa mungkin memiliki peran penting sebagai pemberi dukungan emosional dan praktis bagi anggota lainnya. Dalam hal ini, perawat bekerja untuk memperkuat mekanisme dukungan keluarga untuk membantu keluarga menghadapi tantangan kesehatan (Tang et al., 2023).

Prinsip utama dari pendekatan ini adalah mengakui bahwa keluarga adalah sistem yang dinamis. Oleh karena itu, intervensi harus dirancang untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi sistem keluarga, bukan hanya untuk individu tertentu. Pendekatan ini sangat efektif untuk menangani masalah kompleks, seperti penyakit kronis atau kondisi kesehatan mental, yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga (Diriba et al., 2021).

b. *Family as a Client* (Keluarga sebagai Klien)

Pendekatan ini memandang keluarga secara keseluruhan sebagai penerima utama intervensi keperawatan. Dalam kerangka ini, fokus perhatian tidak hanya pada satu individu tetapi pada seluruh keluarga sebagai satu unit klien. Pendekatan ini relevan ketika kesehatan seluruh keluarga dipengaruhi oleh satu atau lebih faktor yang memengaruhi mereka secara kolektif, seperti pandemi, bencana alam, atau isu kesehatan masyarakat lainnya (Friedman & Bowden, 2010).

Ketika keluarga dianggap sebagai klien, perhatian diberikan pada kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan kolektif seluruh anggota keluarga. Misalnya, jika satu keluarga menghadapi stres akibat diagnosis kanker pada salah satu anggotanya, perawat akan merancang intervensi yang tidak hanya mendukung pasien tetapi juga mendukung anggota keluarga lainnya yang mungkin mengalami stres emosional atau kelelahan fisik sebagai caregiver (Gullick et al., 2019).

Pendekatan ini juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Perawat dapat membantu keluarga mengembangkan strategi coping, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mendukung

kesehatan kolektif mereka. Dengan memperlakukan keluarga sebagai klien, perawat memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Mathur et al., 2022).

Selain itu, pendekatan ini menyoroti pentingnya pemantauan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk kesehatan emosional, sosial, dan ekonomi. Intervensi sering kali melibatkan penguatan hubungan di dalam keluarga dan membantu mereka mengatasi konflik atau tekanan yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka (Zhou et al., 2023).

c. *Family as a Context* (Keluarga sebagai Konteks)

Dalam pendekatan ini, keluarga dipandang sebagai latar belakang atau konteks untuk memberikan perawatan kepada individu. Fokus utamanya adalah pada individu pasien, tetapi keluarga tetap dipertimbangkan sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi pasien. Pendekatan ini sering digunakan ketika pasien memerlukan dukungan dari keluarga untuk menjalani perawatan yang efektif, seperti dalam kasus pemulihan pascaoperasi atau manajemen penyakit kronis (Friedman & Bowden, 2010).

Misalnya, jika seorang anak didiagnosis dengan asma, keluarga dianggap sebagai konteks yang memengaruhi kepatuhan anak terhadap pengobatan dan pengelolaan penyakit. Dalam hal ini, perawat akan mengevaluasi sejauh mana keluarga mendukung kebutuhan anak, termasuk pemahaman mereka tentang asma, kemampuan mereka untuk memberikan pengobatan, dan pengelolaan lingkungan rumah untuk mengurangi pemicu asma (Veiga-Seijo et al., 2022).

Pendekatan ini juga mengakui bahwa keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan perawatan individu. Dukungan emosional dan fisik dari keluarga dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien, sementara kurangnya dukungan dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, intervensi sering kali dirancang untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam mendukung kebutuhan individu pasien (Campos et al., 2015).

Namun, dalam pendekatan ini, perhatian terhadap keluarga biasanya bersifat sekunder, karena fokus utama tetap pada individu. Perawat akan memberikan edukasi atau intervensi yang diarahkan kepada keluarga hanya jika hal itu relevan untuk mendukung perawatan pasien. Misalnya, mengajarkan anggota keluarga tentang teknik perawatan luka atau manajemen obat untuk pasien dengan kondisi kronis (Bailey et al., 2010).

2. Peran Keluarga dalam Keperawatan Berbasis Kolaborasi

Keluarga memiliki peran multifungsi dalam mendukung kesehatan anggota-anggotanya, mulai dari memberikan perawatan langsung hingga menjadi penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam situasi perawatan kronis, keluarga sering kali bertindak sebagai caregiver utama yang memastikan kebutuhan pasien terpenuhi setiap hari. Peran ini menjadi semakin penting ketika pasien memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti pada lansia atau anak-anak dengan penyakit kronis (Watanabe et al., 2023).

Selain sebagai caregiver, keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang mewakili pasien dalam situasi tertentu. Dalam banyak kasus, anggota keluarga harus memahami rencana perawatan, mempertimbangkan pilihan medis, dan berkolaborasi dengan tim kesehatan untuk menentukan langkah terbaik. Dengan begitu, keluarga tidak hanya menjadi objek perawatan tetapi juga subjek aktif yang memberikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan (Busari et al., 2017).

Peran keluarga sebagai sumber dukungan emosional juga sangat penting. Kehadiran keluarga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pasien yang menghadapi tekanan fisik atau emosional. Dukungan moral dari keluarga membantu pasien merasa dihargai, diperhatikan, dan termotivasi untuk mematuhi rencana perawatan yang telah disusun (Santschi et al., 2021).

3. Pentingnya Keterlibatan Keluarga dalam Kolaborasi Interprofesional

Keterlibatan keluarga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi interprofesional. Keluarga yang dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pasien, sehingga mampu mendukung keputusan perawatan dengan lebih efektif. Ketika keluarga dilibatkan dalam diskusi dan perencanaan, mereka merasa memiliki kontrol atas situasi dan lebih percaya terhadap tim kesehatan (García-Sierra & Fernández-Castro, 2018).

Keterlibatan aktif keluarga juga memperkuat hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Interaksi yang terbuka memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, sehingga kebutuhan pasien dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Sebaliknya, jika keluarga tidak dilibatkan, keputusan yang diambil oleh tim kesehatan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi dan kebutuhan pasien (Kurniasih et al., 2024).

Keterlibatan keluarga juga meningkatkan keberlanjutan perawatan. Pasien yang didukung oleh keluarga yang terlibat cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pengobatan. Selain itu, keterlibatan keluarga dapat

mengurangi risiko kekambuhan penyakit atau komplikasi karena keluarga mampu mengawasi dan membantu pasien menjalankan rencana perawatan di rumah (Carron et al., 2021).

4. Strategi untuk Melibatkan Keluarga sebagai Fokus Utama

Melibatkan keluarga dalam pendekatan kolaborasi memerlukan strategi yang terencana dan berpusat pada kebutuhan mereka. Salah satu langkah awal adalah memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga tentang peran mereka dalam proses perawatan. Tim kesehatan perlu menjelaskan rencana perawatan, kondisi pasien, dan bagaimana keluarga dapat berkontribusi secara efektif.

Komunikasi yang inklusif menjadi kunci lain dalam melibatkan keluarga. Tim kesehatan harus memastikan bahwa keluarga merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak menggunakan jargon medis membantu keluarga memahami situasi dengan lebih baik. Selain itu, mendengarkan masukan keluarga tanpa menghakimi menciptakan suasana kolaborasi yang harmonis (Santschi et al., 2021).

Melibatkan keluarga dalam rapat tim atau diskusi tentang rencana perawatan juga menjadi langkah penting. Rapat ini memberikan platform bagi keluarga untuk memahami perkembangan pasien, mengajukan pertanyaan, dan memberikan perspektif mereka. Dengan cara ini, keluarga dapat merasa lebih diberdayakan dan terlibat dalam setiap langkah proses perawatan (Iguiñiz-Romero & Guerra-Reyes, 2020).

Pendekatan lain adalah dengan memberikan dukungan emosional kepada keluarga. Keluarga yang mendampingi pasien sering kali mengalami tekanan psikologis akibat tanggung jawab yang mereka pikul. Tim kesehatan dapat menawarkan bantuan, seperti sesi konseling, kelompok pendukung, atau sekadar menyediakan waktu untuk mendengarkan kekhawatiran mereka (Carron et al., 2021).

D. Perspektif Pasien dan Keluarga terhadap Kolaborasi Tim Interprofesional dalam Layanan Kesehatan

Kolaborasi tim interprofesional telah menjadi pendekatan yang semakin diutamakan dalam memberikan layanan kesehatan yang holistik dan berkualitas. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan interaksi antarprofesional dari berbagai disiplin ilmu, tetapi juga menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat dari seluruh proses perawatan. Sebagai penerima utama layanan kesehatan, pasien dan keluarga memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan kolaborasi tim. Namun, untuk memahami sepenuhnya bagaimana kolaborasi ini memengaruhi

kualitas perawatan, penting untuk menggali perspektif mereka secara mendalam (Busari et al., 2017; Dahlke et al., 2020).

Pengalaman pasien dan keluarga sering kali mencerminkan efektivitas kerja tim dalam menciptakan hubungan yang saling mendukung. Persepsi mereka mencakup bagaimana komunikasi berlangsung, peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota tim, serta sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, cara tim kesehatan menerapkan nilai-nilai seperti empati, kepercayaan, dan penghormatan terhadap martabat pasien turut memengaruhi bagaimana kolaborasi ini dinilai. Melalui lensa pasien dan keluarga, keberhasilan sebuah tim kolaborasi dapat diukur dari kemampuan mereka untuk memahami kebutuhan individu secara personal (Busari et al., 2017).

Di sisi lain, berbagai tantangan sering muncul ketika kolaborasi tim diterapkan dalam layanan kesehatan. Kesenjangan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan dapat menghambat hubungan yang harmonis, sementara hierarki dalam tim terkadang menciptakan hambatan komunikasi. Dalam konteks ini, persepsi pasien dan keluarga tidak hanya menjadi refleksi dari dinamika tim, tetapi juga menjadi panduan untuk melakukan perbaikan yang berorientasi pada kepentingan mereka. Pendekatan yang mendengarkan suara pasien dan keluarga mampu menciptakan model kolaborasi yang lebih inklusif dan relevan (Dahlke et al., 2020).

Sub Bab ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pasien dan keluarga memandang kolaborasi tim interprofesional dalam layanan kesehatan. Pembahasan ini tidak hanya mencakup kelebihan dan kekurangan dari perspektif mereka, tetapi juga menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam tim kolaborasi. Dengan memahami persepsi ini, kita dapat mendorong transformasi sistem layanan kesehatan yang lebih berpusat pada manusia, di mana kebutuhan pasien dan keluarga menjadi inti dari seluruh upaya perawatan.

1. Nilai dan Etika: Pilar Kerja Sama Tim Kolaborasi Interprofesional

Nilai dan etika menjadi fondasi utama dalam membangun kerja sama tim kolaborasi interprofesional. Pasien dan keluarga sering kali memandang kepercayaan sebagai atribut penting dalam hubungan dengan tim kesehatan. Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang jujur, transparan, dan konsisten antara pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan. Ketika nilai-nilai seperti empati, penghormatan, dan dukungan saling diterapkan, pasien merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi penting tentang kondisi mereka. Sebaliknya, kurangnya penerapan nilai dan etika dapat menciptakan jarak emosional antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, hubungan yang tidak didasari oleh nilai-nilai ini akan menghambat keberhasilan kolaborasi tim (Interprofessional Education Collaborative, 2023).

Empati juga merupakan komponen penting dalam kolaborasi interprofesional yang berpusat pada pasien. Anggota tim kesehatan yang menunjukkan empati mampu memahami kebutuhan dan kekhawatiran pasien dengan lebih baik. Pasien merasa didengarkan ketika tenaga kesehatan menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kondisi mereka. Sebaliknya, jika empati tidak ditunjukkan, pasien cenderung merasa diabaikan dan kurang dihargai sebagai individu. Dengan pendekatan yang empatik, tim kesehatan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk membangun hubungan yang harmonis. Empati juga membantu tim kesehatan mengenali kebutuhan psikososial pasien dan keluarga yang sering kali terabaikan dalam perawatan berbasis klinis (Watanabe et al., 2023).

Dukungan emosional yang diberikan oleh tim kesehatan kepada pasien dan keluarga juga berperan penting dalam memperkuat hubungan. Pasien dan keluarga sering kali menghadapi stres emosional yang tinggi ketika menjalani perawatan. Dalam situasi ini, kehadiran tenaga kesehatan yang mendukung secara emosional memberikan rasa aman dan nyaman. Dukungan ini dapat berupa pendampingan selama pengambilan keputusan atau sekadar memberikan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien. Dukungan yang diberikan dengan penuh perhatian dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tim kesehatan. Sebaliknya, jika pasien merasa tidak didukung, rasa ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan dapat meningkat (van Staalduinen et al., 2023).

Selain itu, penerapan nilai-nilai etika dalam kolaborasi juga mencakup penghormatan terhadap privasi dan martabat pasien. Pasien berhak atas perlindungan data pribadi dan keputusan yang berlandaskan otonomi mereka. Ketika tim kesehatan menjaga privasi dan menghormati martabat pasien, hubungan saling percaya akan terbentuk dengan lebih kuat. Pasien yang merasa dihormati cenderung lebih terbuka untuk berbagi informasi penting terkait kesehatan mereka. Namun, jika privasi dan martabat mereka diabaikan, pasien akan merasa terasing dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan (Mathur et al., 2022; Watanabe et al., 2023).

Nilai dan etika tidak hanya berlaku untuk hubungan antara tim kesehatan dan pasien, tetapi juga di antara anggota tim itu sendiri. Tim yang saling menghormati perbedaan peran, budaya, dan latar belakang setiap anggota dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ketika anggota tim menunjukkan rasa hormat satu sama lain, pasien akan merasakan suasana kerja yang kondusif dan profesional. Oleh karena itu, penerapan nilai dan etika menjadi elemen kunci yang harus diprioritaskan dalam kolaborasi interprofesional (Mathur et al., 2022).

2. Peran dan Tanggung Jawab: Klarifikasi untuk Keterlibatan Pasien

Peran dan tanggung jawab dalam tim kolaborasi interprofesional harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan keterlibatan yang efektif dari pasien dan keluarga. Setiap anggota tim kesehatan memiliki peran unik yang saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Ketika peran ini tidak didefinisikan dengan baik, pasien sering kali merasa bingung tentang siapa yang harus mereka hubungi untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, pasien yang membutuhkan penjelasan tentang rencana perawatan mungkin merasa frustrasi jika tidak mengetahui peran masing-masing anggota tim. Klarifikasi peran dan tanggung jawab membantu menciptakan alur komunikasi yang lebih efektif dan meminimalkan kebingungan (Junge-Maughan et al., 2021).

Keterlibatan pasien sebagai anggota aktif tim kolaborasi interprofesional juga memerlukan pemahaman terhadap peran mereka sendiri. Pasien yang memahami tanggung jawab mereka, seperti memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan atau mematuhi rencana perawatan, cenderung memiliki hasil yang lebih baik. Namun, jika pasien tidak diberi pemahaman yang memadai tentang peran mereka, mereka mungkin merasa tidak memiliki kontrol atas proses perawatan mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang peran pasien dalam tim kolaborasi interprofesional menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan mereka (Waltz et al., 2023).

Hierarki dalam tim kolaborasi interprofesional sering kali menjadi isu yang kompleks, terutama bagi pasien dan keluarga. Dalam beberapa kasus, pasien merasa nyaman dengan model hierarki di mana dokter menjadi pemimpin utama tim. Model ini memberikan rasa kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Namun, hierarki juga dapat menjadi penghalang ketika anggota tim lainnya merasa ragu untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan dokter. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja di mana semua anggota tim merasa diberdayakan untuk mengambil keputusan yang relevan (Djharuddin et al., 2023).

Keluarga pasien juga memegang peran penting sebagai advokat dalam tim kolaborasi interprofesional. Keluarga sering kali menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan, terutama ketika pasien mengalami keterbatasan dalam menyampaikan kebutuhan mereka. Dalam peran ini, keluarga dapat membantu menjelaskan kondisi pasien, memastikan kebutuhan pasien terpenuhi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, untuk menjalankan peran ini dengan baik, keluarga juga perlu diberikan edukasi yang memadai tentang fungsi mereka dalam tim kolaborasi interprofesional (Hellman et al., 2016).

Dalam praktiknya, keterlibatan pasien dan keluarga dalam tim kolaborasi interprofesional dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses perawatan. Ketika pasien dan keluarga merasa dihargai sebagai bagian dari tim, mereka lebih cenderung berkontribusi secara aktif dalam perawatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tim kolaborasi interprofesional, tetapi juga memperkuat hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, definisi peran dan tanggung jawab yang jelas menjadi elemen kunci dalam keberhasilan kolaborasi interprofesional (Hellman et al., 2016).

3. Komunikasi Antarprofesional: Fondasi Keberhasilan Tim

Komunikasi yang efektif merupakan landasan penting dalam keberhasilan tim kolaborasi interprofesional. Tim kesehatan yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Komunikasi yang jelas membantu tim untuk menyampaikan informasi yang relevan, memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang rencana perawatan. Sebaliknya, jika komunikasi tidak efektif, kesalahpahaman dapat terjadi, yang pada akhirnya merugikan pasien. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi menjadi elemen yang harus terus diasah oleh setiap anggota tim kolaborasi interprofesional (Busari et al., 2017).

Pasien dan keluarga sering kali mengharapkan komunikasi yang inklusif dari tim kesehatan. Mereka merasa dihargai ketika dilibatkan dalam diskusi tentang kondisi dan rencana perawatan mereka. Namun, banyak pasien melaporkan bahwa komunikasi dalam tim kolaborasi interprofesional sering kali bersifat hierarkis, di mana keputusan dibuat tanpa melibatkan mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, tim kesehatan harus memastikan bahwa setiap pasien diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Dengan cara ini, pasien akan merasa lebih diberdayakan dalam proses perawatan (Kurniasih et al., 2024).

4. Dinamika Tim: Mencapai Kolaborasi yang Efektif

Dinamika tim yang efektif adalah inti dari keberhasilan kolaborasi interprofesional dalam layanan kesehatan. Pasien dan keluarga sering kali menilai efektivitas tim berdasarkan kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pasien. Sebuah tim yang memiliki dinamika kerja yang harmonis menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memahami peran masing-masing, dan berkolaborasi tanpa konflik yang menghambat tujuan bersama. Sebaliknya, dinamika tim yang buruk, seperti kurangnya koordinasi atau konflik internal, dapat memberikan kesan negatif kepada pasien dan keluarga. Oleh karena itu, membangun dinamika tim yang

sehat menjadi langkah awal untuk menciptakan kolaborasi yang efektif (Kurniasih et al., 2024).

Identifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim adalah salah satu komponen kunci dalam menciptakan dinamika yang baik. Ketika anggota tim memahami fungsi mereka dalam mencapai tujuan bersama, kerja sama menjadi lebih terstruktur dan efisien. Misalnya, jika seorang pasien membutuhkan penanganan gizi, tim harus tahu bahwa ahli gizi bertanggung jawab atas aspek ini, sementara perawat bertugas untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas, tumpang tindih tugas atau bahkan pengabaian tanggung jawab dapat terjadi, yang akhirnya merugikan pasien. Oleh karena itu, proses definisi peran dan tanggung jawab harus menjadi prioritas dalam membangun dinamika tim (Keshmiri, 2021).

Kepemimpinan dalam tim kolaborasi interprofesional juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika tim. Pemimpin tim yang kompeten mampu mengarahkan setiap anggota untuk bekerja menuju tujuan bersama, sambil memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Pasien sering kali mengasosiasikan peran pemimpin dengan dokter, meskipun perawat atau profesional kesehatan lainnya sering lebih terlibat dalam perawatan sehari-hari. Misalnya, dalam banyak kasus, perawat bertindak sebagai penghubung utama antara pasien dan anggota tim lainnya. Namun, tanpa pengakuan yang jelas terhadap peran ini, dinamika tim dapat terganggu. Oleh karena itu, edukasi tentang kepemimpinan kolaboratif menjadi elemen penting untuk memperkuat dinamika tim (van Staaldin et al., 2023).

Efisiensi tim juga menjadi perhatian pasien dalam menilai kualitas kolaborasi interprofesional. Pasien sering kali merasa bingung atau khawatir ketika terlalu banyak anggota tim yang terlibat tanpa koordinasi yang baik. Misalnya, pasien mungkin merasa lelah atau frustrasi jika mereka harus mengulang informasi yang sama kepada berbagai anggota tim. Dalam situasi ini, efisiensi dapat ditingkatkan melalui dokumentasi yang terpusat dan komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Ketika proses kerja terorganisasi dengan baik, pasien merasa lebih percaya terhadap sistem kesehatan yang mereka gunakan (White et al., 2018).

Selain itu, pentingnya koordinasi dalam tim terlihat dari bagaimana pasien merespons kualitas interaksi antaranggota tim. Pasien merasa lebih nyaman dan percaya ketika melihat anggota tim saling mendukung dan bekerja dalam harmoni. Sebaliknya, konflik internal atau komunikasi yang buruk di antara anggota tim dapat menciptakan kesan tidak profesional yang akhirnya memengaruhi persepsi pasien terhadap layanan kesehatan. Dinamika tim yang

kuat memastikan bahwa semua anggota dapat bekerja secara sinergis untuk memberikan hasil terbaik bagi pasien (White et al., 2018).

Dinamika tim yang baik juga membantu menciptakan rasa memiliki bagi pasien dan keluarga terhadap proses perawatan. Ketika pasien merasa dilibatkan dalam diskusi dan keputusan, mereka lebih cenderung mempercayai tim dan mengikuti rencana perawatan dengan penuh komitmen. Dengan demikian, dinamika tim yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga bagi anggota tim itu sendiri. Kolaborasi yang harmonis memperkuat hubungan profesional di dalam tim, meningkatkan kepuasan kerja, dan pada akhirnya menghasilkan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi (van Staalduinen et al., 2023).

E. Manfaat Kolaborasi Interprofessional dalam Keperawatan Keluarga

Kolaborasi interprofesional dalam keperawatan membawa berbagai manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh pasien dan organisasi layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks keperawatan keluarga, manfaat ini menjadi lebih signifikan karena kebutuhan kesehatan yang kompleks sering kali membutuhkan pendekatan multidisiplin. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kolaborasi interprofesional:

1. Hasil Perawatan yang Lebih Baik

Kolaborasi interprofesional berkontribusi langsung pada peningkatan hasil perawatan pasien. Dalam tim yang terintegrasi, tenaga kesehatan dapat berbagi hasil pemeriksaan dan analisis mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi pasien. Pendekatan ini memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan rencana perawatan yang lebih efektif. Misalnya, seorang pasien yang mengalami keluhan sesak napas akan mendapatkan manfaat dari kerja sama antara dokter spesialis paru, perawat, dan ahli gizi untuk menangani masalah tersebut secara menyeluruh. Koordinasi ini mempercepat proses pengambilan keputusan medis, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan pasien dan pengurangan risiko komplikasi (White et al., 2018).

Hasil perawatan yang lebih baik juga mencakup pengurangan angka rawat ulang. Ketika tim kesehatan bekerja bersama untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat sejak awal, kemungkinan pasien harus kembali ke rumah sakit berkurang secara signifikan. Kolaborasi ini mengintegrasikan semua aspek perawatan, mulai dari diagnosis hingga pemulihan. Sebagai contoh, seorang pasien yang menjalani operasi dapat menerima perawatan yang terkoordinasi antara dokter bedah, fisioterapis, dan perawat rehabilitasi. Pendekatan ini

memastikan pasien memiliki panduan yang jelas untuk pemulihan di rumah, sehingga mereka dapat menghindari komplikasi atau cedera ulang (Folkman et al., 2019).

Selain itu, kolaborasi interprofesional meningkatkan pengalaman pasien selama proses perawatan. Pasien merasa lebih nyaman ketika mereka melihat bahwa tenaga kesehatan bekerja secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepercayaan ini memperkuat hubungan antara pasien dan tim kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pasien yang terlibat aktif dalam diskusi dengan tim kesehatan lebih mungkin untuk mematuhi rencana perawatan yang disusun. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan hasil klinis yang lebih baik tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien (Bornman & Louw, 2023).

Kolaborasi juga memungkinkan penanganan yang lebih cepat terhadap masalah kesehatan akut. Dalam situasi darurat, komunikasi yang efektif antara anggota tim dapat menyelamatkan nyawa pasien. Sebagai contoh, dalam kasus serangan jantung, koordinasi antara dokter, perawat, dan teknisi laboratorium memungkinkan diagnosis dan intervensi yang cepat. Ketika semua anggota tim memahami peran mereka dan bekerja dalam harmoni, pasien menerima perawatan yang lebih cepat dan lebih efisien. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan standar perawatan di seluruh sistem kesehatan (Slater et al., 2023).

Penggunaan teknologi yang mendukung kolaborasi juga meningkatkan hasil perawatan. Rekam medis elektronik, misalnya, memungkinkan semua anggota tim untuk mengakses informasi pasien secara real-time. Teknologi ini mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa setiap keputusan perawatan didasarkan pada data yang akurat. Dengan dukungan teknologi ini, kolaborasi interprofesional dapat menghasilkan hasil perawatan yang lebih konsisten dan terukur. Oleh karena itu, kolaborasi bukan hanya tentang kerja sama antarindividu tetapi juga tentang memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk kepentingan pasien (Bollen et al., 2019).

2. Pengurangan Biaya Perawatan

Kolaborasi interprofesional membantu mengurangi biaya perawatan melalui efisiensi yang lebih tinggi. Ketika anggota tim kesehatan bekerja sama, mereka dapat menghindari duplikasi tugas yang tidak perlu. Misalnya, seorang perawat yang memeriksa hasil tes laboratorium sebelumnya dapat menghindari pengulangan tes yang sudah dilakukan. Dengan cara ini, tim kesehatan tidak hanya menghemat waktu tetapi juga sumber daya keuangan. Pengurangan biaya

ini memberikan manfaat langsung bagi pasien, yang tidak perlu membayar untuk prosedur atau layanan yang tidak diperlukan (Carron et al., 2021).

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga mengurangi tekanan finansial pada organisasi kesehatan. Rumah sakit yang mengadopsi pendekatan kolaborasi interprofesional cenderung memiliki operasi yang lebih lancar dan lebih sedikit pemborosan. Sebagai contoh, tim yang terkoordinasi dapat merencanakan perawatan pasien dengan lebih baik, sehingga mengurangi waktu rawat inap yang tidak diperlukan. Pengurangan ini berdampak pada peningkatan kapasitas rumah sakit untuk melayani lebih banyak pasien. Selain itu, efisiensi operasional ini membantu organisasi kesehatan untuk mencapai tujuan keuangan mereka tanpa mengorbankan kualitas layanan (Sackalingam et al., 2022).

Kolaborasi interprofesional juga menurunkan risiko kesalahan medis, yang sering kali mengakibatkan biaya tambahan. Ketika anggota tim berbagi informasi dengan jelas, kemungkinan terjadi kesalahan, seperti pemberian obat yang salah, dapat diminimalkan. Sebagai contoh, seorang pasien dengan alergi tertentu dapat dilindungi jika informasi tersebut tersedia dan diakses oleh semua anggota tim. Dengan mengurangi kesalahan seperti ini, organisasi kesehatan tidak hanya menghindari biaya tambahan tetapi juga melindungi reputasi mereka (Southerland et al., 2016).

Dari perspektif pasien, kolaborasi ini memberikan kelegaan finansial. Ketika pasien tidak harus menghadapi biaya tambahan akibat perawatan yang tidak perlu atau kesalahan medis, mereka merasa lebih percaya terhadap sistem kesehatan. Sebagai contoh, pasien yang mendapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan sebelumnya masih relevan tidak perlu membayar untuk tes ulang. Penghematan ini tidak hanya membantu pasien secara individu tetapi juga menciptakan persepsi positif tentang transparansi dan efisiensi dalam sistem kesehatan (Vasconcelos et al., 2024).

Peningkatan efisiensi ini juga memberikan ruang untuk investasi dalam layanan lain yang mendukung pasien. Misalnya, rumah sakit dapat menggunakan penghematan biaya untuk meningkatkan fasilitas, memperluas layanan kesehatan mental, atau menyediakan program edukasi pasien. Dengan cara ini, manfaat finansial dari kolaborasi interprofesional melampaui penghematan langsung dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan.

3. Kepuasan Kerja yang Lebih Tinggi

Lingkungan kerja yang kolaboratif mendorong kepuasan kerja di antara tenaga kesehatan. Ketika perawat, dokter, dan profesional lain merasa bahwa suara mereka dihargai dalam tim, mereka cenderung memiliki rasa kepuasan

yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka. Misalnya, seorang perawat yang diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang rencana perawatan akan merasa lebih dihargai. Dengan lingkungan yang mendukung ini, tenaga kesehatan merasa lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi pasien (Will et al., 2019).

Kolaborasi interprofesional juga mengurangi beban kerja individu. Dalam tim yang efektif, tugas-tugas didistribusikan secara merata berdasarkan keahlian masing-masing anggota. Sebagai contoh, seorang perawat tidak perlu menangani semua aspek administrasi ketika ada staf lain yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Dengan pembagian kerja yang adil, tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada peran utama mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perawatan (García-Sierra & Fernández-Castro, 2018).

Rasa kebersamaan yang diciptakan oleh kolaborasi ini juga memperkuat hubungan antaranggota tim. Ketika tenaga kesehatan bekerja dalam lingkungan yang saling mendukung, mereka cenderung memiliki hubungan kerja yang lebih harmonis. Hubungan ini tidak hanya menciptakan suasana kerja yang positif tetapi juga meningkatkan efisiensi tim secara keseluruhan. Sebagai contoh, seorang dokter yang merasa nyaman berdiskusi dengan perawat akan lebih mudah mengambil keputusan yang didasarkan pada masukan kolega mereka (Morgan et al., 2020).

Kepuasan kerja yang lebih tinggi juga mengurangi tingkat turnover dalam organisasi kesehatan. Ketika tenaga kesehatan merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih lama bertahan dalam pekerjaan mereka. Pengurangan turnover ini mengurangi biaya yang terkait dengan rekrutmen dan pelatihan staf baru. Selain itu, tim yang stabil cenderung lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada pasien (Nurchis et al., 2022).

Lingkungan kerja yang kolaboratif juga mendukung perkembangan profesional. Tenaga kesehatan memiliki kesempatan untuk belajar dari kolega mereka yang memiliki keahlian berbeda. Misalnya, seorang perawat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen penyakit kronis dengan bekerja sama dengan spesialis. Peluang pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga memperkuat kompetensi tim secara keseluruhan.

4. Akses Informasi yang Lebih Mudah

Kolaborasi interprofesional meningkatkan akses terhadap informasi yang relevan bagi tim kesehatan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan dari berbagai disiplin dapat berbagi data dan catatan medis secara efektif untuk menciptakan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi pasien. Misalnya, seorang dokter

umum dapat dengan mudah mengakses catatan medis yang diperbarui oleh spesialis untuk memahami perkembangan perawatan. Akses ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Ketika semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang sama, koordinasi perawatan menjadi lebih efisien (Morgan et al., 2015).

Integrasi teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mendukung akses informasi. Sistem rekam medis elektronik memungkinkan setiap anggota tim untuk mengakses data pasien secara real-time, mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya informasi. Misalnya, seorang perawat yang mengetahui alergi obat pasien dari rekam medis elektronik dapat mencegah pemberian obat yang berbahaya. Teknologi ini memastikan bahwa setiap langkah perawatan dilakukan dengan dasar yang kuat, mengurangi risiko komplikasi atau kesalahan. Dengan demikian, kolaborasi yang didukung teknologi menciptakan proses perawatan yang lebih aman (Potthoff et al., 2023).

Kemudahan akses informasi juga memperkuat hubungan antara tim kesehatan dan pasien. Ketika informasi dapat dibagikan dengan cepat, pasien merasa bahwa mereka diprioritaskan dan dipahami dengan baik oleh tim kesehatan. Sebagai contoh, pasien yang menerima penjelasan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh tim spesialis dan perawat merasa lebih percaya terhadap rencana perawatan mereka. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasien tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk mengikuti rekomendasi perawatan (Sockalingam et al., 2022).

Selain itu, akses informasi yang mudah membantu tim kesehatan untuk merespons kebutuhan pasien dengan lebih baik. Dalam situasi darurat, kemampuan untuk segera mengakses riwayat kesehatan pasien memungkinkan tindakan cepat yang dapat menyelamatkan nyawa. Misalnya, dalam kasus reaksi alergi akut, informasi tentang alergi yang tercatat sebelumnya membantu tim memberikan perawatan yang tepat dalam waktu singkat. Dengan akses informasi yang optimal, setiap keputusan yang diambil oleh tim kesehatan menjadi lebih terkoordinasi dan relevan dengan kondisi pasien (Hunter et al., 2021).

Akhirnya, kemudahan akses informasi juga mendorong efisiensi administrasi dalam organisasi kesehatan. Dengan mengurangi kebutuhan untuk mencari data secara manual atau meminta dokumen tambahan, waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif dapat dikurangi. Hal ini memberikan lebih banyak waktu bagi tenaga kesehatan untuk fokus pada perawatan langsung pasien. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi, kolaborasi interprofesional tidak hanya meningkatkan hasil klinis tetapi juga mengoptimalkan operasi organisasi kesehatan secara keseluruhan.

5. Pengembangan Keterampilan

Kolaborasi interprofesional memberikan peluang besar bagi tenaga kesehatan untuk mengembangkan keterampilan yang beragam. Dalam lingkungan kerja yang kolaboratif, perawat, dokter, dan profesional kesehatan lainnya dapat belajar dari pengalaman dan keahlian satu sama lain. Misalnya, seorang perawat yang bekerja bersama ahli gizi dapat memperoleh wawasan tentang manajemen diet pasien, yang kemudian dapat diterapkan dalam perawatan harian. Proses ini tidak hanya memperluas pengetahuan tetapi juga meningkatkan kompetensi individu dalam tim (Kenaszchuk et al., 2010).

Kolaborasi ini juga memungkinkan pengembangan keterampilan non-klinis, seperti manajemen waktu, komunikasi interpersonal, dan pengelolaan data administrasi. Ketika tenaga kesehatan bekerja sama dengan staf administrasi, mereka dapat belajar cara menggunakan sistem informasi kesehatan secara lebih efektif. Misalnya, seorang perawat yang terlibat dalam pengelolaan jadwal pasien dapat meningkatkan keterampilannya dalam organisasi dan logistik. Keterampilan ini menjadi penting dalam memastikan kelancaran operasi layanan kesehatan (Hinyard et al., 2018).

Peluang untuk belajar dari kolega dengan latar belakang berbeda juga memperkuat hubungan profesional dalam tim. Ketika anggota tim berbagi pengetahuan dan pengalaman, mereka menciptakan budaya kerja yang saling mendukung dan berorientasi pada pengembangan bersama. Misalnya, seorang dokter spesialis dapat memberikan pelatihan informal kepada perawat tentang teknik diagnostik tertentu, sementara perawat berbagi wawasan tentang interaksi pasien. Hubungan ini tidak hanya memperkuat kompetensi tim tetapi juga meningkatkan kepuasan kerja (Hinyard et al., 2018).

Selain itu, kolaborasi interprofesional membantu tenaga kesehatan untuk tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka. Dengan bekerja dalam tim yang beragam, anggota tim sering kali terpapar pada teknologi baru, pendekatan perawatan inovatif, atau penelitian terkini yang dibawa oleh kolega mereka. Misalnya, seorang fisioterapis yang bekerja sama dengan dokter bedah dapat mempelajari teknik rehabilitasi pascaoperasi yang lebih efektif. Eksposur ini memastikan bahwa setiap anggota tim terus berkembang secara profesional (Southerland et al., 2016).

Pengembangan keterampilan yang didorong oleh kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi tenaga kesehatan tetapi juga bagi organisasi kesehatan. Dengan meningkatkan kompetensi individu, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pasien. Selain itu, tenaga kesehatan yang terampil dan serba bisa cenderung lebih efisien dan beradaptasi terhadap tantangan di tempat

kerja. Dalam jangka panjang, investasi dalam pengembangan keterampilan melalui kolaborasi interprofesional menjadi salah satu strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi kesehatan secara keseluruhan (Sekanina et al., 2024).

F. Profesional Kesehatan sebagai Tim Kolaborasi

Pendekatan kolaborasi interprofesional menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Tim kolaborasi terdiri dari berbagai profesional kesehatan yang memiliki keahlian unik, yang bersama-sama bekerja untuk memberikan asuhan komprehensif bagi keluarga (Watanabe et al., 2023). Sub bab ini membahas identifikasi dan peran setiap anggota tim serta sinergi antarprofesional untuk mencapai tujuan asuhan keluarga.

1. Peran Perawat

Perawat memiliki peran penting sebagai penghubung utama antara pasien, keluarga, dan anggota tim lainnya. Sebagai koordinator utama dalam tim kolaborasi, perawat bertanggung jawab untuk memantau kondisi pasien secara berkala, memastikan rencana perawatan dijalankan sesuai dengan panduan, dan memberikan informasi kepada keluarga tentang perkembangan pasien. Dalam konteks keperawatan keluarga, perawat juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan kesehatan keluarga secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial. Melalui pendekatan holistik ini, perawat memastikan bahwa setiap anggota keluarga menerima perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Kenaszchuk et al., 2010).

Selain sebagai koordinator, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Mereka mengajarkan tentang prosedur medis yang harus dilakukan di rumah, seperti pemberian obat, perawatan luka, atau penggunaan peralatan medis tertentu. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa keluarga dapat mendukung perawatan pasien secara efektif di luar lingkungan rumah sakit. Misalnya, dalam kasus perawatan diabetes, perawat akan mengajarkan anggota keluarga cara memantau kadar gula darah dan memberikan insulin dengan benar. Dengan edukasi yang baik, perawat membantu keluarga menjadi mitra aktif dalam perawatan (Busari et al., 2017).

Perawat juga memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga. Mereka sering kali menjadi pendengar utama bagi pasien yang merasa cemas atau takut terhadap proses perawatan. Dalam situasi sulit, seperti penyakit terminal, perawat membantu keluarga menghadapi tekanan emosional dengan memberikan dukungan moral dan membantu mereka memahami langkah-

langkah perawatan selanjutnya. Peran ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antara perawat dan keluarga tetapi juga meningkatkan kualitas perawatan yang diterima oleh pasien (Granrud et al., 2019).

2. Peran Dokter

Dokter memiliki peran utama dalam menetapkan diagnosis dan merancang rencana perawatan. Dalam tim kolaborasi, dokter sering bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan seluruh proses perawatan berdasarkan kebutuhan pasien. Mereka mengevaluasi kondisi pasien, melakukan pemeriksaan medis, dan menentukan intervensi yang diperlukan. Sebagai contoh, dalam kasus penyakit kronis seperti hipertensi, dokter akan mengevaluasi riwayat kesehatan pasien, menentukan obat yang sesuai, dan memberikan arahan kepada anggota tim lain untuk mendukung perawatan. Peran dokter sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan medis yang digunakan relevan dan berbasis bukti (Busari et al., 2017).

Selain itu, dokter juga bekerja erat dengan anggota tim lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien ditangani secara menyeluruh. Misalnya, dalam kasus seorang ibu hamil dengan risiko komplikasi, dokter bekerja sama dengan bidan untuk memantau kesehatan ibu dan janin, sementara ahli gizi memberikan saran tentang nutrisi yang diperlukan. Dengan bekerja secara kolaboratif, dokter memastikan bahwa semua kebutuhan pasien terpenuhi tanpa tumpang tindih tugas antarprofesional. Sinergi ini membantu menciptakan perawatan yang lebih terkoordinasi dan efektif (Kurniasih et al., 2022).

Dokter juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Mereka menjelaskan diagnosis, tujuan perawatan, dan prosedur yang akan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam situasi yang kompleks, dokter membantu keluarga memahami pilihan pengobatan yang tersedia dan mendukung mereka dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk pasien. Pendekatan ini menciptakan kepercayaan antara dokter, pasien, dan keluarga, yang merupakan elemen penting dalam keberhasilan perawatan (Belrhiti et al., 2021).

3. Peran Bidan

Bidan memiliki peran spesifik dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Sebagai profesional kesehatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi, bidan bertanggung jawab untuk memberikan perawatan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Mereka memantau kondisi kesehatan ibu dan janin, memberikan panduan tentang kehamilan sehat, serta membantu ibu mempersiapkan diri untuk proses persalinan. Dalam tim kolaborasi, bidan bekerja

erat dengan dokter kandungan untuk menangani kasus-kasus berisiko tinggi dan memastikan keselamatan ibu serta bayi (Nieuwoudt et al., 2021).

Bidan juga memainkan peran penting dalam edukasi keluarga. Mereka memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir, seperti cara menyusui, menjaga kebersihan bayi, dan menangani kondisi umum seperti ruam atau kolik. Selain itu, bidan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada ibu, termasuk perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. Dengan edukasi ini, bidan membantu keluarga memahami cara menjaga kesehatan ibu dan bayi secara optimal, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri (Vaseghi et al., 2022).

Selain peran klinis, bidan juga mendukung kesehatan mental dan emosional ibu. Proses kehamilan dan persalinan sering kali membawa tekanan emosional yang signifikan bagi ibu dan keluarga. Dalam situasi ini, bidan menjadi pendamping yang memberikan dukungan moral, membantu ibu mengatasi ketakutan, dan mendorong mereka untuk tetap positif selama proses persalinan. Peran ini tidak hanya meningkatkan pengalaman persalinan tetapi juga memperkuat hubungan antara bidan, ibu, dan keluarga (Sangaleti et al., 2017).

4. Peran Ahli Gizi

Ahli gizi berkontribusi dalam memastikan bahwa kebutuhan nutrisi pasien dan keluarga terpenuhi. Mereka mengevaluasi status gizi pasien dan merancang rencana makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Sebagai contoh, dalam kasus pasien dengan diabetes, ahli gizi akan mengatur pola makan yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, ahli gizi juga bekerja dengan anggota tim lain untuk memastikan bahwa saran nutrisi mereka mendukung rencana perawatan secara keseluruhan (Djavaruddin et al., 2023).

Selain memberikan konsultasi langsung kepada pasien, ahli gizi juga berperan dalam edukasi keluarga. Mereka membantu keluarga memahami pentingnya pola makan sehat dan cara mempersiapkan makanan yang mendukung proses penyembuhan pasien. Dalam konteks keperawatan keluarga, ahli gizi sering kali mengajarkan keluarga tentang cara mengelola diet bagi anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dengan alergi makanan atau orang tua dengan risiko malnutrisi. Edukasi ini memastikan bahwa keluarga dapat menjalankan peran mereka dalam mendukung perawatan pasien (Marker & Jensen, 2022).

Ahli gizi juga memainkan peran penting dalam pencegahan penyakit. Dengan memberikan edukasi dan intervensi gizi yang tepat, mereka membantu keluarga mengadopsi gaya hidup sehat yang dapat mencegah berbagai kondisi kronis, seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular. Dalam tim kolaborasi, ahli

gizi bekerja secara sinergis dengan dokter dan perawat untuk memastikan bahwa intervensi mereka selaras dengan tujuan kesehatan jangka panjang pasien dan keluarga (Geese & Schmitt, 2023).

5. Peran Psikolog

Psikolog memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental pasien dan keluarga. Dalam tim kolaborasi, psikolog membantu keluarga menghadapi tekanan emosional yang mungkin timbul akibat kondisi medis yang serius, seperti penyakit kronis atau terminal. Mereka memberikan konseling individu atau keluarga untuk membantu mengelola kecemasan, stres, atau depresi. Sebagai contoh, dalam kasus pasien kanker, psikolog bekerja untuk membantu pasien dan keluarganya menerima kondisi tersebut dan mengembangkan mekanisme koping yang sehat. Dengan dukungan ini, psikolog memastikan bahwa aspek psikologis dari perawatan tidak diabaikan (Rosen et al., 2018).

Selain memberikan konseling, psikolog juga membantu keluarga memahami dinamika emosi yang terjadi dalam situasi sulit. Mereka mengevaluasi hubungan antaranggota keluarga dan membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul akibat tekanan situasi. Misalnya, ketika seorang anak menderita penyakit serius, psikolog dapat membantu orang tua mengatasi perasaan bersalah atau ketegangan yang mungkin muncul. Dengan intervensi ini, psikolog mendukung stabilitas emosional keluarga sehingga mereka dapat fokus pada perawatan pasien (Sørensen et al., 2020).

Psikolog juga berperan dalam memberikan edukasi kepada anggota tim lainnya tentang pentingnya mempertimbangkan kesehatan mental dalam perawatan pasien. Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana stres atau gangguan emosional dapat memengaruhi proses pemulihan fisik. Dalam tim kolaborasi, psikolog bekerja dengan perawat, dokter, dan anggota tim lainnya untuk merancang pendekatan perawatan yang memperhitungkan kesejahteraan mental pasien dan keluarganya. Sinergi ini menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh (Geese & Schmitt, 2023).

6. Peran Apoteker

Apoteker memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan obat dalam perawatan pasien. Dalam tim kolaborasi, apoteker memberikan saran tentang pilihan obat, dosis yang sesuai, dan potensi interaksi obat yang dapat memengaruhi hasil perawatan. Misalnya, dalam kasus pasien yang menggunakan beberapa obat untuk kondisi kronis, apoteker membantu dokter dan perawat memahami risiko interaksi obat dan memberikan

rekomendasi untuk mencegah efek samping. Peran ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan pengobatan (Fusco & Ohtake, 2019).

Selain itu, apoteker juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara menggunakan obat dengan benar. Mereka menjelaskan waktu, dosis, dan metode pemberian obat, serta memberikan informasi tentang efek samping yang perlu diwaspadai. Dalam situasi kompleks, seperti terapi kanker, apoteker bekerja erat dengan keluarga untuk memastikan bahwa pasien menerima pengobatan dengan cara yang aman dan efektif. Edukasi ini meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan mendukung proses penyembuhan (Rathbone et al., 2016).

Apoteker juga bekerja dengan anggota tim lainnya untuk mengembangkan rencana perawatan yang berbasis obat. Misalnya, mereka dapat berkontribusi pada manajemen nyeri dengan menyarankan kombinasi obat yang paling efektif. Dalam tim kolaborasi, apoteker menjadi mitra penting yang memastikan bahwa semua aspek farmakologis dari perawatan berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, apoteker membantu menciptakan proses perawatan yang lebih terintegrasi (Ramji et al., 2020).

7. Peran Fisioterapis

Fisioterapis bertanggung jawab untuk membantu pasien memulihkan mobilitas dan fungsi fisik mereka setelah cedera, operasi, atau penyakit. Dalam tim kolaborasi, fisioterapis bekerja dengan dokter dan perawat untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya, pasien pascaoperasi tulang dapat menerima terapi fisik untuk mengembalikan kekuatan otot dan rentang gerak. Dengan intervensi yang dirancang secara khusus, fisioterapis membantu pasien meningkatkan kualitas hidup mereka (Sørensen et al., 2020).

Selain memberikan perawatan langsung, fisioterapis juga mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya latihan fisik dalam proses pemulihan. Mereka mengajarkan latihan-latihan yang dapat dilakukan di rumah untuk mendukung rehabilitasi. Dalam konteks keperawatan keluarga, fisioterapis membantu keluarga memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan pasien, seperti membantu pasien dalam latihan atau menciptakan lingkungan rumah yang aman. Edukasi ini memastikan bahwa pasien dapat melanjutkan rehabilitasi dengan dukungan yang memadai (Geese & Schmitt, 2023).

Fisioterapis juga bekerja untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas. Mereka merancang intervensi yang bertujuan untuk mencegah atrofi otot, luka tekan, atau gangguan postur. Dalam

tim kolaborasi, fisioterapis bekerja bersama anggota tim lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan fisik pasien diperhatikan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, fisioterapis membantu pasien mencapai pemulihan yang optimal.

8. Peran Petugas Kesehatan Masyarakat

Petugas kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani layanan kesehatan dengan komunitas. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa keluarga dan komunitas menerima akses yang memadai ke informasi, sumber daya, dan layanan kesehatan. Dalam tim kolaborasi, petugas kesehatan masyarakat mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat, memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit, dan menghubungkan keluarga dengan program kesehatan yang relevan. Misalnya, dalam kasus keluarga yang menghadapi masalah gizi, petugas kesehatan masyarakat dapat mengarahkan mereka ke program bantuan makanan atau layanan ahli gizi (Watanabe et al., 2023).

Selain memberikan edukasi kesehatan, petugas kesehatan masyarakat juga bertanggung jawab untuk mendorong perubahan perilaku yang mendukung gaya hidup sehat. Mereka mengedukasi keluarga tentang pentingnya imunisasi, pola makan sehat, dan kebiasaan hidup bersih. Dalam keperawatan keluarga, petugas kesehatan masyarakat sering kali memberikan pelatihan dasar kepada anggota keluarga tentang pengelolaan kesehatan di rumah, seperti teknik mencuci tangan yang benar atau cara menangani penyakit menular. Dengan pendekatan ini, mereka membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mencegah penyebaran penyakit dalam komunitas (Rosen et al., 2018).

Petugas kesehatan masyarakat juga berperan dalam mengidentifikasi faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan keluarga. Mereka bekerja untuk mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, seperti sanitasi yang buruk atau polusi udara. Dalam tim kolaborasi, mereka menyampaikan temuan ini kepada anggota tim lainnya, seperti dokter atau perawat, untuk merancang intervensi yang lebih terfokus. Misalnya, mereka dapat bekerja dengan ahli gizi untuk mengatasi masalah gizi buruk yang disebabkan oleh keterbatasan akses ke makanan sehat di komunitas tertentu. Dengan peran ini, petugas kesehatan masyarakat menjadi penggerak penting dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Albassam et al., 2020).

Sinergi antar profesi menjadi landasan utama untuk memberikan asuhan yang holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk mencapai hasil yang optimal bagi pasien dan

keluarganya. Setiap anggota tim kesehatan membawa keahlian dan perspektif unik mereka, yang jika digabungkan dengan baik, menciptakan pendekatan perawatan yang lebih komprehensif dan efisien. Dalam konteks keperawatan keluarga, sinergi ini menjadi semakin penting karena keluarga sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin (Watanabe et al., 2023).

Keberhasilan sinergi antar profesi tidak hanya bergantung pada keahlian teknis masing-masing anggota tim, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam satu tujuan bersama. Komunikasi yang efektif dan pembagian tanggung jawab yang jelas menjadi kunci utama dalam memastikan kebutuhan pasien dan keluarga terpenuhi secara menyeluruh. Dalam hal ini, setiap anggota tim, seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, psikolog, dan fisioterapis, memiliki peran yang saling melengkapi untuk menciptakan perawatan yang terkoordinasi. Pendekatan ini tidak hanya menghindari duplikasi tugas, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan (Rosen et al., 2018).

Pendekatan sinergis juga memberikan manfaat langsung kepada keluarga sebagai penerima layanan. Ketika tim kesehatan bekerja secara harmonis, keluarga merasa lebih percaya diri dan didukung dalam proses perawatan. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan edukasi yang tepat dan keterlibatan yang mendalam, keluarga dapat memainkan peran penting dalam mendukung perawatan pasien di rumah. Pendekatan ini mendorong keberlanjutan perawatan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan (Morgan et al., 2020).

Selain itu, sinergi antar profesi memungkinkan tim kesehatan untuk menangani masalah kesehatan secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Misalnya, pasien dengan penyakit kronis mungkin memerlukan intervensi medis dari dokter, dukungan nutrisi dari ahli gizi, dan terapi rehabilitasi dari fisioterapis. Dalam kasus ini, perawat berperan sebagai koordinator yang memastikan bahwa semua intervensi tersebut berjalan sesuai rencana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan hasil yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan pengalaman pasien dalam menerima perawatan. Sinergi ini dapat membantu tenaga kesehatan untuk:

a. Kolaborasi untuk Diagnosis dan Perawatan

Dalam proses diagnosis, dokter, perawat, dan ahli gizi dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan. Misalnya, jika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan, dokter dapat melakukan evaluasi

medis, sementara ahli gizi mengidentifikasi kekurangan nutrisi, dan perawat memantau pelaksanaan rencana makan. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif (Granrud et al., 2019).

b. Peran Koordinasi dalam Perawatan Berkelanjutan

Perawat sering kali menjadi koordinator dalam memastikan rencana perawatan dilaksanakan dengan baik. Perawat bekerja dengan semua anggota tim untuk mengintegrasikan intervensi yang direkomendasikan. Sebagai contoh, ketika seorang pasien pasca operasi membutuhkan rehabilitasi fisik, perawat akan mengatur jadwal terapi dengan fisioterapis dan memantau kemajuan pasien (Morgan et al., 2020).

c. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga

Anggota tim kolaborasi bersama-sama memberikan edukasi kepada keluarga untuk mendukung perawatan di rumah. Misalnya, bidan memberikan panduan perawatan bayi, ahli gizi memberikan rekomendasi makanan, dan apoteker memberikan informasi tentang pengobatan. Edukasi ini memberdayakan keluarga untuk menjadi mitra aktif dalam perawatan (Watanabe et al., 2023).

d. Pendekatan Psikososial yang Terpadu

Psikolog, pekerja sosial, dan perawat bekerja sama untuk mendukung kesehatan mental keluarga. Ketika sebuah keluarga menghadapi penyakit kronis, mereka mungkin mengalami tekanan emosional yang membutuhkan intervensi psikososial. Dengan bekerja bersama, tim ini memastikan bahwa keluarga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi stress (Quek et al., 2022).

e. Pemantauan dan Evaluasi Bersama

Pemantauan kemajuan pasien dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim. Setiap profesional memberikan masukan berdasarkan keahlian mereka untuk mengevaluasi apakah rencana perawatan berjalan dengan baik. Proses ini memastikan bahwa jika ada hambatan, tim dapat segera mengambil langkah koreksi (Sørensen et al., 2020).

G. Perawat sebagai Pemimpin dalam Perawatan Berbasis Tim

Dalam dunia pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, peran perawat tidak lagi terbatas pada memberikan perawatan langsung kepada pasien. Perawat kini berfungsi sebagai pemimpin dalam perawatan berbasis tim, dengan tanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memastikan keberhasilan kolaborasi antarprofesional. Sebagai penghubung utama antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, perawat memainkan peran sentral dalam menciptakan

perawatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Bab ini akan mengeksplorasi peran perawat sebagai pemimpin, keterampilan yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas perawatan (Sørensen et al., 2020).

1. Perawat Sebagai Pemimpin: Sebuah Perspektif Modern

Dalam perawatan berbasis tim, perawat dianggap sebagai pemimpin yang mengintegrasikan berbagai elemen perawatan untuk memastikan hasil yang optimal bagi pasien. Sebagai pemimpin, perawat bertugas untuk mengoordinasikan anggota tim, memastikan komunikasi yang efektif, dan menjamin bahwa semua intervensi berjalan sesuai rencana. Peran ini tidak hanya memerlukan pengetahuan klinis yang mendalam tetapi juga keterampilan manajemen, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang kuat. Dalam tim kolaborasi, perawat menjadi figur yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan bersama (García-Sierra & Fernández-Castro, 2018).

Sebagai pemimpin, perawat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien dan keluarga terpenuhi. Mereka mendengarkan kekhawatiran pasien, memberikan edukasi, dan memastikan bahwa pasien serta keluarga terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Peran ini memperkuat kepercayaan pasien terhadap tim kesehatan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam perawatan. Dengan pendekatan ini, perawat tidak hanya menjadi pelaksana perawatan tetapi juga agen perubahan yang mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan (Nieuwoudt et al., 2021).

2. Keterampilan yang Dibutuhkan Perawat Sebagai Pemimpin

Untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam perawatan berbasis tim, perawat membutuhkan sejumlah keterampilan khusus. Pertama, keterampilan komunikasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan tepat kepada semua anggota tim. Perawat harus mampu menjembatani perbedaan pandangan di antara anggota tim dan menciptakan dialog yang konstruktif. Selain itu, kemampuan manajemen konflik menjadi penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau ketegangan yang mungkin muncul dalam tim (Sørensen et al., 2020).

Keterampilan pengambilan keputusan juga merupakan elemen penting dalam kepemimpinan perawat. Dalam situasi darurat, perawat sering kali harus membuat keputusan cepat berdasarkan informasi yang tersedia. Selain itu, kemampuan koordinasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara sinkron. Perawat juga perlu memiliki empati yang mendalam untuk memahami kebutuhan pasien dan keluarga, serta kemampuan edukasi untuk memberdayakan mereka sebagai mitra aktif dalam perawatan (Nieuwoudt et al., 2021).

3. Peran Perawat dalam Meningkatkan Sinergi Tim

Sebagai pemimpin, perawat berperan dalam menciptakan sinergi di antara anggota tim kesehatan. Perawat memfasilitasi rapat tim untuk membahas perkembangan pasien, mengevaluasi intervensi, dan menyusun rencana perawatan yang lebih baik. Dalam peran ini, perawat memastikan bahwa semua suara dalam tim didengar dan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Dengan mempromosikan kolaborasi yang inklusif, perawat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif (Nieuwoudt et al., 2021).

Perawat juga menjadi penjamin komunikasi lintas disiplin. Mereka memastikan bahwa informasi penting tentang pasien disampaikan kepada dokter, fisioterapis, ahli gizi, atau anggota tim lainnya secara jelas dan tepat waktu. Peran ini membantu mencegah duplikasi tugas, kesalahan, atau keterlambatan dalam perawatan. Dengan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan pasien, perawat membantu menciptakan perawatan yang lebih terkoordinasi dan efektif (Stucky et al., 2022).

4. Tantangan yang Dihadapi Perawat Sebagai Pemimpin

Meskipun peran perawat sebagai pemimpin membawa banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah hierarki dalam tim kesehatan, di mana dokter sering kali dianggap sebagai pemimpin utama. Hal ini dapat menghambat perawat untuk menjalankan peran kepemimpinan mereka secara penuh. Selain itu, kurangnya pelatihan formal dalam kepemimpinan juga menjadi hambatan bagi banyak perawat untuk mengembangkan keterampilan manajemen yang diperlukan (Kurniasih et al., 2022).

Tantangan lainnya adalah beban kerja yang tinggi yang sering kali membatasi waktu perawat untuk fokus pada tugas kepemimpinan. Dalam banyak kasus, perawat harus menangani tanggung jawab klinis dan administratif sekaligus, yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Selain itu, kurangnya pengakuan terhadap peran perawat sebagai pemimpin juga dapat mengurangi motivasi mereka untuk mengambil inisiatif dalam tim (Stucky et al., 2022).

5. Dampak Kepemimpinan Perawat terhadap Kualitas Perawatan

Peran kepemimpinan perawat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas perawatan. Ketika perawat mampu memimpin dengan efektif, tim kesehatan cenderung bekerja lebih efisien dan harmonis. Hal ini berujung pada hasil perawatan yang lebih baik, termasuk peningkatan kepuasan pasien, pengurangan tingkat kesalahan medis, dan perawatan yang lebih terkoordinasi. Dalam keperawatan keluarga, perawat sebagai pemimpin membantu

memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa didukung dan dilibatkan dalam proses perawatan (Orchard et al., 2017a).

Selain itu, kepemimpinan perawat juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja di antara anggota tim. Ketika perawat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, anggota tim merasa lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan kepemimpinan yang kuat, perawat tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan berkelanjutan (Ernawati, 2020).

H. Tantangan Kolaborasi Interprofessional dalam Keperawatan Keluarga

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk memberikan asuhan yang holistik dan terintegrasi dalam keperawatan keluarga. Namun, penerapan pendekatan ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan sering kali muncul, mulai dari kendala komunikasi hingga perbedaan persepsi antarprofesi.

1. Tantangan dalam Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kolaborasi interprofesional, tetapi sering kali menjadi salah satu tantangan terbesar. Hambatan komunikasi dapat muncul dalam bentuk kurangnya transparansi, penggunaan jargon teknis yang tidak dimengerti oleh semua pihak, atau informasi yang tidak disampaikan dengan jelas. Dalam keperawatan keluarga, masalah komunikasi dapat menghambat pemahaman bersama tentang rencana perawatan, yang pada akhirnya memengaruhi hasil kesehatan pasien (Keshmiri, 2021).

Selain itu, perbedaan cara komunikasi antarprofesi juga menjadi kendala. Misalnya, dokter cenderung menggunakan pendekatan klinis yang berbasis data, sedangkan perawat sering kali berfokus pada aspek emosional dan praktis dalam perawatan. Ketidakefahaman ini dapat menyebabkan miskomunikasi, yang berpotensi memengaruhi koordinasi tim. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan komunikasi lintas profesi yang baik untuk memastikan kolaborasi berjalan lancar (van Staalduinen et al., 2023).

2. Hierarki dan Perbedaan Peran

Hierarki yang kaku dalam tim kesehatan sering kali menjadi penghalang bagi kolaborasi yang efektif. Dalam banyak kasus, dokter dianggap sebagai pemimpin utama, sementara perawat dan profesional lainnya dipandang sebagai pendukung. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang menghambat anggota tim untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Dalam keperawatan keluarga, hierarki ini dapat mengurangi efektivitas tim dalam memberikan perawatan yang komprehensif (Junge-Maughan et al., 2021).

Perbedaan peran dan tanggung jawab antarprofesi juga dapat menyebabkan kebingungan. Ketika peran tidak didefinisikan dengan jelas, risiko tumpang tindih tugas atau bahkan pengabaian tanggung jawab menjadi lebih tinggi. Misalnya, ahli gizi mungkin tidak dilibatkan dalam diskusi tentang rencana makan pasien, meskipun perannya sangat penting. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kejelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab di dalam tim (Bollen et al., 2019).

3. Kurangnya Pemahaman Tentang Konsep Kolaborasi

Tidak semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kolaborasi interprofesional. Beberapa profesional kesehatan mungkin merasa bahwa pendekatan ini tidak relevan atau tidak memiliki dampak langsung pada hasil perawatan. Pandangan ini sering kali muncul karena kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam bekerja secara kolaboratif. Dalam konteks keperawatan keluarga, kurangnya pemahaman ini dapat menghambat sinergi antarprofesional dalam menangani masalah kesehatan yang kompleks (Davidson et al., 2022).

Selain itu, perbedaan budaya kerja di antara profesi juga menjadi tantangan. Misalnya, perawat dan pekerja sosial mungkin memiliki pendekatan yang lebih berpusat pada pasien, sementara dokter lebih berfokus pada aspek medis. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan konflik yang menghambat kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi tentang konsep kolaborasi kepada semua anggota tim (Busari et al., 2017).

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun teknologi, juga menjadi tantangan besar dalam kolaborasi interprofesional. Anggota tim sering kali memiliki jadwal yang padat, sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk rapat tim atau diskusi kasus. Selain itu, beban kerja yang tinggi dapat mengurangi kemampuan tenaga kesehatan untuk berfokus pada aspek kolaborasi (Hinyard et al., 2018).

Teknologi yang kurang memadai juga dapat menjadi kendala dalam berbagi informasi. Misalnya, sistem rekam medis elektronik yang tidak terintegrasi membuat anggota tim kesulitan mengakses data pasien yang relevan. Dalam situasi ini, informasi penting mungkin terlewatkan, yang dapat memengaruhi kualitas perawatan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan alokasi sumber daya yang lebih baik diperlukan untuk mendukung kolaborasi yang efektif (Findyartini et al., 2019).

5. Hambatan Psikososial dan Budaya

Hambatan psikososial, seperti kurangnya kepercayaan di antara anggota tim, juga dapat menghambat kolaborasi interprofesional. Ketidakpercayaan ini sering kali muncul akibat pengalaman negatif di masa lalu atau stereotip tentang profesi tertentu. Dalam keperawatan keluarga, kurangnya kepercayaan ini dapat memengaruhi hubungan antara anggota tim dan keluarga, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas perawatan (Findyartini et al., 2019).

Selain itu, perbedaan budaya, baik budaya organisasi maupun budaya individu, juga dapat menjadi tantangan. Misalnya, anggota tim dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang cara mendekati masalah kesehatan. Perbedaan ini dapat memengaruhi komunikasi dan koordinasi dalam tim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya untuk mengatasi hambatan ini (Fewster-Thuente & Velsor-Friedrich, 2008).

I. Referensi

- Albassam, A., Almohammed, H., Alhujaili, M., Koshy, S., & Awad, A. (2020). Perspectives of primary care physicians and pharmacists on interprofessional collaboration in Kuwait: A quantitative study. *PloS one*, 15(7), e0236114. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236114>
- Bailey, J. J., Sabbagh, M., Loiselle, C. G., Boileau, J., & McVey, L. (2010). Supporting families in the ICU: a descriptive correlational study of informational support, anxiety, and satisfaction with care. *Intensive Crit Care Nurs*, 26(2), 114-122. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2009.12.006>
- Belrhiti, Z., Van Belle, S., & Criel, B. (2021). How medical dominance and interprofessional conflicts undermine patient-centred care in hospitals: historical analysis and multiple embedded case study in Morocco. *BMJ Glob Health*, 6(7), e006140. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006140>
- Bollen, A., Harrison, R., Aslani, P., & van Haastregt, J. C. M. (2019). Factors influencing interprofessional collaboration between community pharmacists and general practitioners-A systematic review. *Health Soc Care Community*, 27(4), e189-e212. <https://doi.org/10.1111/hsc.12705>
- Bornman, J., & Louw, B. (2023). Leadership development strategies in interprofessional healthcare collaboration: A rapid review. *J Healthc Leadersh*, 15, 175-192. <https://doi.org/10.2147/jhl.S405983>
- Busari, J. O., Moll, F. M., & Duits, A. J. (2017). Understanding the impact of interprofessional collaboration on the quality of care: A case report from a small-scale resource limited health care environment. *J Multidiscip Healthc*, 10, 227-234. <https://doi.org/10.2147/jmdh.S140042>

- Cacchione, P. Z. (2020). Innovative care models across settings: Providing nursing care to older adults. *Geriatr Nurs*, 41(1), 16-20. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.01.011>
- Campos, C. G., Mantovani Mde, F., Nascimento, M. E., & Cassi, C. C. (2015). Social representations of illness among people with chronic kidney disease. *Rev Gaucha Enferm*, 36(2), 106-112. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.02.48183> (Representações sociais sobre o adoecimento de pessoas com doença renal crônica.)
- Carron, T., Rawlinson, C., Arditi, C., Cohidon, C., Hong, Q. N., Pluye, P., . . . Peytremann-Bridevaux, I. (2021). An overview of reviews on interprofessional collaboration in primary care: Effectiveness. *Int J Integr Care*, 21(2), 31. <https://doi.org/10.5334/ijic.5588>
- Dahlke, S., Hunter, K. F., Reshef Kalogirou, M., Negrin, K., Fox, M., & Wagg, A. (2020). Perspectives about Interprofessional Collaboration and Patient-Centred Care. *Can J Aging*, 39(3), 443-455. <https://doi.org/10.1017/s0714980819000539>
- Davidson, A. R., Kelly, J., Ball, L., Morgan, M., & Reidlinger, D. P. (2022). What do patients experience? Interprofessional collaborative practice for chronic conditions in primary care: An integrative review. *BMC Prim Care*, 23(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s12875-021-01595-6>
- Diriba, C. D., Leung, D., & Suen, L. K. P. (2021). A nurse-led, community-based self management program for people living with type 2 diabetes in Western Ethiopia: A feasibility and pilot study protocol. *Diabet Med*, 38(8), e14587. <https://doi.org/10.1111/dme.14587>
- Djaharuddin, I., Aras, I., Masadah, R., Yusuf, I., Idris, I., Rasyid, H., & Nelwan, B. (2023). Factors influencing the implementation of interprofessional collaborative practice in teaching hospital setting: A mixed-method study. *J Adv Med Educ Prof*, 11(4), 213-221. <https://doi.org/10.30476/jamp.2023.98987.1821>
- Ernawati, D. K. (2020). Collaborative competencies in public health center in Indonesia: An explorative study. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 18, 100299. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xjep.2019.100299>
- Fewster-Thuente, L., & Velsor-Friedrich, B. (2008). Interdisciplinary collaboration for healthcare professionals. *Nurs Adm Q*, 32(1), 40-48. <https://doi.org/10.1097/01.Naq.0000305946.31193.61>
- Findyartini, A., Kambey, D. R., Yusra, R. Y., Timor, A. B., Khairani, C. D., Setyorini, D., & Soemantri, D. (2019). Interprofessional collaborative practice in primary healthcare settings in Indonesia: A mixed-methods study. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 17, 100279. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2019.100279>
- Folkman, A. K., Tveit, B., & Sverdrup, S. (2019). Leadership in interprofessional collaboration in health care. *J Multidiscip Healthc*, 12, 97-107. <https://doi.org/10.2147/jmdh.S189199>

- Friedman, M. M., & Bowden, V. R. (2010). *Family nursing textbook: Research, theory, and practice*. EGC.
- Fusco, N. M., & Ohtake, P. J. (2019). Training the trainers: A preceptor development program targeting interprofessional collaboration competencies. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 11(11), 1138-1143. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2019.07.007>
- García-Sierra, R., & Fernández-Castro, J. (2018). Relationships between leadership, structural empowerment, and engagement in nurses. *J Adv Nurs*, 74(12), 2809-2819. <https://doi.org/10.1111/jan.13805>
- Geese, F., & Schmitt, K. U. (2023). Interprofessional collaboration in complex patient care transition: A qualitative multi-perspective analysis. *Healthcare (Basel)*, 11(3), 359. <https://doi.org/10.3390/healthcare11030359>
- Granrud, M. D., Anderzèn-Carlsson, A., Bisholt, B., & Steffenak, A. K. M. (2019). Public health nurses' perceptions of interprofessional collaboration related to adolescents' mental health problems in secondary schools: A phenomenographic study. *J Clin Nurs*, 28(15-16), 2899-2910. <https://doi.org/10.1111/jocn.14881>
- Gullick, J., Lin, F., Massey, D., Wilson, L., Greenwood, M., Skylas, K., . . . Gill, F. J. (2019). Structures, processes and outcomes of specialist critical care nurse education: An integrative review. *Aust Crit Care*, 32(4), 331-345. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2018.09.007>
- Hellman, T., Jensen, I., Orchard, C., & Bergström, G. (2016). Preliminary testing of the Swedish version of the Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS-S). *J Interprof Care*, 30(4), 499-504. <https://doi.org/10.3109/13561820.2016.1159184>
- Hinyard, L., Toomey, E., Eliot, K., & Breitbach, A. (2018). Student Perceptions of Collaboration Skills in an Interprofessional Context: Development and Initial Validation of the Self-Assessed Collaboration Skills Instrument. *Evaluation & the Health Professions*, 42(4), 450-472. <https://doi.org/10.1177/0163278717752438>
- Hoffman, J. L., & Cowdery, J. E. (2021). Interprofessional Collaboration in Public Health. *Nurs Educ Perspect*, 42(1), 46-48. <https://doi.org/10.1097/01.Nep.0000000000000591>
- Hunter, J., Majd, I., Kowalski, M., & Harnett, J. E. (2021). Interprofessional Communication—A Call for More Education to Ensure Cultural Competency in the Context of Traditional, Complementary, and Integrative Medicine. *Global Advances in Health and Medicine*, 10, 1-5. <https://doi.org/10.1177/21649561211014107>
- Iguñiz-Romero, R., & Guerra-Reyes, L. (2020). On the front line: Health professionals and system preparedness for Zika virus in Peru. *Int J Gynaecol Obstet*, 148 Suppl 2(Suppl 2), 45-54. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13047>

- Interprofessional Education Collaborative. (2023). *IPEC core competencies for interprofessional collaborative practice: Version 3*. Interprofessional Education Collaborative.
- Junge-Maughan, L., Moore, A., & Lipsitz, L. (2021). Key strategies for improving transitions of care collaboration: lessons from the ECHO-care transitions program. *J Interprof Care*, 35(4), 633-636. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1798900>
- Karam, M., Macq, J., Duchesnes, C., Crismer, A., & Belche, J. L. (2022). Interprofessional collaboration between general practitioners and primary care nurses in Belgium: a participatory action research. *J Interprof Care*, 36(3), 380-389. <https://doi.org/10.1080/13561820.2021.1929878>
- Kenaszchuk, C., Reeves, S., Nicholas, D., & Zwarenstein, M. (2010). Validity and reliability of a multiple-group measurement scale for interprofessional collaboration. *BMC Health Services Research*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-83>
- Keshmiri, F. (2021). Relationship between Self-efficacy and Attitudes towards Interprofessional Collaboration and Communication in Learners of Different Disciplines of Medical Sciences. *Strides in Development of Medical Education*, 18(1), 1-8. <https://doi.org/10.22062/sdme.2020.193866.1015>
- Kurniasih, D. A. A., Setiawati, E. P., Pradipta, I. S., & Subarnas, A. (2022). Interprofessional collaboration in the breast cancer unit: how do healthcare workers see it? *BMC Womens Health*, 22(1), 227. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01818-7>
- Kurniasih, T., Bunga, A. L., & Suparadi, S. (2024). A study on the effectiveness of interprofessional collaborative training in enhancing interprofessional communication and teamwork among nurses at X hospital Jakarta. *Asian Journal of Healthy and Science*, 3(2), 63-70. <https://doi.org/10.58631/ajhs.v3i2.98>
- Lalonde, L., Goudreau, J., Hudon, É., Lussier, M. T., Bareil, C., Duhamel, F., . . . Lalonde, G. (2014). Development of an interprofessional program for cardiovascular prevention in primary care: A participatory research approach. *SAGE open medicine*, 2(2050312114522788), 1-11. <https://doi.org/10.1177/2050312114522788>
- Marker, M. S., & Jensen, H. I. (2022). Interprofessional collaboration regarding nutrition intervention for the frail elderly in the discharge process from hospital to home – A qualitative study. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 29(100580), 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2022.100580>
- Martin, A. K., Green, T. L., McCarthy, A. L., Sowa, P. M., & Laakso, E. L. (2022). Healthcare Teams: Terminology, Confusion, and Ramifications. *J Multidiscip Healthc*, 15, 765-772. <https://doi.org/10.2147/jmdh.S342197>
- Mathur, A. G., Chan, K., & Kalluri, M. (2022). Patient-centered care and interprofessional collaboration in medical resident education: Where we stand

- and where we need to go. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 206. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01221-5>
- Morgan, K., Barroso, C. S., Bateman, S., Dixon, M., & Brown, K. C. (2020). Patients' Experiences of Interprofessional Collaborative Practice in Primary Care: A Scoping Review of the Literature. *Journal of Patient Experience*, 7(6), 1466-1475. <https://doi.org/10.1177/2374373520925725>
- Morgan, S., Pullon, S., & McKinlay, E. (2015). Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review. *Int J Nurs Stud*, 52(7), 1217-1230. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.008>
- Nieuwoudt, L., Hutchinson, A., & Nicholson, P. (2021). Pre-registration nursing and occupational therapy students' experience of interprofessional simulation training designed to develop communication and team-work skills: A mixed methods study. *Nurse Educ Pract*, 53, 103073. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103073>
- Norris, J., Carpenter, J. G., Eaton, J., Guo, J. W., Lassche, M., Pett, M. A., & Blumenthal, D. K. (2015). The development and validation of the interprofessional attitudes scale: Assessing the interprofessional attitudes of students in the health professions. *Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges*, 90(10), 1394-1400. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000000764>
- Nurchis, M. C., Sessa, G., Pascucci, D., Sassano, M., Lombi, L., & Damiani, G. (2022). Interprofessional collaboration and diabetes management in primary care: A systematic review and meta-analysis of patient-reported outcomes. *J Pers Med*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/jpm12040643>
- Orchard, Pederson, L. L., Read, E., Mahler, C., & Laschinger, H. (2018). Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS): Further testing and instrument revision. *J Contin Educ Health Prof*, 38(1), 11-18. <https://doi.org/10.1097/ceh.0000000000000193>
- Orchard, C. A., Sonibare, O., Morse, A., Collins, J., & Al-Hamad, A. (2017a). Collaborative leadership, Part 1: The nurse leader's role within interprofessional teams. *Nurs Leadersh (Tor Ont)*, 30(2), 14-25. <https://doi.org/10.12927/cjnl.2017.25258>
- Orchard, C. A., Sonibare, O., Morse, A., Collins, J., & Al-Hamad, A. (2017b). Collaborative leadership, Part 2: The role of the nurse leader in interprofessional team-based practice - shifting from task- to collaborative patient-/family-focused care. *Nurs Leadersh (Tor Ont)*, 30(2), 26-38. <https://doi.org/10.12927/cjnl.2017.25257>
- Potthoff, M., Kirkpatrick, A. J., & Jizba, T. A. (2023). Interprofessional primary palliative care: Do the AACN Essentials prepare nurses for collaborative practice? *Journal of Professional Nursing*, 46, 197-204. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.03.017>

- Quek, G. S. M., Kwan, Y. H., Chan, C. Q. H., Phang, J. K., & Low, L. L. (2022). Validation of the Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) to assess the degree of inter-professional collaboration (IPC) in a Community Hospital in Singapore. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 27, 100504. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xjep.2022.100504>
- Ramji, R., Carlson, E., Brogårdh-Roth, S., Olofsson, A. N., Kottorp, A., & Rämngård, M. (2020). Understanding behavioural changes through community-based participatory research to promote oral health in socially disadvantaged neighbourhoods in Southern Sweden. *BMJ Open*, 10(4), e035732. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035732>
- Rathbone, A. P., Mansoor, S. M., Krass, I., Hamrosi, K., & Aslani, P. (2016). Qualitative study to conceptualise a model of interprofessional collaboration between pharmacists and general practitioners to support patients' adherence to medication [Article]. *BMJ Open*, 6(3), Article e010488. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010488>
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *Am Psychol*, 73(4), 433-450. <https://doi.org/10.1037/amp0000298>
- Sakai, I., Yamamoto, T., Takahashi, Y., Maeda, T., Kunii, Y., & Kurokochi, K. (2017). Development of a new measurement scale for interprofessional collaborative competency: The Chiba Interprofessional Competency Scale (CICS29). *J Interprof Care*, 31(1), 59-65. <https://doi.org/10.1080/13561820.2016.1233943>
- Sangaleti, C., Schweitzer, M. C., Peduzzi, M., Zoboli, E., & Soares, C. B. (2017). Experiences and shared meaning of teamwork and interprofessional collaboration among health care professionals in primary health care settings: A systematic review. *JBI Database System Rev Implement Rep*, 15(11), 2723-2788. <https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2016-003016>
- Santschi, V., Wuerzner, G., Pais, B., Chiolerio, A., Schaller, P., Cloutier, L., . . . Burnier, M. (2021). Team-based care for improving hypertension management: A pragmatic randomized controlled trial. *Front Cardiovasc Med*, 8, 760662. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.760662>
- Sekanina, U., Tetzlaff, B., Mazur, A., Huckle, T., Kühn, A., Dano, R., . . . Müller, C. (2024). Interprofessional collaboration in the home care setting: perspectives of people receiving home care, relatives, nurses, general practitioners, and therapists-results of a qualitative analysis. *BMC Prim Care*, 25(1), 79. <https://doi.org/10.1186/s12875-024-02313-8>
- Sigmon, L. B., Reis, P. J., Woodard, E. K., & Hinkle, J. F. (2023). Patient and family perceptions of interprofessional collaborative teamwork: An integrative review. *J Clin Nurs*, 32(9-10), 2102-2113. <https://doi.org/10.1111/jocn.16295>
- Sirimsi, M. M., Loof, H. D., Broeck, K. V. d., Vliegheer, K. D., Pype, P., Remmen, R., & Bogaert, P. V. (2022). Scoping review to identify strategies and interventions

- improving interprofessional collaboration and integration in primary care. *BMJ Open*, 12(10), e062111. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062111>
- Sittner, B. J., Hudson, D. B., & Defrain, J. (2007). Using the concept of family strengths to enhance nursing care. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 32(6), 353-357. <https://doi.org/10.1097/01.nmc.0000298130.16914.47>
- Slater, C. E., Keefe, B., & Jacobs, K. (2023). Impact of the interprofessional leadership in healthcare certificate on health professionals' collaboration and leadership abilities. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 32, 100658. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2023.100658>
- Sockalingam, S., Rajaratnam, T., Gambin, A., Soklaridis, S., Serhal, E., & Crawford, A. (2022). Interprofessional continuing professional development programs can foster lifelong learning in healthcare professionals: experiences from the Project ECHO model. *BMC Medical Education*, 22(1), 432. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03500-w>
- Sørensen, M., Groven, K. S., Gjelsvik, B., Almendingen, K., & Garnweidner-Holme, L. (2020). The roles of healthcare professionals in diabetes care: a qualitative study in Norwegian general practice. *Scand J Prim Health Care*, 38(1), 12-23. <https://doi.org/10.1080/02813432.2020.1714145>
- Southerland, J. H., Webster-Cyriaque, J., Bednarsh, H., & Mouton, C. P. (2016). Interprofessional Collaborative Practice Models in Chronic Disease Management. *Dent Clin North Am*, 60(4), 789-809. <https://doi.org/10.1016/j.cden.2016.05.001>
- Stucky, C. H., Wymer, J. A., & House, S. (2022). Nurse Leaders: Transforming Interprofessional Relationships to Bridge Healthcare Quality and Safety. *Nurse Leader*, 20(4), 375-380. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2021.12.003>
- Tang, R., Luo, D., Li, B., Wang, J., & Li, M. (2023). The role of family support in diabetes self-management among rural adult patients. *J Clin Nurs*, 32(19-20), 7238-7246. <https://doi.org/10.1111/jocn.16786>
- van Staalduinen, D. J., van den Bekerom, P. E. A., Groeneveld, S. M., Stiggelbout, A. M., & van den Akker-van Marle, M. E. (2023). Relational coordination in value-based health care. *Health Care Manage Rev*, 48(4), 334-341. <https://doi.org/10.1097/hmr.0000000000000381>
- Vasconcelos, J., Probst, L. F., Silva, J. A. M. d., Costa, M. V. d., Higashijima, M. N. S., Santos, M. L. d. M. d., . . . Carli, A. D. D. (2024). Factors associated with interprofessional collaboration in primary health care: A multilevel analysis. *Cien Saude Colet*, 29(1), e10572022. <https://doi.org/10.1590/1413-81232024291.10572022>
- Vaseghi, F., Yarmohammadian, M. H., & Raeisi, A. (2022). Interprofessional collaboration competencies in the health system: A systematic review. *Iran J Nurs Midwifery Res*, 27(6), 496-504. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_476_21

- Veiga-Seijo, R., Miranda-Duro, M. D. C., & Veiga-Seijo, S. (2022). Strategies and actions to enable meaningful family connections in nursing homes during the COVID-19: A Scoping Review. *Clin Gerontol*, 45(1), 20-30. <https://doi.org/10.1080/07317115.2021.1937424>
- Verspuy, M., & Van Bogaert, P. (2018). Interprofessional collaboration and communication. In *The Organizational Context of Nursing Practice: Concepts, Evidence, and Interventions for Improvement* (pp. 259-278). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71042-6_12
- Waltz, L. A., Barnes, J. N., Crocker, A. F., Doeringer, J. R., Downs, L. T., Maki, Y., . . . Voyce, C. (2023). Implementing a primary care simulation to improve interprofessional competencies. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 33, 100681. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2023.100681>
- Watanabe, F., Kita, K., Kobayashi, N., Kuroiwa, M., Shimizu, Y., Sekijima, A., . . . Son, D. (2023). What was happening in the collaboration between general practitioners and public health nurses in the community: A qualitative study. *J Gen Fam Med*, 24(5), 288-293. <https://doi.org/10.1002/jgf2.637>
- White, D. B., Angus, D. C., Shields, A. M., Buddadhumaruk, P., Pidro, C., Paner, C., . . . Arnold, R. M. (2018). A Randomized Trial of a Family-Support Intervention in Intensive Care Units. *N Engl J Med*, 378(25), 2365-2375. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1802637>
- Wiarsih, W., Sahar, D. J., & Nursasi, A. Y. (2023). A qualitative study: Interprofessional collaboration practice in Indonesian primary healthcare. *Nursing Management*, 54(5S), 13-18. <https://doi.org/10.1097/nmg.0000000000000010>
- Will, K. K., Johnson, M. L., & Lamb, G. (2019). Team-based care and patient satisfaction in the hospital setting: A systematic review. *J Patient Cent Res Rev*, 6(2), 158-171. <https://doi.org/10.17294/2330-0698.1695>
- Zhou, J., Dang, W., Luo, Z., Fan, X., Shi, H., Deng, N., & Xiong, G. (2023). Telenursing needs and influencing factors in patients with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study. *J Clin Nurs*, 32(19-20), 7298-7309. <https://doi.org/10.1111/jocn.16805>

CHAPTER 2

INTERVENSI KEPERAWATAN KELUARGA UNTUK PENYAKIT MENTAL DAN GANGGUAN EMOSIONAL: KOLABORASI LINTAS PROFESI

Imran Yaman S.Kep Ns M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Masalah kesehatan jiwa berupa penyakit mental dan gangguan emosional merupakan tantangan kesehatan global yang semakin meningkat prevalensinya dalam beberapa dekade terakhir. Menurut World Health Organization (WHO), satu dari empat individu di dunia mengalami gangguan mental pada tahap tertentu dalam hidupnya, dan sekitar 450 juta orang di seluruh dunia saat ini menderita gangguan mental yang memerlukan perawatan khusus. Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencatat peningkatan prevalensi gangguan emosional, seperti kecemasan dan depresi, hingga mencapai 9,8%, dibandingkan 6% pada tahun 2013. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan permasalahan kesehatan mental yang berimplikasi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, merupakan pihak yang paling terpengaruh secara langsung oleh munculnya gangguan mental pada salah satu anggotanya. Penyakit mental tidak hanya berdampak terhadap penderita, namun juga mempengaruhi keseimbangan emosional, sosial, ekonomi, dan fungsi peran setiap anggota keluarga. Stigma negatif, kesulitan dalam komunikasi, serta beban psikologis yang dirasakan keluarga sering kali menyebabkan isolasi sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang adekuat. Selain itu, minimnya pemahaman tentang gangguan mental menyebabkan keluarga kurang mampu memberikan dukungan yang efektif bagi anggota yang mengalami gangguan mental dan emosional.

Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam penanganan gangguan mental cenderung bersifat individu dan kurang melibatkan keluarga secara aktif. Padahal, berbagai studi telah membuktikan bahwa keterlibatan aktif keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan, pencegahan kekambuhan, dan peningkatan kualitas hidup pasien dengan gangguan mental. Oleh karena itu, diperlukan sebuah intervensi keperawatan yang secara khusus melibatkan peran serta keluarga sebagai bagian integral dari proses terapi. Untuk mendukung

efektivitas intervensi keluarga ini, pendekatan kolaborasi lintas profesi yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan, seperti perawat, psikolog, psikiater, konselor, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan masyarakat menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

1. Tujuan dan Pentingnya Intervensi Berbasis Keluarga

Tujuan utama dari intervensi keperawatan berbasis keluarga dalam penanganan penyakit mental dan gangguan emosional adalah untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan terapeutik, emosional, dan sosial kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Secara khusus, tujuan dari intervensi ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. **Meningkatkan pemahaman keluarga** mengenai gejala, tanda-tanda, dampak, serta cara penanganan gangguan mental dan emosional yang dialami anggota keluarga.
- b. **Memberdayakan keluarga** agar mampu mengambil peran aktif dalam proses rehabilitasi dan perawatan jangka panjang, termasuk mencegah kekambuhan dan memfasilitasi integrasi sosial pasien.
- c. **Memperbaiki komunikasi dan interaksi keluarga** yang sering kali terganggu akibat beban emosional, stres, dan tekanan psikologis yang terkait dengan gangguan mental anggota keluarga.
- d. **Mengurangi stigma negatif** yang masih melekat kuat dalam masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan mental.
- e. **Mendorong terbentuknya coping positif dan resiliensi keluarga** dalam menghadapi tantangan dan krisis yang muncul akibat penyakit mental dan gangguan emosional.

Intervensi berbasis keluarga sangat penting karena keluarga memiliki potensi besar sebagai sumber daya primer dalam proses penyembuhan pasien dengan gangguan mental. Studi menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan keluarga yang kuat cenderung memiliki tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang minim atau tanpa dukungan keluarga. Dukungan keluarga dapat mengurangi intensitas gejala, mempercepat respons terhadap pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien serta seluruh anggota keluarga. Melibatkan keluarga secara aktif juga membantu mengurangi beban layanan kesehatan, terutama di lingkungan komunitas yang memiliki akses terbatas terhadap layanan spesialis kesehatan jiwa.

Pendekatan intervensi berbasis keluarga yang kolaboratif secara lintas profesi mampu memberikan solusi yang komprehensif dalam menjawab kompleksitas permasalahan gangguan mental dan emosional, sehingga sangat

krusial untuk terus dikembangkan dalam konteks praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan jiwa.

2. Ruang Lingkup Intervensi Keperawatan Keluarga pada Gangguan Mental dan Emosional

Ruang lingkup intervensi keperawatan keluarga dalam konteks penyakit mental dan gangguan emosional mencakup sejumlah aspek yang saling berhubungan dan berorientasi pada peningkatan kapasitas keluarga serta perawatan terpadu pasien, antara lain:

a. Intervensi Psikoedukasi Keluarga

Meliputi pemberian edukasi mendalam kepada keluarga mengenai diagnosis, gejala, penyebab, dampak gangguan mental, serta berbagai alternatif terapi yang tersedia.

b. Pelaksanaan Terapi Keluarga (Family Therapy)

Pengembangan keterampilan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah psikologis, interaksi interpersonal, konflik, serta dinamika keluarga yang menjadi pemicu atau dampak dari gangguan mental anggota keluarga.

c. Konseling dan Pendampingan Emosional Keluarga

Bantuan profesional dalam mendampingi keluarga menghadapi tekanan psikologis, stres, serta perasaan bersalah atau frustrasi akibat beban penyakit mental anggota keluarga.

d. Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Coping Keluarga

Program intervensi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, serta mengelola stres secara konstruktif dan sehat.

e. Manajemen Krisis dalam Keluarga

Intervensi yang berfokus pada cara keluarga menghadapi situasi krisis akut seperti percobaan bunuh diri, gejala psikotik berat, maupun kondisi emosional ekstrem lainnya.

f. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Profesi

Mengintegrasikan pelayanan dari berbagai disiplin ilmu, seperti perawat spesialis kesehatan jiwa, psikolog klinis, psikiater, pekerja sosial, konselor, dan petugas layanan komunitas, demi memastikan intervensi berlangsung secara holistik dan efektif.

g. Monitoring dan Evaluasi Intervensi Keluarga

Pemantauan rutin terhadap perkembangan kondisi pasien dan keluarga serta evaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan.

Dengan memperjelas ruang lingkup intervensi keperawatan berbasis keluarga ini, diharapkan intervensi dapat dilaksanakan secara sistematis,

terstruktur, dan menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kesehatan jiwa pasien serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

B. Konsep Dasar Penyakit Mental dan Gangguan Emosional dalam Keluarga

1. Definisi Penyakit Mental dan Gangguan Emosional

Penyakit mental atau gangguan jiwa adalah serangkaian kondisi yang ditandai oleh perubahan signifikan pada pikiran, perasaan, atau perilaku individu, yang berpengaruh terhadap fungsi sosial, keluarga, pendidikan, atau pekerjaan. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang mampu menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari, produktif secara sosial, serta mampu berkontribusi positif pada lingkungannya. Ketika kondisi ini terganggu, maka individu dapat mengalami penyakit mental atau gangguan emosional.

Gangguan emosional merupakan bagian dari gangguan mental yang secara khusus ditandai dengan adanya ketidakstabilan emosi, seperti kecemasan, depresi, atau perasaan takut yang berlebihan dan menetap. Gangguan emosional dapat menyebabkan individu kesulitan dalam mengelola perasaan, yang kemudian berdampak negatif pada interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan kualitas hidupnya secara umum.

2. Jenis dan Karakteristik Penyakit Mental dan Gangguan Emosional dalam Keluarga

Dalam konteks keluarga, beberapa jenis penyakit mental dan gangguan emosional yang sering ditemui antara lain:

- a. Gangguan Depresi:** Ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, hilangnya energi, perasaan putus asa, serta penurunan fungsi sosial dan pekerjaan. Dalam keluarga, depresi salah satu anggota keluarga sering kali menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan kelelahan emosional bagi anggota keluarga lainnya.
- b. Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder):** Meliputi rasa khawatir yang intens, ketakutan berlebihan, panik, dan gelisah yang menetap serta berlebihan. Anggota keluarga dengan gangguan ini cenderung membutuhkan banyak dukungan emosional dari keluarga, namun sering tidak mendapatkan respons yang memadai karena kurangnya pemahaman dari keluarga.
- c. Gangguan Bipolar:** Ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem dari kondisi mania (euforia berlebihan) ke kondisi depresi yang mendalam. Keluarga sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola perubahan emosional mendadak ini, yang bisa mengakibatkan konflik atau kebingungan dalam interaksi sehari-hari.

d. Skizofrenia dan Gangguan Psikotik Lainnya: Ditandai oleh gangguan dalam berpikir, halusinasi, delusi, dan kesulitan dalam mengenali realitas. Gangguan ini dapat menimbulkan ketakutan, stigma, serta beban emosional dan sosial bagi keluarga.

e. Gangguan Emosi dan Perilaku pada Anak dan Remaja: Seperti ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autisme, gangguan perilaku menentang (oppositional defiant disorder), yang sering memerlukan penanganan khusus dalam keluarga dan mempengaruhi pola pengasuhan serta dinamika interaksi keluarga secara keseluruhan.

3. Dampak Penyakit Mental dan Gangguan Emosional Terhadap Dinamika Keluarga

Gangguan mental dan emosional memiliki dampak signifikan tidak hanya pada individu penderita, tetapi juga terhadap seluruh anggota keluarga. Dampak tersebut meliputi:

a. Dampak Psikologis: Keluarga sering mengalami perasaan cemas, stres, bersalah, atau frustrasi dalam menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan mental. Hal ini bisa memperparah situasi keluarga, menciptakan tekanan emosional yang besar, hingga risiko gangguan mental sekunder pada anggota keluarga lainnya.

b. Dampak Sosial: Stigma sosial terhadap gangguan mental sering menyebabkan keluarga menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga menimbulkan isolasi sosial, keterbatasan jaringan sosial, dan penurunan dukungan sosial yang tersedia.

c. Dampak Ekonomi: Gangguan mental sering memerlukan biaya pengobatan yang tinggi serta mengurangi produktivitas kerja. Keluarga harus menanggung beban finansial akibat biaya perawatan, pengobatan, serta hilangnya pendapatan jika anggota keluarga yang mengalami gangguan mental tidak dapat bekerja.

d. Gangguan Fungsi Keluarga: Gangguan mental pada salah satu anggota keluarga cenderung mengganggu dinamika keluarga secara keseluruhan, seperti peran keluarga yang berubah, beban pengasuhan meningkat, serta konflik antaranggota keluarga yang lebih sering terjadi.

4. Peran Keluarga dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Mental dan Emosional

Keluarga memainkan peran sentral dalam pencegahan, deteksi dini, penanganan, serta pemulihan penyakit mental dan gangguan emosional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan Deteksi Dini:** Keluarga yang memiliki pemahaman yang baik mengenai gangguan mental akan mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan, sehingga intervensi dini dapat segera dilakukan. Dukungan emosional dan sosial yang kuat dari keluarga juga dapat mencegah terjadinya gangguan mental lebih lanjut.
- b. Dukungan Terapeutik:** Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, seperti menyediakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman, membantu dalam pengelolaan obat-obatan, serta mendampingi anggota keluarga dalam menjalani terapi dan rehabilitasi.
- c. Advokasi dan Penghubung Pelayanan Kesehatan:** Keluarga dapat berperan aktif dalam mencari dan menghubungkan individu penderita dengan layanan kesehatan mental yang diperlukan. Mereka juga bisa berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak pasien di masyarakat atau institusi.
- d. Penguatan dan Resiliensi Keluarga:** Dukungan keluarga dapat memperkuat resiliensi individu dalam menghadapi penyakit mental, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola stres, mengurangi stigma, dan memperkuat kohesi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.

5. Pentingnya Pemahaman Keluarga terhadap Penyakit Mental dan Gangguan Emosional

Pemahaman yang baik mengenai penyakit mental sangat penting bagi keluarga, karena:

- a. Mengurangi stigma dan prasangka negatif yang selama ini menghambat pemulihan pasien.
- b. Meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan respons yang positif, adaptif, dan konstruktif terhadap gangguan mental anggota keluarga.
- c. Mengurangi risiko kekambuhan atau munculnya gangguan mental pada anggota keluarga lainnya melalui intervensi dini, edukasi, dan promosi kesehatan mental.
- d. Memperkuat hubungan interpersonal keluarga, yang sangat krusial bagi pemulihan emosional individu yang mengalami gangguan mental.

C. Model Intervensi Keperawatan Keluarga untuk Penyakit Mental dan Gangguan Emosional

1. Model Calgary Family Intervention (CFIM)

- a. Pengertian Model CFIM

Calgary Family Intervention Model (CFIM) adalah model intervensi keperawatan keluarga yang dikembangkan oleh Lorraine M. Wright dan Maureen Leahey. Model ini merupakan pendekatan sistemik yang

menekankan pentingnya memahami keluarga sebagai sebuah sistem interaksi yang dinamis dan kompleks. CFIM berfokus pada upaya menciptakan perubahan positif dalam fungsi keluarga melalui serangkaian intervensi keperawatan yang terstruktur dan bertujuan untuk memperbaiki pola interaksi, persepsi keluarga, serta perilaku yang terkait dengan masalah kesehatan mental dan emosional.

b. Komponen Utama CFIM:

1) Intervensi Kognitif (Cognitive Interventions)

Intervensi kognitif merupakan bagian penting dalam model CFIM yang secara spesifik menargetkan aspek pemahaman, persepsi, dan pola pikir keluarga terhadap gangguan mental dan emosional yang dialami oleh salah satu anggotanya. Dasar intervensi ini adalah keyakinan bahwa pola pikir yang positif dan tepat dari keluarga tentang gangguan mental akan sangat menentukan bagaimana keluarga tersebut dapat mendukung proses pemulihan pasien.

a) Tujuan utama intervensi kognitif:

- Meningkatkan pemahaman keluarga terhadap kondisi gangguan mental, termasuk penyebab, gejala, dan dampaknya.
- Mengoreksi persepsi negatif atau keliru keluarga terkait gangguan mental, yang sering kali menjadi sumber stigma dan diskriminasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- Mengubah pola pikir negatif (misalnya merasa bersalah, malu, atau putus asa) menjadi pemikiran yang lebih realistis dan konstruktif.

b) Contoh intervensi kognitif yang dapat dilakukan:

- Edukasi Terstruktur
Memberikan edukasi intensif mengenai gangguan mental yang spesifik dialami oleh anggota keluarga. Edukasi ini mencakup penjelasan mengenai diagnosis medis, penyebab penyakit (baik biologis, psikologis, maupun sosial), gejala khas, pilihan terapi, serta kemungkinan prognosis atau hasil terapi jangka panjang.
- Diskusi Terbuka dan Konseling Psikoedukasi
Melakukan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan keluarga mengajukan pertanyaan, mengungkapkan keraguan atau ketakutan mereka, serta menerima informasi yang jelas dan valid. Pendekatan ini juga melibatkan pemberian contoh nyata dan studi kasus, sehingga keluarga dapat memahami situasi secara lebih konkrit dan realistis.
- Pengenalan dan Manajemen Stigma

Mengidentifikasi persepsi negatif atau stigma dalam keluarga mengenai gangguan mental, kemudian membantu keluarga menyadari bahwa penyakit mental bukanlah kesalahan individu ataupun keluarga, melainkan kondisi medis yang dapat dikelola. Keluarga juga diajak untuk melihat gangguan mental sebagai tantangan yang dapat dihadapi bersama dengan sikap positif dan terbuka.

2) Intervensi Afektif (Affective Interventions)

Intervensi afektif dalam model CFIM bertujuan untuk membantu keluarga mengelola perasaan, emosi, dan hubungan emosional yang mungkin terganggu akibat adanya gangguan mental dalam keluarga. Fokus intervensi ini adalah meningkatkan kualitas hubungan emosional keluarga agar menjadi lebih positif, mendukung, serta menurunkan tingkat stres emosional.

a) Tujuan utama intervensi afektif:

- Mengurangi stres, kecemasan, ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, atau perasaan negatif lainnya yang dialami oleh anggota keluarga.
- Meningkatkan ekspresi emosional positif seperti empati, kasih sayang, rasa saling percaya, dan saling menghargai antar anggota keluarga.
- Menciptakan suasana keluarga yang suportif secara emosional untuk mendukung proses pemulihan pasien.

b) Contoh intervensi afektif yang dapat dilakukan:

• Sesi Konseling Keluarga

Melaksanakan sesi konseling bersama seluruh anggota keluarga untuk memberikan kesempatan kepada mereka dalam mengungkapkan perasaan terpendam secara terbuka dalam suasana yang aman dan tanpa dihakimi. Hal ini membantu mengurangi beban emosional yang dialami keluarga.

• Diskusi Dampak Emosional

Mengadakan diskusi khusus yang membahas dampak emosional yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga akibat gangguan mental anggota keluarga yang sakit, sehingga memupuk pengertian dan toleransi antar anggota keluarga.

• Pelatihan Emotional Support

Mengajarkan keluarga cara memberikan dukungan emosional yang efektif, seperti mengungkapkan rasa peduli, empati, mendengarkan secara aktif, serta memberikan penguatan positif.

3) Intervensi Perilaku (Behavioral Interventions)

Intervensi perilaku dalam model CFIM adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan nyata pada perilaku keluarga yang bisa diamati dan berdampak langsung pada pemulihan pasien yang mengalami gangguan mental. Pendekatan ini membantu keluarga mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan mental.

a) Tujuan utama intervensi perilaku:

- Membentuk pola perilaku positif yang konsisten dalam mendukung anggota keluarga yang mengalami gangguan mental.
- Mengurangi perilaku negatif atau maladaptif dalam keluarga yang memperburuk kondisi mental pasien.
- Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola situasi stres atau konflik yang berkaitan dengan kondisi mental anggota keluarga.

b) Contoh intervensi perilaku yang dapat dilakukan:

- **Pelatihan Keterampilan Komunikasi Efektif**
Melatih keluarga dalam keterampilan komunikasi seperti mendengarkan aktif, berbicara dengan nada positif, menghindari kata-kata negatif atau menghakimi, serta mengekspresikan kebutuhan dengan jelas dan terbuka.
- **Pelatihan Manajemen Konflik Keluarga**
Mengajarkan keluarga cara-cara mengelola konflik secara konstruktif, seperti mengenali sumber konflik, berdiskusi tanpa menyerang, menyusun solusi bersama, serta mencegah eskalasi konflik.
- **Strategi Coping Keluarga**
Memberikan pelatihan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan emosional dan praktis akibat gangguan mental anggota keluarga, misalnya teknik relaksasi, manajemen stres, atau aktivitas rekreatif bersama keluarga yang meningkatkan kekompakan.

c. Tahapan dalam Implementasi CFIM:

Tahapan implementasi CFIM dilakukan secara sistematis, meliputi:

1) **Penilaian Keluarga secara Mendalam (Family Assessment)**

Penilaian komprehensif untuk mendapatkan gambaran tentang struktur, fungsi, hubungan interpersonal, komunikasi, pola interaksi, serta masalah khusus yang dihadapi keluarga.

2) **Menentukan Diagnosis Keperawatan Keluarga**

Menetapkan masalah kesehatan keluarga secara spesifik dan merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat.

3) **Menyusun Rencana Intervensi Bersama Keluarga**

Mengajak keluarga berdiskusi untuk menyusun rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

4) **Pelaksanaan Intervensi sesuai Rencana**

Menjalankan intervensi secara terstruktur sesuai jadwal yang disepakati, menggunakan intervensi kognitif, afektif, dan perilaku.

5) **Evaluasi Berkelanjutan terhadap Hasil Intervensi**

Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana intervensi berhasil, serta melakukan modifikasi jika diperlukan.

d. Keunggulan CFIM:

CFIM memiliki sejumlah keunggulan dalam penerapannya di klinis:

- 1) **Fleksibilitas tinggi:** Mudah diterapkan dalam berbagai kondisi klinis, baik di rumah sakit maupun komunitas.
- 2) **Keterlibatan aktif keluarga:** Mendorong keterlibatan keluarga secara aktif dalam proses terapi, sehingga menghasilkan komitmen yang lebih tinggi.
- 3) **Efektivitas dalam perubahan keluarga:** Terbukti efektif dalam menghasilkan perubahan signifikan dalam pola pikir, hubungan emosional, serta perilaku keluarga yang mendukung proses pemulihan pasien secara optimal.

D. Strategi Intervensi Keperawatan Berbasis Keluarga

1. Psikoedukasi kepada Keluarga

Psikoedukasi kepada keluarga merupakan strategi intervensi keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang gangguan mental atau emosional yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Strategi ini tidak hanya berupa penyampaian informasi tetapi juga merupakan proses edukasi yang berkelanjutan untuk merubah pola pikir keluarga ke arah yang lebih positif serta mengurangi stigma sosial terkait penyakit mental.

a. Tujuan Psikoedukasi:

- Meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai jenis, gejala, penyebab, dan prognosis gangguan mental.
- Mengurangi stigma keluarga terhadap penyakit mental.
- Meningkatkan kapasitas keluarga dalam mendukung pengobatan dan pemulihan pasien.
- Mengembangkan kemampuan keluarga dalam deteksi dini tanda-tanda kekambuhan gangguan mental.

b. Isi Materi Psikoedukasi:

- Penjelasan tentang definisi gangguan mental (seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan).

- Penyebab dan faktor risiko gangguan mental (biologis, psikologis, sosial).
 - Informasi tentang pengobatan, terapi psikologis, dan rehabilitasi.
 - Cara menghadapi stigma sosial yang melekat pada penyakit mental.
 - Deteksi dini dan cara menanggulangi gejala kekambuhan penyakit.
- c. Metode Pelaksanaan Psikoedukasi:
- Seminar atau workshop keluarga.
 - Diskusi kelompok keluarga secara rutin (support groups).
 - Media audio-visual seperti video, brosur, atau materi edukasi tertulis.
 - Konseling atau konsultasi langsung antara keluarga dengan perawat kesehatan jiwa.

2. Terapi Keluarga (Family Therapy)

Terapi keluarga adalah intervensi terapeutik yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikologis atau emosional melalui perbaikan interaksi keluarga. Terapi ini menekankan pentingnya hubungan antaranggota keluarga dalam proses penyembuhan dan pencegahan gangguan mental lebih lanjut.

- a. Tujuan Terapi Keluarga:
- Memperbaiki komunikasi keluarga yang terganggu akibat gangguan mental.
 - Mengatasi konflik keluarga secara konstruktif.
 - Meningkatkan dukungan emosional dan sosial dalam keluarga.
 - Mengembangkan strategi coping adaptif dalam menghadapi stres akibat gangguan mental.
- b. Teknik dalam Terapi Keluarga:
- Family Mapping: Mengidentifikasi pola interaksi keluarga yang dapat memperburuk kondisi mental anggota keluarga.
 - Role-playing: Melakukan simulasi untuk memahami perspektif anggota keluarga lainnya.
 - Open Dialogue: Memberikan kesempatan anggota keluarga berbicara secara jujur dan terbuka mengenai perasaan dan pemikiran masing-masing.
 - Conflict Resolution Training: Mengajarkan keluarga teknik penyelesaian konflik secara sehat dan konstruktif.
- c. Langkah Pelaksanaan Terapi Keluarga:
- Tahap asesmen mendalam terhadap pola hubungan dan komunikasi dalam keluarga.
 - Perumusan masalah keluarga yang terkait dengan gangguan mental.
 - Pelaksanaan sesi terapi secara berkala.
 - Evaluasi perkembangan interaksi keluarga secara berkala untuk menilai perubahan positif yang terjadi.

3. Konseling Keluarga dan Pelatihan Keterampilan

Konseling keluarga merupakan intervensi yang memberikan dukungan emosional, nasihat, serta bimbingan kepada keluarga dalam menghadapi situasi sulit akibat gangguan mental. Konseling keluarga biasanya dikombinasikan

dengan pelatihan keterampilan praktis untuk memperkuat kemampuan keluarga menghadapi tantangan sehari-hari.

a. Tujuan Konseling dan Pelatihan Keterampilan:

- Mengurangi stres dan tekanan emosional keluarga.
- Mengembangkan kemampuan keluarga dalam berkomunikasi secara efektif.
- Melatih keluarga dalam mengelola konflik dan mengatasi situasi sulit.
- Memperkuat keterampilan coping adaptif dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga yang kompleks.

b. Jenis Keterampilan yang Dilatih:

- Komunikasi Efektif: Teknik mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas tanpa menyalahkan, serta memahami pesan verbal dan non-verbal secara tepat.
- Manajemen Konflik: Pelatihan negosiasi, mediasi konflik, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
- Strategi Coping Adaptif: Pelatihan teknik relaksasi seperti mindfulness, meditasi, atau yoga keluarga.
- Manajemen Perilaku: Teknik penguatan positif dan bagaimana menghadapi perilaku negatif dengan pendekatan positif.

c. Cara Pelaksanaan Konseling Keluarga:

- Sesi konseling individual atau kelompok keluarga secara rutin.
- Workshop interaktif dengan simulasi kasus nyata atau role-playing.
- Pelatihan keterampilan secara terstruktur melalui sesi terpisah.

4. Manajemen Stres dan Krisis dalam Keluarga

Manajemen stres dan krisis dalam keluarga merupakan intervensi strategis yang dirancang untuk membantu keluarga menghadapi situasi stres atau krisis secara efektif, sehingga keluarga tidak mengalami dampak negatif jangka panjang akibat gangguan mental anggota keluarganya.

a. Tujuan Manajemen Stres dan Krisis:

- Mengidentifikasi tanda-tanda awal stres kronis dan krisis akut dalam keluarga.
- Mengurangi dampak negatif dari krisis pada kesehatan mental seluruh anggota keluarga.
- Memberdayakan keluarga untuk mengambil langkah yang tepat dan cepat saat menghadapi situasi krisis.

b. Komponen Penting dalam Manajemen Stres dan Krisis:

- Pendidikan tentang tanda-tanda krisis keluarga: Seperti perubahan perilaku mendadak, ancaman bunuh diri, atau episode psikotik akut.
- Family Crisis Plan: Merancang rencana tindakan darurat yang jelas dan praktis untuk menghadapi krisis secara cepat dan efektif.

- Teknik Relaksasi dan Manajemen Stres: Mengajarkan teknik-teknik seperti relaksasi napas dalam, relaksasi otot progresif, visualisasi positif, meditasi mindfulness, dan yoga keluarga.
 - Penyediaan Dukungan Profesional Cepat dan Responsif: Menyiapkan kontak layanan darurat profesional yang dapat dihubungi keluarga setiap saat.
- c. Tahapan Implementasi Manajemen Stres dan Krisis:
- Melakukan asesmen risiko keluarga untuk memahami potensi terjadinya krisis.
 - Mengadakan pelatihan keluarga tentang deteksi dini tanda krisis dan langkah-langkah antisipatif.
 - Menyusun bersama keluarga dokumen rencana krisis yang jelas.
 - Menyediakan konsultasi atau layanan profesional secara teratur agar keluarga dapat langsung mendapatkan bantuan saat krisis.

E. Kolaborasi Lintas Profesi dalam Intervensi Keperawatan Keluarga

1. Pengertian dan Pentingnya Kolaborasi Lintas Profesi

Kolaborasi lintas profesi adalah proses kerja sama antar berbagai profesi kesehatan yang saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam konteks intervensi keperawatan keluarga untuk gangguan mental dan emosional, kolaborasi lintas profesi berarti bahwa tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu seperti perawat jiwa, psikolog, psikiater, pekerja sosial, konselor, ahli terapi okupasi, serta tenaga kesehatan masyarakat, bersama-sama merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keluarga secara integratif dan holistik.

Kolaborasi lintas profesi sangat penting karena gangguan mental merupakan kondisi kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi yang tidak mungkin dapat diatasi secara efektif hanya oleh satu profesi saja. Dengan kolaborasi yang efektif, keluarga akan menerima dukabungan menyeluruh dari berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kolaborasi juga mempercepat proses penyembuhan, mengurangi kekambuhan, serta meningkatkan kepuasan keluarga dan kualitas hidup pasien.

2. Tim Interprofesional dalam Perawatan Kesehatan Jiwa

Dalam konteks kesehatan jiwa, tim interprofesional terdiri dari tenaga kesehatan dari berbagai bidang keahlian yang bekerja sama secara sinergis. Tim ini mencakup antara lain:

- **Perawat Kesehatan Jiwa:**

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan intervensi keperawatan keluarga, pemberian psikoedukasi, pemantauan kondisi pasien, serta mendampingi keluarga secara langsung dalam proses pemulihan.

- **Psikolog Klinis:**

Melakukan asesmen psikologis mendalam terhadap pasien dan keluarga, serta memberikan terapi psikologis seperti cognitive behavioral therapy (CBT), family therapy, serta intervensi emosional lainnya.

- **Psikiater:**

Dokter spesialis yang melakukan diagnosis medis, meresepkan dan mengelola pengobatan farmakologis, serta memantau efek terapi obat-obatan pada pasien.

- **Pekerja Sosial:**

Berperan dalam membantu keluarga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dukungan komunitas. Juga memberikan pendampingan untuk mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi gangguan mental.

- **Konselor Keluarga:**

Memberikan konseling khusus untuk membantu keluarga mengelola perasaan, konflik, dan stres emosional dalam menghadapi gangguan mental.

- **Terapis Okupasi:**

Membantu pasien dan keluarga dalam membangun keterampilan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan adaptasi, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial pasien di lingkungan keluarga dan masyarakat.

- **Petugas Kesehatan Masyarakat:**

Menghubungkan keluarga dengan komunitas, mempromosikan kesehatan mental secara luas, serta memonitor implementasi program di lingkungan masyarakat.

3. Peran Khusus Masing-Masing Profesi dalam Intervensi Keluarga

a. Perawat Kesehatan Jiwa

Perawat kesehatan jiwa merupakan profesi yang memiliki posisi sentral dalam intervensi keperawatan keluarga, khususnya untuk kasus gangguan mental dan emosional. Peran perawat jiwa secara mendetail meliputi:

- **Melakukan asesmen keperawatan menyeluruh:**

Perawat mengkaji secara rinci kondisi fisik, emosional, sosial, serta spiritual keluarga. Kajian ini mencakup evaluasi pola interaksi keluarga, pola komunikasi, faktor risiko, serta kekuatan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi gangguan mental.

- **Menentukan diagnosa keperawatan keluarga dan menyusun rencana intervensi yang integratif:**

Setelah proses asesmen, perawat menentukan diagnosa keperawatan secara spesifik, kemudian merancang rencana intervensi yang sesuai kebutuhan keluarga secara individu, termasuk pendekatan kognitif, afektif, dan perilaku.

- **Melakukan psikoedukasi secara rutin kepada keluarga:**

Perawat secara teratur memberikan edukasi yang komprehensif tentang penyakit mental, pengobatan, serta cara keluarga mendukung proses

pemulihan pasien. Psikoedukasi juga meliputi pelatihan keluarga dalam mendeteksi tanda awal kekambuhan.

- **Menyediakan konseling dan dukungan emosional secara kontinu:**

Perawat menjadi pendamping keluarga yang terus-menerus memberikan dukungan emosional serta konseling yang diperlukan, terutama saat menghadapi situasi stres atau krisis dalam keluarga.

- **Berperan sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam tim interprofesional:**

Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh profesi dalam tim interprofesional bekerja secara sinergis, efektif, serta berorientasi pada tujuan pemulihan pasien dan keluarga.

b. Psikolog Klinis

Psikolog klinis memiliki peran penting dalam memberikan intervensi psikologis yang spesifik serta terfokus kepada keluarga. Tugas detailnya mencakup:

- **Evaluasi psikologis mendalam terhadap dinamika keluarga:**

Psikolog melakukan asesmen rinci tentang pola hubungan emosional antaranggota keluarga, serta menilai dampak psikologis gangguan mental terhadap anggota keluarga secara individu maupun kolektif.

- **Memberikan terapi psikologis berbasis bukti:**

Menjalankan terapi psikologis terstruktur seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi keluarga, terapi interpersonal, terapi perilaku dialektis (DBT), atau terapi lainnya yang sesuai dengan kondisi spesifik pasien dan keluarga.

- **Melatih keluarga dalam keterampilan coping emosional yang efektif:**

Psikolog melatih keluarga untuk menggunakan strategi coping emosional adaptif, seperti manajemen stres, regulasi emosi, dan cara mengatasi krisis secara positif.

- **Mengukur efektivitas intervensi psikologis yang diberikan secara berkala:**

Melakukan evaluasi terhadap perkembangan keluarga secara terstruktur untuk memastikan intervensi memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

c. Psikiater

Sebagai tenaga medis spesialis, psikiater memiliki tugas yang berfokus pada aspek medis dari gangguan mental yang dialami keluarga, seperti:

- **Menegakkan diagnosis medis berdasarkan DSM-5:**

Psikiater melakukan diagnosis gangguan mental secara medis berdasarkan kriteria diagnostik yang baku (DSM-5), dan menjelaskan secara jelas kepada keluarga tentang diagnosis tersebut.

- **Meresepkan dan memonitor terapi farmakologis:**

Menentukan dan memberikan pengobatan farmakologis yang tepat sesuai dengan jenis gangguan mental, serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap efektivitas dan efek samping obat-obatan tersebut.

- **Berkolaborasi dalam tim untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan serta merespons situasi darurat atau krisis keluarga:**

Psikiater bekerjasama erat dengan profesi lain untuk merespon situasi darurat, seperti episode psikotik akut, percobaan bunuh diri, atau situasi krisis lainnya yang membutuhkan intervensi medis segera.

d. Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki tugas utama yang berhubungan dengan aspek sosial dari permasalahan yang dialami keluarga, yaitu:

- **Melakukan asesmen sosial secara komprehensif terhadap keluarga:**

Mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi, masalah keuangan, akses layanan kesehatan, serta sumber daya sosial keluarga yang mungkin berkontribusi pada gangguan mental.

- **Membantu keluarga mengakses berbagai layanan sosial, keuangan, pendidikan, serta komunitas pendukung:**

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara keluarga dengan sumber-sumber daya eksternal, seperti bantuan sosial, layanan pendidikan, layanan komunitas, serta layanan sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan keluarga.

- **Mengurangi faktor stres sosial yang memperburuk kondisi mental pasien:**

Secara aktif mengurangi berbagai faktor stres sosial seperti konflik keluarga, diskriminasi, masalah ekonomi, maupun masalah lingkungan yang memperparah kondisi pasien.

e. Konselor Keluarga

Konselor keluarga memiliki peran dalam membantu keluarga mengelola aspek emosional, komunikasi, dan hubungan interpersonal dalam keluarga secara khusus:

- **Menyediakan konseling intensif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi keluarga:**

Melalui sesi konseling, keluarga dilatih untuk memiliki keterampilan komunikasi positif, mendengarkan aktif, serta mengekspresikan perasaan tanpa menimbulkan konflik.

- **Membantu keluarga menyelesaikan konflik internal secara konstruktif:**
- Konselor memfasilitasi keluarga dalam menyelesaikan konflik keluarga secara efektif, kooperatif, dan tanpa kekerasan.

- **Memberikan dukungan emosional spesifik dalam menghadapi tantangan psikososial:**

Menyediakan ruang yang aman bagi keluarga untuk mengungkapkan perasaan negatif dan membantu keluarga merespons tantangan emosional secara sehat dan adaptif.

f. Terapis Okupasi

Terapis okupasi memiliki peran spesifik dalam melatih keterampilan fungsional keluarga dalam kehidupan sehari-hari:

- **Melatih pasien dan keluarga dalam keterampilan kehidupan sehari-hari:**

Terapis okupasi mengembangkan kemampuan pasien dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti perawatan diri, aktivitas sosial, dan rekreasi bersama keluarga.

- **Meningkatkan kemampuan adaptasi pasien di lingkungan rumah dan masyarakat:**

Menyusun strategi adaptasi serta modifikasi lingkungan yang dapat membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih produktif di komunitasnya.

- **Memberikan edukasi khusus kepada keluarga mengenai strategi rehabilitasi sosial:**

Menyediakan informasi tentang cara mendukung rehabilitasi sosial pasien di lingkungan keluarga dan masyarakat.

g. **Petugas Kesehatan Masyarakat**

Peran petugas kesehatan masyarakat secara spesifik mencakup aspek komunitas dan kesehatan masyarakat secara luas:

- **Melaksanakan edukasi dan kampanye kesehatan mental di komunitas:**

Menjalankan berbagai kegiatan edukasi masyarakat tentang kesehatan mental, meningkatkan kesadaran komunitas terhadap gangguan mental.

- **Memfasilitasi program dukungan kesehatan mental berbasis komunitas:**

Mengembangkan kelompok dukungan komunitas, pendampingan sosial, serta jaringan dukungan sosial bagi keluarga pasien gangguan mental.

- **Memantau dampak intervensi keluarga secara luas di masyarakat sekitar:**

Mengawasi efektivitas program kesehatan mental berbasis komunitas, serta menyediakan umpan balik kepada tim interprofesional untuk memperbaiki intervensi.

4. Prinsip dan Strategi Kolaborasi Lintas Profesi dalam Pelaksanaan Intervensi

a. **Prinsip Dasar Kolaborasi Lintas Profesi:**

- **Saling Menghormati (Mutual Respect):** Menghargai keahlian dan kontribusi masing-masing profesi dalam tim.
- **Komunikasi Efektif:** Menjaga komunikasi yang jelas, terbuka, dan transparan antar anggota tim untuk menghindari kesalahpahaman.
- **Pembagian Peran Jelas:** Setiap profesi memahami peran dan tanggung jawab spesifiknya dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.
- **Tujuan Bersama:** Seluruh anggota tim bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pasien secara menyeluruh.
- **Pengambilan Keputusan Bersama:** Keputusan klinis dilakukan secara kolektif setelah mempertimbangkan perspektif dari semua anggota tim.

b. **Strategi Efektif dalam Kolaborasi Lintas Profesi:**

- **Rapat Tim Interprofesional Rutin:** Mengadakan pertemuan tim secara rutin untuk berdiskusi tentang perkembangan pasien dan keluarga, evaluasi program, serta modifikasi intervensi.
- **Komunikasi Dokumentasi Terintegrasi:** Memiliki sistem dokumentasi bersama agar setiap anggota tim dapat mengakses informasi pasien secara real-time dan transparan.
- **Pelatihan Tim Bersama:** Mengadakan pelatihan lintas disiplin secara berkala untuk memperkuat kerjasama, saling memahami peran, serta meningkatkan keterampilan kolaborasi.
- **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kolaborasi dan hasil intervensi, serta melakukan perbaikan secara kontinu.
- **Dukungan Kelembagaan:** Mendapatkan dukungan penuh dari manajemen institusi kesehatan dalam menyediakan sumber daya, fasilitas, serta lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi antar profesi.

F. Hambatan dan Tantangan dalam Kolaborasi Lintas Profesi dalam Intervensi Keperawatan Berbasis Keluarga

Kolaborasi lintas profesi merupakan aspek yang krusial dalam pelaksanaan intervensi keperawatan berbasis keluarga, khususnya dalam mengatasi masalah gangguan mental dan emosional. Meskipun pendekatan kolaborasi telah terbukti memberikan manfaat yang besar, dalam implementasinya masih sering dijumpai berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Hambatan tersebut harus dikenali secara dini agar tidak mengurangi efektivitas intervensi yang diberikan kepada keluarga.

1. Tantangan Komunikasi antar Profesi

Salah satu tantangan utama yang kerap muncul dalam kolaborasi lintas profesi adalah masalah komunikasi antar tenaga profesional. Setiap profesi memiliki latar belakang keilmuan, gaya komunikasi, serta terminologi teknis yang berbeda. Perbedaan ini sering kali memunculkan kesalahpahaman atau miskomunikasi yang dapat menghambat jalannya intervensi.

Misalnya, komunikasi antara psikiater yang menggunakan istilah medis teknis dengan pekerja sosial yang cenderung memakai bahasa yang lebih sederhana terkadang memunculkan hambatan pemahaman informasi. Hal ini juga terjadi pada saat penyampaian hasil evaluasi psikologis oleh psikolog klinis kepada anggota tim lain seperti perawat kesehatan jiwa dan konselor keluarga. Kesalahpahaman seperti ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan dan strategi intervensi, sehingga implementasi tindakan menjadi kurang efektif atau bahkan bertentangan.

Selain itu, tantangan komunikasi juga muncul ketika anggota tim memiliki ego profesional yang tinggi, sehingga cenderung kurang terbuka terhadap masukan atau pandangan dari profesi lain. Sikap defensif dan ketidakmampuan dalam menyampaikan kritik konstruktif secara tepat turut memperburuk situasi komunikasi antarprofesi. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian khusus agar tidak mengganggu proses kolaborasi secara keseluruhan.

2. Hambatan Sosial-Budaya dalam Intervensi Berbasis Keluarga

Hambatan lain yang juga signifikan dalam intervensi berbasis keluarga adalah hambatan sosial-budaya. Gangguan mental dan emosional masih sering dikaitkan dengan stigma negatif di banyak komunitas dan budaya tertentu. Akibatnya, keluarga sering kali mengalami rasa malu, penolakan sosial, atau bahkan mengisolasi diri karena khawatir mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat sekitar.

Dalam beberapa budaya tertentu, gangguan mental dipandang sebagai akibat dari kelemahan pribadi, kutukan, atau hukuman akibat kesalahan keluarga di masa lalu. Pandangan seperti ini menyebabkan keluarga ragu untuk terbuka terhadap intervensi yang ditawarkan oleh tim interprofesional. Dalam situasi seperti ini, keluarga cenderung menolak atau menunda mencari bantuan profesional, yang akhirnya memperburuk kondisi pasien dan menyulitkan tim dalam melakukan intervensi efektif.

Selain itu, perbedaan nilai budaya juga mempengaruhi penerimaan keluarga terhadap metode intervensi. Sebagai contoh, keluarga yang memiliki orientasi budaya yang sangat tertutup mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan enggan dalam mengikuti sesi konseling keluarga atau terapi kelompok yang bersifat terbuka. Hal ini menjadi tantangan bagi tim dalam menyesuaikan pendekatan intervensi agar tetap relevan, efektif, sekaligus tetap menghormati nilai budaya yang dianut keluarga.

3. Masalah Koordinasi dan Manajemen Waktu antar Profesi

Permasalahan berikutnya yang kerap ditemui dalam kolaborasi lintas profesi adalah masalah koordinasi serta pengaturan waktu yang efektif. Setiap tenaga profesional biasanya memiliki jadwal kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk bertemu, berdiskusi, atau melaksanakan intervensi secara bersamaan.

Kurangnya koordinasi yang baik sering menyebabkan penundaan pelaksanaan intervensi, tidak terselesaikannya tugas-tugas penting, atau bahkan pengulangan pekerjaan akibat kurangnya komunikasi mengenai apa yang telah dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Selain itu, kurangnya sistem manajemen waktu yang efektif menyebabkan anggota tim sulit hadir dalam rapat rutin, sesi

pelatihan bersama, atau konsultasi tim yang penting dalam menentukan keputusan bersama.

Masalah ini semakin kompleks bila tim interprofesional terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai institusi atau lokasi yang berbeda, sehingga menyebabkan tantangan logistik tambahan. Ketidakhadiran anggota tim dalam rapat atau diskusi secara rutin akan menyebabkan ketidaklengkapan informasi, menurunkan kualitas pengambilan keputusan, dan akhirnya mengurangi efektivitas intervensi.

4. Strategi Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Mengatasi berbagai hambatan dan tantangan dalam kolaborasi lintas profesi membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Beberapa strategi yang dapat diterapkan secara efektif adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam mengatasi tantangan komunikasi, tim harus menerapkan sistem komunikasi yang jelas, sederhana, dan terstandar. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan terminologi yang disepakati bersama serta penyediaan pelatihan komunikasi interprofesional yang rutin. Anggota tim perlu dilatih untuk terbuka terhadap masukan, mampu memberikan umpan balik konstruktif, serta memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik.

Kedua, untuk mengatasi hambatan sosial-budaya, tim interprofesional perlu mengembangkan sensitivitas budaya melalui pendekatan cultural competence. Artinya, tim harus berusaha memahami latar belakang budaya keluarga yang menjadi sasaran intervensi. Pendekatan ini mencakup penghormatan terhadap nilai dan kepercayaan keluarga, penyesuaian metode intervensi dengan budaya lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat yang dihormati keluarga untuk membantu proses pendekatan dan edukasi.

Ketiga, dalam menangani masalah koordinasi dan manajemen waktu, diperlukan sistem koordinasi yang terintegrasi dan penggunaan teknologi informasi yang modern. Penggunaan platform digital untuk dokumentasi terintegrasi, konferensi virtual, atau jadwal daring yang terpusat, dapat membantu tim berkomunikasi secara efektif, efisien, serta fleksibel. Penjadwalan rutin harus disepakati jauh hari sebelumnya agar semua anggota tim bisa mengatur prioritas kerja dengan lebih baik.

Keempat, dukungan kelembagaan dari institusi tempat tim bekerja menjadi faktor yang krusial. Institusi harus memberikan dukungan berupa kebijakan yang jelas tentang kolaborasi lintas profesi, alokasi waktu khusus untuk aktivitas kolaborasi, serta fasilitas yang memadai seperti ruangan khusus pertemuan atau perangkat pendukung komunikasi.

G. Simpulan

Gangguan mental dan emosional telah menjadi tantangan besar dalam kesehatan global, termasuk di Indonesia, dengan prevalensi yang semakin meningkat dan memberikan dampak luas terhadap individu, keluarga, serta masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan pihak yang sangat terpengaruh oleh kondisi ini, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun demikian, keterlibatan aktif keluarga dalam intervensi penanganan gangguan mental masih minim, sehingga mengurangi efektivitas terapi.

Pendekatan intervensi keperawatan berbasis keluarga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan terapeutik, emosional, dan sosial kepada anggotanya yang mengalami gangguan mental. Intervensi ini mencakup peningkatan pemahaman keluarga, pemberdayaan peran aktif dalam rehabilitasi, perbaikan komunikasi keluarga, pengurangan stigma sosial, serta peningkatan coping dan resiliensi keluarga. Melibatkan keluarga dalam intervensi terbukti efektif mempercepat pemulihan, mencegah kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

Intervensi keperawatan keluarga ini memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup psikoedukasi, terapi keluarga, konseling emosional, pelatihan keterampilan komunikasi dan coping, manajemen stres dan krisis, koordinasi lintas profesi, serta evaluasi rutin intervensi. Implementasi model intervensi seperti Calgary Family Intervention Model (CFIM) yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku, terbukti efektif dalam merubah pola pikir keluarga, memperbaiki hubungan emosional, serta meningkatkan perilaku positif keluarga dalam mendukung pemulihan pasien.

Kolaborasi lintas profesi antara perawat jiwa, psikolog, psikiater, pekerja sosial, konselor keluarga, terapis okupasi, dan petugas kesehatan masyarakat sangat krusial untuk menjamin intervensi yang holistik dan terintegrasi. Kolaborasi ini berdasarkan prinsip saling menghormati, komunikasi efektif, pembagian peran jelas, tujuan bersama, dan pengambilan keputusan bersama. Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi lintas profesi sering menghadapi berbagai hambatan seperti tantangan komunikasi antarprofesi, hambatan sosial-budaya, serta masalah koordinasi dan manajemen waktu.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan berbagai strategi seperti meningkatkan komunikasi interprofesional melalui pelatihan rutin, mengembangkan sensitivitas budaya dalam tim intervensi, meningkatkan koordinasi melalui penggunaan teknologi informasi, serta memastikan dukungan kelembagaan dalam kebijakan kolaborasi. Dengan demikian, intervensi keperawatan keluarga yang kolaboratif dapat dilaksanakan secara optimal, meningkatkan

efektivitas perawatan kesehatan jiwa, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan pasien dan keluarganya.

H. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. http://labmandat.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Leahey, M., & Wright, L. M. (2016). *Nurses and families: A guide to family assessment and intervention* (6th ed.). F.A. Davis Company.
- Stuart, G. W. (2018). *Principles and practice of psychiatric nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2018). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (9th ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2018). *Mental health atlas 2017*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514019>
- World Health Organization. (2019). *The WHO special initiative for mental health (2019-2023): Universal health coverage for mental health*. World Health Organization. [https://www.who.int/publications/i/item/special-initiative-for-mental-health-\(2019-2023\)](https://www.who.int/publications/i/item/special-initiative-for-mental-health-(2019-2023))
- World Health Organization. (2021). *Comprehensive mental health action plan 2013–2030*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029>
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2013). Calgary Family Intervention Model: One way to think about change. *Journal of Marital and Family Therapy*, 39(1), 11–23. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00360.x>
- Xiao, S., Lin, Y., Zhu, Y., Wang, X., & Wu, L. (2021). Effectiveness of family intervention on patients with mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 650–660. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.610036>
- Yıldırım, M., & Aylaz, R. (2022). The effect of psychoeducation given to families of patients with mental illness on family functioning and coping strategies. *Journal of Psychiatric Nursing*, 13(1), 23–30. <https://doi.org/10.14744/phd.2022.97860>

I. Glosarium

- **Advokasi:** Proses mendukung, membela, dan memperjuangkan hak-hak pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan dan sosial yang memadai.
- **Afektif (Intervensi):** Intervensi yang bertujuan untuk mengelola dan memperbaiki aspek emosi dan hubungan emosional dalam keluarga.
- **Bipolar (Gangguan):** Gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati ekstrem, dari kondisi mania (euforia) hingga depresi berat.
- **Calgary Family Intervention Model (CFIM):** Model intervensi keperawatan keluarga yang berfokus pada perubahan pola interaksi, persepsi, dan perilaku keluarga untuk mendukung pasien gangguan mental.
- **Coping:** Cara individu atau keluarga menghadapi dan mengelola situasi stres atau masalah yang dihadapi.
- **Depresi (Gangguan):** Gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, dan penurunan energi serta aktivitas sehari-hari.
- **Emosional (Gangguan):** Gangguan mental yang khusus ditandai oleh ketidakstabilan emosi, misalnya kecemasan dan depresi.
- **Family Mapping:** Teknik dalam terapi keluarga yang digunakan untuk mengidentifikasi pola interaksi keluarga yang berpotensi memperburuk gangguan mental pasien.
- **Family Therapy (Terapi Keluarga):** Terapi yang berfokus pada perbaikan interaksi keluarga untuk mengatasi masalah psikologis atau emosional dalam keluarga.
- **Gangguan Emosional:** Gangguan mental dengan ciri utama ketidakstabilan atau gangguan dalam emosi seseorang, seperti kecemasan berlebihan atau depresi.
- **Gangguan Jiwa (Penyakit Mental):** Kondisi perubahan signifikan dalam pikiran, emosi, atau perilaku yang berdampak negatif pada fungsi sehari-hari seseorang.
- **Intervensi Kognitif:** Pendekatan intervensi yang bertujuan memperbaiki pemahaman, persepsi, dan pola pikir keluarga terhadap gangguan mental.
- **Intervensi Perilaku:** Intervensi yang bertujuan menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku keluarga dalam mendukung pasien yang mengalami gangguan mental.
- **Intervensi Psikoedukasi:** Edukasi mendalam yang diberikan kepada keluarga tentang diagnosis, gejala, penyebab, dan alternatif terapi gangguan mental.
- **Intervensi Keperawatan Keluarga:** Tindakan keperawatan yang melibatkan keluarga secara aktif untuk meningkatkan dukungan terapeutik bagi pasien gangguan mental.
- **Kolaborasi Lintas Profesi:** Kerja sama berbagai tenaga kesehatan dari disiplin ilmu yang berbeda untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal.
- **Komunikasi Efektif:** Keterampilan menyampaikan pesan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami antar anggota keluarga atau tenaga profesional.
- **Konseling Keluarga:** Dukungan profesional kepada keluarga untuk membantu mengatasi konflik, stres, serta tekanan emosional akibat gangguan mental anggota keluarga.
- **Manajemen Krisis:** Proses intervensi yang berfokus pada penanganan situasi akut seperti percobaan bunuh diri atau kondisi emosional yang ekstrem dalam keluarga.

- **Model Intervensi:** Kerangka sistematis yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan intervensi, seperti model CFIM.
- **Perawat Kesehatan Jiwa:** Tenaga kesehatan yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan mental.
- **Pekerja Sosial:** Profesional yang membantu keluarga dalam mengakses layanan sosial dan mengatasi masalah sosial-ekonomi yang berkaitan dengan gangguan mental.
- **Psikolog Klinis:** Profesional yang melakukan evaluasi psikologis dan memberikan terapi psikologis pada pasien dan keluarga.
- **Psikiater:** Dokter spesialis yang menangani diagnosis medis dan pengobatan farmakologis pada pasien dengan gangguan mental.
- **Resiliensi Keluarga:** Kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari situasi sulit atau krisis akibat gangguan mental.
- **Risiko Kekambuhan:** Potensi munculnya kembali gejala gangguan mental setelah kondisi pasien sempat membaik.
- **Skizofrenia:** Gangguan mental berat yang ditandai dengan gejala halusinasi, delusi, gangguan berpikir, dan kesulitan mengenali realitas.
- **Stigma Sosial:** Pandangan negatif dari masyarakat yang menyebabkan diskriminasi terhadap individu atau keluarga yang mengalami gangguan mental.
- **Strategi Coping Adaptif:** Strategi yang konstruktif dan positif digunakan keluarga dalam mengelola stres dan tantangan akibat gangguan mental.
- **Terapi Okupasi:** Terapi yang bertujuan membantu pasien dalam meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari, fungsi sosial, dan adaptasi di lingkungan masyarakat.
- **Tim Interprofesional:** Kelompok tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang bekerja secara kolaboratif untuk memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi.
- **Tingkat Prevalensi:** Angka kejadian atau jumlah kasus gangguan mental dalam populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- **WHO (World Health Organization):** Organisasi kesehatan dunia yang memberikan panduan global dalam penanganan masalah kesehatan, termasuk gangguan mental.

CHAPTER 3

INTEGRASI PSIKOLOGI KELUARGA DALAM ASUHAN KEPERAWATAN

Ns. Yenny B. Makahaghi, S.Kep., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan merupakan suatu pendekatan multidimensional yang menggabungkan pemahaman mendalam terhadap aspek psikologis dan emosional keluarga dalam proses perawatan pasien. Dalam konteks keperawatan, psikologi keluarga didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana dinamika emosional, sosial, dan hubungan interpersonal antar anggota keluarga dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun mental pasien. Psikologi keluarga memberikan wawasan tentang pola komunikasi, interaksi, peran keluarga, serta bagaimana stres atau tantangan psikologis dalam keluarga bisa menjadi faktor yang mempercepat atau menghambat pemulihan pasien. Integrasi pendekatan ini dalam praktik keperawatan memungkinkan perawat untuk lebih efektif dalam memberikan perawatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada pasien tetapi juga mencakup seluruh anggota keluarganya (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

Pentingnya integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan sangat besar karena keluarga merupakan unit sosial terdekat yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi pasien. Sebagai lingkungan utama di mana pasien hidup dan berinteraksi, keluarga seringkali menjadi sumber utama dukungan emosional, sosial, spiritual, dan finansial. Dengan memahami secara menyeluruh kondisi psikologis keluarga, perawat mampu mengidentifikasi masalah potensial yang dapat memengaruhi kesehatan pasien, seperti konflik keluarga, kurangnya komunikasi yang efektif, stres kronis akibat penyakit yang berkepanjangan, dan ketidakmampuan keluarga dalam mengelola situasi krisis kesehatan (Yeh & Bull, 2022). Sebagai contoh, pada keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronis, tekanan emosional yang tinggi dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap komplikasi pada pasien maupun memburuknya kualitas hidup keluarga secara keseluruhan (Svavarsdottir, Tryggvadottir, Gisladdottir, Olafsdottir, & Gudmundsdottir, 2020).

Pendekatan ini semakin penting dalam era keperawatan modern di mana paradigma perawatan telah bergeser dari berorientasi pasien semata (patient-centered) menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan keluarga sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan (family-centered care). Studi menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang memasukkan elemen psikologi keluarga, seperti edukasi keluarga, konseling, pelatihan keterampilan coping, dan terapi keluarga,

terbukti efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan pasien, mempercepat proses pemulihan, serta memperkuat resiliensi keluarga dalam menghadapi tantangan kesehatan yang berat (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

Integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan juga bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran penting dalam pelayanan kesehatan. Pertama, integrasi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam mengelola emosi dan stres, sehingga keluarga dapat lebih baik dalam mendukung pasien melalui berbagai tahap pengobatan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya sebagai pendamping, namun juga aktif dalam membantu proses penyembuhan pasien. Kedua, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan komunikasi efektif antara keluarga dengan pasien maupun tim kesehatan, sehingga mencegah kesalahpahaman atau miskomunikasi yang seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021). Ketiga, tujuan dari integrasi ini adalah memberdayakan keluarga dengan keterampilan khusus dalam mengelola berbagai masalah kesehatan, termasuk pengambilan keputusan bersama dalam situasi kritis, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup baik pasien maupun seluruh anggota keluarga (Kokorelias, Gignac, Naglie, & Cameron, 2020).

Selain itu, tujuan penting lainnya dari integrasi ini adalah menciptakan lingkungan terapeutik yang kondusif, di mana pasien merasa aman, nyaman, dan didukung secara emosional oleh keluarga yang stabil dan harmonis. Kondisi psikologis positif dalam keluarga secara langsung berdampak positif terhadap pasien, meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani terapi, serta mengurangi risiko gangguan psikologis tambahan seperti depresi atau kecemasan akibat isolasi sosial (Giske & Gjengedal, 2021).

Integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan juga membawa manfaat jangka panjang. Keluarga yang dilibatkan secara aktif dalam perawatan cenderung lebih efektif dalam mendukung pasien setelah pasien kembali ke lingkungan rumah. Hal ini membantu dalam menurunkan angka readmisi rumah sakit, mengurangi biaya kesehatan secara keseluruhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara berkelanjutan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam asuhan keperawatan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan, serta memperkuat hubungan profesional antara tim kesehatan dan keluarga pasien (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

Dengan demikian, integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan tidak hanya sekadar tambahan dalam proses perawatan, tetapi merupakan elemen vital dalam memastikan tercapainya perawatan yang holistik, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif keluarga sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan perawatan, sehingga secara nyata meningkatkan hasil kesehatan pasien serta kesejahteraan psikologis keluarga.

B. Konsep Dasar Psikologi Keluarga dalam Keperawatan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga merupakan cabang psikologi yang secara spesifik mempelajari dinamika emosional, sosial, dan perilaku dalam unit keluarga. Psikologi keluarga berfokus pada bagaimana pola interaksi, komunikasi, dan hubungan antaranggota keluarga dapat memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan perkembangan setiap individu dalam keluarga tersebut. Secara lebih spesifik, psikologi keluarga mengeksplorasi bagaimana keluarga sebagai sistem sosial terkecil berinteraksi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik tantangan yang bersifat rutin sehari-hari maupun tantangan berat seperti penyakit kronis, kecelakaan, perceraian, atau kehilangan anggota keluarga (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Ruang lingkup psikologi keluarga mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi orang tua-anak, hubungan antar saudara, hubungan dalam pasangan suami-istri, serta interaksi keluarga dengan lingkungan sosialnya yang lebih luas. Aspek lainnya yang dipelajari adalah bagaimana keluarga beradaptasi terhadap perubahan siklus hidup, seperti kelahiran anak, anak yang mulai dewasa, menghadapi penyakit serius, pensiun, hingga kematian anggota keluarga. Selain itu, psikologi keluarga juga membahas aspek psikologis keluarga yang lebih luas seperti kohesi keluarga, pola komunikasi, manajemen stres, dan kemampuan adaptasi keluarga terhadap tekanan atau perubahan yang dialami. Dalam konteks keperawatan, psikologi keluarga membantu perawat memahami bahwa pasien bukan hanya sebagai individu yang membutuhkan perawatan medis, melainkan juga sebagai bagian dari sistem keluarga yang lebih luas, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat holistik dan terintegrasi (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

2. Teori-teori Psikologi Keluarga yang Relevan dengan Keperawatan

a. Teori Sistem Keluarga (Family Systems Theory)

Teori sistem keluarga, yang diperkenalkan oleh Murray Bowen, menganggap keluarga sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau anggota yang saling bergantung satu sama lain. Menurut teori ini, perilaku, emosi, dan kondisi psikologis salah satu anggota keluarga tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam konteks hubungan dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Teori ini menekankan bahwa setiap perubahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga akan berdampak pada seluruh keluarga secara keseluruhan. Dengan kata lain, keluarga berfungsi sebagai unit yang saling berhubungan secara emosional dan fungsional (Walsh, 2021).

Dalam praktik keperawatan, teori sistem keluarga sangat berguna karena memungkinkan perawat untuk melihat lebih dalam bagaimana hubungan antar anggota keluarga dapat mendukung atau justru menghambat proses pemulihan pasien. Contohnya, ketika seorang pasien menderita penyakit kronis atau akut, seluruh anggota keluarga akan terpengaruh secara emosional maupun psikologis. Sebagai sistem, keluarga perlu menjaga keseimbangan emosional agar bisa memberikan dukungan optimal kepada pasien. Oleh karena itu, perawat tidak hanya memberikan intervensi kepada pasien tetapi juga memberikan dukungan kepada keluarga, membantu mereka mengelola konflik, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga agar proses penyembuhan menjadi lebih efektif (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

b. Teori Perkembangan Keluarga (Family Developmental Theory)

Teori perkembangan keluarga dikembangkan oleh Evelyn Duvall. Teori ini menggambarkan bahwa keluarga mengalami siklus hidup dengan berbagai tahapan perkembangan yang memiliki tugas dan tantangan tersendiri. Beberapa tahapan dalam siklus ini meliputi tahap awal perkawinan, tahap memiliki anak kecil, tahap anak remaja, tahap anak dewasa meninggalkan rumah, tahap keluarga dengan lansia, hingga tahap akhir kehidupan pasangan lansia. Setiap tahap memiliki tantangan psikologis yang khas, seperti adaptasi terhadap peran baru, komunikasi antar generasi, pengambilan keputusan bersama, dan adaptasi terhadap kehilangan anggota keluarga yang meninggal atau pindah (Friedman et al., 2022).

Dalam konteks keperawatan, teori perkembangan keluarga membantu perawat untuk menyesuaikan intervensi yang diberikan kepada keluarga sesuai dengan tahapan perkembangan yang mereka alami. Misalnya, keluarga muda dengan anak kecil akan memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan keluarga dengan anggota lansia yang mengalami penyakit degeneratif. Perawat yang memahami teori ini dapat mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan keluarga dengan lebih tepat, sehingga intervensi keperawatan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan keluarga dalam tahap kehidupannya (Kaakinen et al., 2022).

c. Teori Stres dan Coping dalam Keluarga (*Family Stress and Coping Theory*)

Teori stres dan coping keluarga yang dikembangkan oleh Reuben Hill dan dikembangkan lebih lanjut oleh McCubbin dan Patterson, mengkaji bagaimana keluarga mengalami dan mengelola stres. Teori ini mengemukakan bahwa keluarga terus-menerus menghadapi berbagai sumber stres yang bisa berasal dari internal maupun eksternal keluarga. Sumber stres internal misalnya konflik

keluarga, sedangkan sumber stres eksternal bisa berupa masalah ekonomi, penyakit kronis anggota keluarga, atau kehilangan pekerjaan. Menurut teori ini, keberhasilan keluarga dalam menghadapi stres sangat tergantung pada kemampuan coping atau strategi yang mereka gunakan serta ketersediaan sumber daya yang mereka miliki, baik internal seperti kohesi keluarga dan komunikasi yang efektif, maupun eksternal seperti dukungan sosial dari komunitas (Patterson & Garwick, 2022).

Dalam keperawatan, teori stres dan coping keluarga sangat relevan untuk memahami bagaimana keluarga menghadapi kondisi kesehatan yang serius atau kronis. Dengan memahami strategi coping keluarga, perawat dapat memberikan intervensi yang lebih efektif, seperti membantu keluarga mengembangkan strategi coping yang adaptif, memberikan edukasi untuk meningkatkan komunikasi keluarga, serta menghubungkan keluarga dengan sumber dukungan sosial yang lebih luas. Misalnya, jika anggota keluarga pasien menunjukkan tanda-tanda stres berlebihan, perawat dapat membantu mereka mengenali sumber stres, mengelola emosi negatif seperti kecemasan atau depresi, dan memberikan strategi khusus seperti terapi keluarga, konseling psikologis, atau pelatihan keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah (Giske & Gjengedal, 2021).

Dengan memahami berbagai teori ini secara mendalam, tenaga keperawatan dapat memberikan perawatan yang holistik, komprehensif, dan efektif, dengan melibatkan keluarga secara aktif sebagai mitra penting dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien.

C. Peran Psikologi Keluarga dalam Asuhan Keperawatan

2. Dampak Kondisi Psikologis Keluarga terhadap Kondisi Pasien

Kondisi psikologis keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi kesehatan pasien, baik secara fisik maupun mental. Sebagai unit sosial terdekat pasien, keluarga merupakan lingkungan utama yang secara konstan berinteraksi dengan pasien, sehingga apa yang dirasakan dan dialami keluarga akan mempengaruhi pasien secara signifikan. Misalnya, jika anggota keluarga mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat penyakit atau kondisi pasien yang berat, maka pasien sendiri juga cenderung mengalami peningkatan stres emosional. Kondisi psikologis negatif ini dapat memperlambat proses pemulihan pasien atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

Sebaliknya, keluarga yang memiliki kondisi psikologis stabil dan positif mampu memberikan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan pasien. Sebagai

contoh, ketika keluarga menunjukkan sikap optimis, dukungan emosional yang kuat, serta memiliki kemampuan untuk mengelola stres dengan baik, pasien cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam menghadapi pengobatan, merasakan kenyamanan psikologis, serta lebih mudah mengikuti rencana perawatan yang diberikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien yang mendapat dukungan keluarga yang kuat memiliki tingkat kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan pasien dengan keluarga yang mengalami gangguan psikologis seperti konflik berkepanjangan, kecemasan berlebihan, atau depresi (Giske & Gjengedal, 2021).

Selain itu, kondisi psikologis keluarga yang kurang baik juga dapat memperparah komplikasi penyakit pasien, seperti meningkatnya rasa nyeri kronis, kesulitan tidur, atau penurunan nafsu makan akibat stres psikologis. Di sisi lain, keluarga yang mampu menjaga kesehatan emosional dengan baik akan membantu pasien dalam menghadapi kondisi kesehatannya dengan lebih baik pula, sehingga risiko komplikasi yang disebabkan oleh stres dan kecemasan dapat diminimalisir secara signifikan (Walsh, 2021).

3. Fungsi Keluarga sebagai Sistem Pendukung Emosional Pasien

Keluargalah yang pertama kali memberikan dukungan emosional terhadap pasien yang mengalami berbagai kondisi kesehatan. Sebagai sistem pendukung emosional utama, keluarga memiliki beberapa peran krusial, di antaranya adalah memberikan rasa aman, nyaman, serta menciptakan suasana psikologis positif bagi pasien. Dalam situasi di mana pasien mengalami kondisi kesehatan serius atau kronis, kehadiran anggota keluarga yang penuh empati, perhatian, serta dukungan nyata sangat penting untuk menjaga kestabilan emosional pasien (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

Selain itu, keluarga memiliki peran sebagai pendamping emosional yang sangat penting, terutama dalam menghadapi stres, kecemasan, atau ketakutan pasien terhadap prosedur medis tertentu, efek samping pengobatan, atau prognosis penyakitnya. Sebagai contoh, kehadiran anggota keluarga yang mendukung secara emosional terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan pasien yang menjalani operasi, kemoterapi, atau perawatan intensif di rumah sakit. Hal ini secara signifikan berdampak positif terhadap pemulihan pasien serta meningkatkan tingkat kepatuhan pasien dalam mengikuti instruksi medis atau terapi (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Keluarga juga memiliki peran penting dalam membantu pasien mengembangkan strategi coping yang efektif. Misalnya, melalui komunikasi yang baik, keluarga dapat membantu pasien dalam mengekspresikan emosi, perasaan, serta ketakutan yang dialaminya. Dukungan emosional ini memungkinkan pasien

untuk lebih terbuka dalam menghadapi tantangan kesehatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menjalani proses pengobatan. Selain itu, dukungan keluarga juga membantu pasien merasakan penerimaan dan penghargaan, yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi pasien dalam mencapai kesembuhan (Patterson & Garwick, 2022).

4. Keluarga sebagai Unit Utama dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan

Dalam proses keperawatan, keluarga memiliki peran sentral sebagai unit utama dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien. Hal ini terutama terjadi dalam konteks budaya tertentu di mana keluarga memiliki kewenangan besar dalam mengambil keputusan terkait kesehatan anggota keluarganya. Sebagai unit terdekat pasien, keluarga sering kali dilibatkan secara aktif oleh tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan penting, seperti persetujuan tindakan medis, keputusan terkait perawatan jangka panjang, atau menentukan pilihan terapi yang paling sesuai dengan kondisi pasien serta nilai-nilai yang dianut keluarga (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021).

Perawat yang memahami psikologi keluarga akan mampu melihat bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, perawat perlu memperhatikan siapa anggota keluarga yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan, bagaimana pola komunikasi keluarga terkait keputusan kesehatan, serta memahami nilai budaya atau agama yang dianut keluarga dalam konteks perawatan pasien. Dengan memahami aspek psikologis ini, perawat dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pasien maupun keluarganya (Kaakinen et al., 2022).

Selain itu, keluarga sebagai unit pengambilan keputusan juga berperan dalam memastikan kontinuitas perawatan pasien di rumah. Keluarga bertanggung jawab dalam memutuskan aspek-aspek perawatan harian, seperti pemberian obat, nutrisi, latihan fisik, atau pengelolaan gejala penyakit di rumah. Oleh karena itu, peran keluarga sebagai pengambil keputusan tidak hanya terbatas pada saat pasien menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, tetapi juga dalam periode pemulihan jangka panjang di lingkungan rumah. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus mendukung keluarga dalam proses pengambilan keputusan, memberikan edukasi yang komprehensif, serta memastikan keluarga memiliki keterampilan dan informasi yang cukup untuk mengelola kondisi pasien di luar rumah sakit (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

Dengan memahami dan menghargai peran psikologi keluarga ini secara mendalam, tenaga keperawatan dapat memberikan asuhan keperawatan yang

holistik dan efektif, yang mampu meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus memperkuat hubungan emosional dan fungsional keluarga secara keseluruhan.

D. Identifikasi Masalah Psikologis dalam Keluarga dalam Konteks Praktik Keperawatan

5. Metode Pengkajian Psikologis Keluarga dalam Praktik Keperawatan

Pengkajian psikologis keluarga merupakan langkah penting dalam praktik keperawatan keluarga yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi emosional, hubungan interpersonal, serta dinamika psikologis keluarga yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien. Metode pengkajian ini membantu perawat dalam mengidentifikasi kekuatan maupun masalah psikologis dalam keluarga yang dapat mempengaruhi proses perawatan dan penyembuhan pasien.

Salah satu metode pengkajian yang umum digunakan adalah wawancara keluarga. Wawancara ini bisa berupa wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur yang berfokus pada pengumpulan data mengenai pola komunikasi keluarga, hubungan interpersonal antar anggota keluarga, dan respons keluarga terhadap stres akibat kondisi pasien. Melalui wawancara, perawat dapat mengevaluasi bagaimana anggota keluarga merasakan situasi yang sedang mereka hadapi, serta mengidentifikasi potensi konflik, stres, atau masalah psikologis lainnya yang belum terlihat secara eksplisit (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Selain wawancara, perawat juga dapat menggunakan metode observasi langsung terhadap interaksi keluarga selama perawatan di fasilitas kesehatan. Observasi ini dilakukan dengan memperhatikan secara khusus pola interaksi antar anggota keluarga, seperti komunikasi verbal dan non-verbal, ekspresi emosi, serta dukungan atau hambatan emosional yang muncul selama proses perawatan. Observasi ini dapat memberikan informasi tambahan yang lebih objektif dan akurat mengenai hubungan keluarga, pola coping, serta kemampuan keluarga dalam mengelola stres (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

Metode lain yang juga sering digunakan adalah penggunaan instrumen pengukuran psikologis standar seperti kuesioner atau skala penilaian psikologis. Contohnya adalah Family Assessment Device (FAD) dan Family APGAR yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat fungsi keluarga dan mengidentifikasi masalah psikologis seperti stres, konflik, atau disfungsi keluarga. Dengan menggunakan instrumen ini, perawat dapat mengidentifikasi secara

cepat area-area masalah keluarga yang membutuhkan perhatian atau intervensi khusus (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

6. Indikator Masalah Psikologis dalam Keluarga

Masalah psikologis dalam keluarga biasanya dapat dikenali melalui beberapa indikator umum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator yang paling umum adalah adanya konflik interpersonal yang berkepanjangan antar anggota keluarga. Konflik ini bisa berupa pertengkaran yang sering terjadi, perselisihan yang tidak terselesaikan, atau munculnya permusuhan antar anggota keluarga yang berdampak pada komunikasi yang buruk dan rendahnya dukungan sosial terhadap pasien (Walsh, 2021).

Stres keluarga merupakan indikator lain yang sering ditemukan. Stres ini dapat muncul akibat berbagai hal, seperti beban finansial akibat biaya perawatan pasien, ketidakpastian prognosis penyakit, atau perubahan drastis dalam peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Stres keluarga dapat dikenali dari perilaku keluarga seperti cepat marah, kelelahan emosional yang berkepanjangan, dan ketidakmampuan untuk mengelola tugas sehari-hari secara efektif (Patterson & Garwick, 2022).

Selain stres, kecemasan juga merupakan indikator masalah psikologis dalam keluarga yang sering muncul, terutama dalam menghadapi penyakit kronis atau kondisi kesehatan kritis. Kecemasan ini bisa berupa kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan pasien, ketidakmampuan untuk berpikir jernih dalam pengambilan keputusan, atau munculnya perilaku protektif berlebihan terhadap pasien yang justru dapat menyebabkan pasien merasa terbebani atau stres (Giske & Gjengedal, 2021).

Depresi keluarga adalah indikator psikologis yang lebih serius yang dapat dikenali melalui gejala seperti kesedihan berkepanjangan, perasaan putus asa, penarikan diri secara sosial, atau hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasanya dinikmati keluarga. Depresi keluarga ini cenderung muncul ketika keluarga menghadapi situasi kesehatan pasien yang sangat berat atau jangka panjang, di mana keluarga merasa kewalahan, tidak berdaya, atau kehilangan harapan (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021).

7. Dampak Masalah Psikologis Keluarga terhadap Hasil Perawatan Pasien

Masalah psikologis dalam keluarga memiliki dampak langsung terhadap hasil perawatan pasien. Keluarga yang mengalami masalah psikologis seperti konflik, stres berat, kecemasan, atau depresi, cenderung kurang mampu memberikan dukungan emosional yang optimal kepada pasien. Sebagai akibatnya, pasien bisa merasa terisolasi secara emosional, tidak mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan, serta mengalami penurunan motivasi dan

kepercayaan diri dalam menjalani pengobatan dan pemulihan (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

Stres dan kecemasan keluarga juga dapat memperlambat proses penyembuhan pasien. Pasien yang terus-menerus terpapar pada lingkungan keluarga yang penuh tekanan atau kecemasan cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Kondisi ini bisa memperburuk gejala penyakit, menghambat efektivitas pengobatan, bahkan memperlambat proses penyembuhan. Sebaliknya, jika keluarga mampu mengelola stres dengan baik, pasien cenderung memiliki respon positif terhadap perawatan yang diterimanya, termasuk lebih cepat sembuh dan mengalami peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Lor et al., 2023).

Dampak lain dari masalah psikologis keluarga adalah meningkatnya risiko komplikasi psikologis pada pasien sendiri, seperti munculnya gejala depresi, kecemasan kronis, atau gangguan tidur. Pasien yang berasal dari keluarga dengan konflik emosional atau kondisi psikologis yang tidak stabil memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental, yang selanjutnya bisa memperburuk kondisi fisik pasien serta memperpanjang waktu perawatan (Walsh, 2021).

Secara keseluruhan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah psikologis keluarga sangat penting dalam konteks keperawatan. Dengan intervensi yang tepat, seperti konseling keluarga, terapi komunikasi, edukasi keluarga, serta dukungan psikososial, perawat dapat membantu keluarga mengatasi masalah psikologis yang ada, sehingga mendukung hasil perawatan pasien yang lebih baik, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

E. Strategi Integrasi Psikologi Keluarga dalam Proses Keperawatan

Strategi integrasi psikologi keluarga dalam proses keperawatan merupakan serangkaian pendekatan yang bertujuan untuk melibatkan keluarga secara aktif dalam perawatan pasien dengan memperhatikan aspek psikologis dan emosional keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga dapat memberikan dukungan optimal kepada pasien, sehingga mempercepat pemulihan serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya secara keseluruhan.

1. Psikoedukasi Keluarga tentang Penyakit dan Kondisi Pasien

Psikoedukasi keluarga adalah strategi intervensi yang melibatkan pemberian informasi mendalam kepada keluarga mengenai penyakit atau kondisi kesehatan pasien. Tujuan utama psikoedukasi adalah meningkatkan pemahaman keluarga tentang kondisi medis pasien, termasuk penyebab penyakit, gejala yang

dialami pasien, prosedur medis atau terapi yang akan dilakukan, serta prognosis dan potensi komplikasi yang mungkin muncul selama proses perawatan (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

Dalam praktik keperawatan, psikoedukasi tidak hanya mencakup informasi medis, tetapi juga meliputi edukasi mengenai cara keluarga menghadapi aspek emosional dari penyakit tersebut. Perawat secara aktif membantu keluarga memahami bahwa stres, kecemasan, atau perasaan negatif lainnya yang mereka rasakan adalah hal yang wajar dan dapat diatasi dengan strategi tertentu. Psikoedukasi membantu keluarga mengurangi ketidakpastian yang sering kali menjadi sumber stres utama, sehingga mereka lebih mampu mengelola situasi secara tenang dan rasional. Hal ini penting untuk mencegah keluarga mengalami kebingungan, kecemasan berlebihan, atau putus asa yang dapat memperlambat proses pemulihan pasien (Giske & Gjengedal, 2021).

Psikoedukasi juga mempersiapkan keluarga dalam memberikan dukungan nyata kepada pasien. Misalnya, keluarga dilatih mengenai bagaimana cara mengelola obat-obatan pasien, memberikan dukungan emosional yang tepat, dan membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Hasilnya, keluarga menjadi lebih percaya diri dan mampu terlibat secara aktif dalam proses perawatan, yang terbukti mempercepat proses pemulihan pasien (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

2. Peningkatan Keterampilan Komunikasi Terapeutik dalam Keluarga

Keterampilan komunikasi terapeutik merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif yang ditujukan untuk mendukung pemulihan psikologis dan fisik pasien. Dalam konteks keluarga, komunikasi terapeutik berarti keluarga dilatih untuk mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, memberikan dukungan emosional yang konstruktif, serta mengelola konflik secara sehat. Melalui komunikasi terapeutik, keluarga dapat menciptakan lingkungan emosional yang positif bagi pasien, sehingga pasien merasa nyaman, diterima, dan dihargai (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Perawat memainkan peran penting dalam melatih keluarga mengenai keterampilan komunikasi ini. Dalam praktiknya, perawat dapat mengajarkan anggota keluarga mengenai pentingnya bahasa non-verbal, seperti ekspresi wajah, sentuhan lembut, dan kontak mata yang hangat, sebagai bentuk dukungan emosional kepada pasien. Selain itu, keluarga juga dilatih untuk menggunakan bahasa yang menenangkan, mendorong pasien mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya, serta menghindari bentuk komunikasi yang menyalahkan atau menghakimi pasien yang justru bisa memperburuk kondisi emosional pasien (Lor et al., 2023).

3. Pendampingan Psikologis Keluarga selama Proses Perawatan Pasien

Pendampingan psikologis keluarga dalam proses perawatan pasien adalah strategi di mana tenaga keperawatan secara aktif memberikan dukungan emosional langsung kepada keluarga selama pasien menjalani perawatan. Pendampingan ini bisa berupa konseling, sesi konsultasi rutin, atau diskusi kelompok keluarga. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah membantu keluarga mengelola stres dan beban emosional yang muncul akibat penyakit pasien, serta membantu mereka memahami bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tantangan tersebut (Patterson & Garwick, 2022).

Melalui pendampingan ini, keluarga mendapatkan ruang aman untuk mengekspresikan emosi negatif seperti ketakutan, frustrasi, atau kelelahan. Perawat, sebagai pendamping psikologis, bertugas untuk mendengarkan, memberikan validasi emosional, serta menawarkan solusi praktis untuk membantu keluarga menghadapi stres atau tantangan yang muncul selama proses perawatan. Selain itu, pendampingan psikologis juga berguna untuk mengidentifikasi anggota keluarga yang membutuhkan dukungan lebih intensif, seperti mereka yang menunjukkan gejala depresi atau kecemasan berat, sehingga intervensi psikologis tambahan dapat segera diberikan (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021).

4. Fasilitasi Coping Adaptif dan Resiliensi Keluarga dalam Menghadapi Penyakit

Fasilitasi coping adaptif merupakan strategi yang bertujuan untuk membantu keluarga mengembangkan cara-cara positif dalam menghadapi tekanan yang disebabkan oleh kondisi kesehatan pasien. Coping adaptif ini termasuk kemampuan keluarga untuk mengelola stres secara efektif, mengambil keputusan yang rasional dalam situasi kritis, serta menggunakan sumber daya internal (dukungan antaranggota keluarga, komunikasi yang sehat, optimisme) maupun eksternal (dukungan sosial dari komunitas, bantuan profesional) untuk mengatasi tantangan (Walsh, 2021).

Selain coping adaptif, resiliensi keluarga juga penting untuk difasilitasi. Resiliensi keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bangkit kembali atau pulih dari tekanan berat atau krisis kesehatan yang dialami pasien. Dalam konteks ini, resiliensi keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mempertahankan fungsi keluarga secara optimal, menjaga kesehatan emosional antaranggota keluarga, serta melihat tantangan kesehatan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperkuat ikatan keluarga (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

Perawat memiliki peran sentral dalam mendukung dan mengembangkan resiliensi keluarga ini. Dalam praktiknya, perawat dapat mengajarkan keluarga

tentang teknik relaksasi, strategi pengelolaan stres, serta mendorong keluarga untuk saling memberikan dukungan emosional secara rutin. Dengan meningkatnya coping adaptif dan resiliensi keluarga, keluarga akan lebih siap menghadapi kondisi kesehatan pasien dalam jangka panjang, yang pada akhirnya membantu pasien mencapai pemulihan yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga secara keseluruhan (Kaakinen et al., 2022).

Dengan demikian, strategi integrasi psikologi keluarga ke dalam keperawatan ini membantu menciptakan lingkungan perawatan yang holistik dan humanis, di mana baik pasien maupun keluarga mendapatkan dukungan optimal selama seluruh proses perawatan.

F. Peran Perawat dalam Integrasi Psikologi Keluarga dalam Asuhan Keperawatan

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan aspek psikologi keluarga dalam perawatan pasien. Keberhasilan integrasi ini sangat tergantung pada kompetensi khusus perawat dalam memahami psikologi keluarga, keterampilan komunikasi, dan kemampuan mengelola dinamika emosi serta stres yang dialami keluarga pasien selama proses perawatan.

1. Kompetensi Khusus Perawat dalam Aspek Psikologi Keluarga

Dalam mengintegrasikan psikologi keluarga ke dalam praktik keperawatan, perawat dituntut memiliki kompetensi khusus yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Pertama, perawat harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai teori-teori psikologi keluarga, seperti teori sistem keluarga (Family Systems Theory), teori perkembangan keluarga (Family Developmental Theory), serta teori stres dan coping dalam keluarga (Family Stress and Coping Theory). Dengan memahami teori-teori ini, perawat mampu mengidentifikasi bagaimana dinamika internal keluarga dapat mempengaruhi kondisi pasien, dan sebaliknya, bagaimana kondisi pasien dapat mempengaruhi keluarga secara keseluruhan (Kaakinen et al., 2022).

Kedua, kompetensi khusus perawat juga melibatkan keterampilan dalam melakukan pengkajian psikologis keluarga. Perawat harus mampu menggunakan berbagai metode pengkajian, seperti wawancara keluarga, observasi interaksi antaranggota keluarga, serta penggunaan instrumen khusus untuk mengukur tingkat stres atau disfungsi keluarga. Kemampuan ini membantu perawat mengidentifikasi masalah-masalah psikologis yang mungkin belum disadari oleh keluarga tetapi berdampak signifikan terhadap pasien (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Selanjutnya, perawat harus mampu menerapkan pendekatan komunikasi terapeutik secara efektif. Keterampilan ini mencakup kemampuan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, memberikan respons emosional yang tepat, serta menjaga sensitivitas terhadap perasaan dan kebutuhan keluarga. Keterampilan komunikasi yang baik ini penting agar keluarga merasa didengarkan, dihargai, dan didukung secara emosional (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

Terakhir, perawat perlu memiliki kemampuan dalam memberikan intervensi psikososial, seperti konseling keluarga, psikoedukasi, dan pelatihan keterampilan coping adaptif, sehingga keluarga mampu menghadapi tantangan kesehatan pasien dengan lebih baik. Kompetensi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk beradaptasi terhadap tekanan atau perubahan yang muncul selama proses perawatan (Walsh, 2021).

2. Peran Perawat sebagai Fasilitator dan Mediator Komunikasi Keluarga

Peran perawat sebagai fasilitator komunikasi keluarga merupakan aspek penting dalam integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan. Sebagai fasilitator, perawat bertugas menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan aman antaranggota keluarga maupun antara keluarga dan tim kesehatan. Perawat membantu keluarga untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, atau harapan mereka dengan jelas, tanpa rasa takut dihakimi atau dikritik. Misalnya, dalam situasi keluarga yang mengalami konflik atau miskomunikasi terkait perawatan pasien, perawat dapat memandu keluarga untuk mengidentifikasi akar masalah, mengklarifikasi persepsi masing-masing anggota keluarga, dan merumuskan solusi bersama (Giske & Gjengedal, 2021).

Sebagai mediator komunikasi, perawat juga berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dengan tim kesehatan. Dalam konteks ini, perawat membantu keluarga memahami informasi medis yang disampaikan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, menjembatani perbedaan persepsi antara keluarga dan tim kesehatan, serta memastikan bahwa informasi tentang kondisi pasien tersampaikan secara jelas, akurat, dan sesuai dengan tingkat pemahaman keluarga. Melalui peran ini, perawat membantu mengurangi kecemasan keluarga akibat ketidakjelasan informasi atau kesalahpahaman mengenai kondisi pasien dan perawatannya (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021).

Lebih jauh, perawat juga berperan dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan keluarga. Dalam situasi sulit seperti penyakit terminal atau perawatan intensif, keluarga sering kali menghadapi keputusan-keputusan kompleks yang penuh dilema emosional. Dalam situasi ini, perawat bertugas memandu keluarga untuk mengambil keputusan secara rasional dan mempertimbangkan semua

aspek penting, termasuk aspek emosional, nilai-nilai keluarga, dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

3. Manajemen Emosi dan Stres Keluarga dalam Konteks Perawatan Pasien

Salah satu peran penting perawat dalam integrasi psikologi keluarga adalah membantu keluarga mengelola emosi dan stres yang muncul selama perawatan pasien. Dalam menghadapi kondisi kesehatan serius atau kronis, keluarga biasanya mengalami berbagai emosi negatif seperti cemas, takut, sedih, marah, bahkan putus asa. Perawat memiliki peran aktif dalam membantu keluarga mengidentifikasi emosi-emosi ini, memahami penyebabnya, serta memberikan strategi praktis untuk mengelola atau mengurangi dampak negatifnya terhadap pasien maupun keluarga (Patterson & Garwick, 2022).

Dalam manajemen emosi keluarga, perawat bisa menggunakan berbagai pendekatan, seperti konseling singkat, intervensi psikososial, atau teknik relaksasi seperti mindfulness, meditasi, dan latihan pernapasan. Selain itu, perawat juga dapat menyediakan waktu khusus untuk keluarga secara rutin, sehingga keluarga bisa mengungkapkan perasaan mereka dalam situasi yang nyaman dan aman. Pendekatan ini membantu keluarga mendapatkan validasi emosional, merasa lebih tenang, serta mengurangi tingkat stres secara signifikan (Walsh, 2021).

Dalam konteks manajemen stres keluarga, perawat juga membantu keluarga mengembangkan strategi coping adaptif yang tepat. Perawat bisa mengajarkan keluarga bagaimana mengidentifikasi sumber stres utama, mengevaluasi sumber daya yang dimiliki keluarga untuk mengatasi stres tersebut, serta mengajarkan strategi coping yang lebih konstruktif, seperti meningkatkan komunikasi dalam keluarga, menetapkan prioritas tugas, dan memperkuat dukungan antaranggota keluarga. Selain itu, perawat juga menghubungkan keluarga dengan sumber dukungan eksternal, seperti kelompok dukungan keluarga, layanan psikologis, atau komunitas yang menyediakan bantuan sosial (Kaakinen et al., 2022).

Dengan demikian, melalui kompetensi khusus, kemampuan komunikasi terapeutik, peran sebagai fasilitator komunikasi, serta keterampilan dalam manajemen emosi dan stres keluarga, perawat menjadi aktor kunci dalam memastikan integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan berjalan efektif. Peran ini secara langsung berdampak pada peningkatan hasil perawatan pasien, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga secara keseluruhan.

G. Hambatan dan Tantangan dalam Integrasi Psikologi Keluarga dalam Keperawatan

Integrasi psikologi keluarga ke dalam asuhan keperawatan memberikan banyak manfaat, tetapi dalam implementasinya seringkali ditemukan berbagai hambatan dan tantangan yang perlu diatasi agar pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif. Hambatan tersebut dapat berasal dari budaya masyarakat, stigma sosial, serta tantangan komunikasi antara keluarga dan tenaga kesehatan.

1. Hambatan Budaya dan Stigma Sosial dalam Pendekatan Psikologis Keluarga

Hambatan budaya merupakan tantangan utama dalam penerapan pendekatan psikologi keluarga, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional yang kuat. Dalam banyak budaya, masalah psikologis atau emosional sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau bahkan tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Keluarga sering merasa enggan atau malu untuk mengungkapkan kondisi emosional mereka, karena takut dianggap lemah atau mendapat stigma negatif dari masyarakat. Sebagai contoh, dalam budaya tertentu, mengakui adanya stres, depresi, atau kecemasan di dalam keluarga sering dianggap sebagai kegagalan keluarga dalam menjaga kehormatan atau keharmonisan keluarga (Lor, Crooks, & Tluczek, 2023).

Selain itu, stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap masalah psikologis juga menjadi hambatan serius. Banyak keluarga menganggap bahwa intervensi psikologis atau konseling adalah sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan berat. Akibat stigma ini, keluarga cenderung menolak atau menghindari bentuk-bentuk bantuan psikologis yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung pasien dalam proses perawatan. Keluarga yang mengalami stigma sosial mungkin akan memilih untuk diam, menarik diri, atau menolak keterlibatan aktif dalam proses perawatan, yang pada akhirnya menyebabkan pasien tidak mendapat dukungan emosional yang optimal (Giske & Gjengedal, 2021).

Lebih jauh, perbedaan keyakinan atau nilai budaya keluarga juga dapat memengaruhi penerimaan keluarga terhadap pendekatan psikologis dalam keperawatan. Misalnya, keluarga yang memiliki kepercayaan bahwa penyakit fisik maupun psikologis merupakan takdir atau hukuman tertentu cenderung tidak aktif dalam mencari solusi psikologis, dan lebih memilih pendekatan spiritual atau religius dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap upaya perawat untuk menerapkan pendekatan psikologis keluarga dalam perawatan pasien (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2022).

2. Tantangan Komunikasi Antar Anggota Keluarga dan Tenaga Kesehatan

Tantangan komunikasi merupakan salah satu hambatan yang paling sering ditemui dalam integrasi psikologi keluarga ke dalam praktik keperawatan. Komunikasi yang tidak efektif antar anggota keluarga, seperti adanya konflik interpersonal, miskomunikasi, atau kesulitan dalam mengekspresikan perasaan secara jelas, bisa menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan menghambat upaya perawat untuk memberikan intervensi psikologis secara optimal. Misalnya, dalam keluarga yang memiliki pola komunikasi tertutup atau menghindari konfrontasi, sangat sulit bagi perawat untuk mengidentifikasi masalah emosional yang sebenarnya sedang dihadapi keluarga, sehingga intervensi yang diberikan menjadi kurang efektif (Friedman, Bowden, & Jones, 2022).

Selain itu, komunikasi antara keluarga dan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan bahasa atau terminologi medis, perbedaan tingkat pendidikan atau literasi kesehatan, dan perbedaan ekspektasi tentang perawatan pasien bisa menyebabkan kesalahpahaman yang serius. Keluarga seringkali merasa bingung, terintimidasi, atau bahkan tidak mempercayai tenaga kesehatan karena ketidakjelasan informasi yang diterima. Kondisi ini bisa memperparah kecemasan atau stres keluarga, sehingga mereka cenderung menarik diri atau bersikap defensif terhadap tenaga kesehatan (O'Hara, McCabe, & Whittington, 2021).

Kurangnya waktu yang dimiliki perawat untuk berkomunikasi secara mendalam dengan keluarga juga menjadi tantangan besar, terutama di fasilitas kesehatan yang sibuk dengan jumlah pasien yang tinggi. Akibatnya, komunikasi seringkali bersifat terburu-buru dan kurang mendalam, yang membuat keluarga merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan merasa tidak dihargai. Situasi ini dapat memperburuk hubungan keluarga dengan tenaga kesehatan, sekaligus mempersulit implementasi pendekatan psikologi keluarga secara efektif (Wittenberg, Saada, & Prosser, 2022).

3. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Pendekatan Integratif Psikologi Keluarga

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan beberapa strategi yang efektif dan terintegrasi. Pertama, pendekatan sensitif budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan budaya dan stigma sosial. Perawat perlu memahami latar belakang budaya keluarga pasien, termasuk nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang dianut keluarga. Dengan memahami aspek-aspek ini, perawat dapat menyesuaikan intervensi psikologis dengan cara yang lebih diterima oleh keluarga, misalnya dengan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang

dihormati untuk membantu menjelaskan manfaat intervensi psikologis dalam konteks budaya keluarga tersebut (Walsh, 2021).

Strategi edukasi dan psikoedukasi keluarga secara rutin dan berkelanjutan juga penting untuk mengurangi stigma sosial. Perawat dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pentingnya aspek psikologis dalam proses perawatan, serta menekankan bahwa masalah psikologis bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi hal yang sangat wajar dialami oleh banyak keluarga dalam situasi serupa. Selain itu, pendekatan kelompok seperti diskusi keluarga atau grup dukungan keluarga juga dapat digunakan sebagai sarana keluarga untuk saling berbagi pengalaman, sehingga mengurangi stigma sosial secara bertahap (Patterson & Garwick, 2022).

Untuk mengatasi tantangan komunikasi, perawat perlu meningkatkan keterampilan komunikasi terapeutiknya, seperti mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami keluarga. Penggunaan bantuan visual, seperti leaflet, brosur, atau video edukasi juga sangat efektif untuk membantu keluarga memahami informasi medis dengan lebih baik. Selain itu, alokasi waktu khusus secara rutin untuk berdiskusi dengan keluarga, meskipun singkat, dapat meningkatkan kepercayaan keluarga terhadap tenaga kesehatan serta mengurangi risiko kesalahpahaman (Lor et al., 2023).

Terakhir, peningkatan kompetensi perawat melalui pelatihan khusus tentang psikologi keluarga dan komunikasi antarbudaya secara teratur juga sangat penting. Pelatihan ini memastikan bahwa perawat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul, sehingga integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal (Kaakinen et al., 2022).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, hambatan dan tantangan dalam integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan dapat diminimalkan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dan keluarga secara holistik.

H. Simpulan

Integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan merupakan pendekatan yang holistik dan multidimensional yang sangat penting dalam praktik keperawatan modern. Pendekatan ini berfokus pada pengakuan terhadap keluarga bukan sekadar sebagai pendamping pasien, melainkan sebagai unit sosial integral yang mempengaruhi secara signifikan proses kesehatan dan pemulihan pasien. Dengan memahami psikologi keluarga, perawat mampu menggali dinamika

emosional, sosial, dan interaksi dalam keluarga yang dapat mempercepat atau menghambat kesembuhan pasien.

Psikologi keluarga dalam konteks keperawatan mencakup beberapa teori utama, di antaranya teori sistem keluarga yang menekankan interdependensi antaranggota keluarga, teori perkembangan keluarga yang menjelaskan tahapan kehidupan keluarga, dan teori stres dan coping yang menggambarkan bagaimana keluarga menghadapi berbagai tekanan. Ketiga teori ini membantu perawat untuk memahami secara komprehensif bagaimana keluarga berfungsi dan bereaksi terhadap perubahan, khususnya terkait dengan kondisi kesehatan pasien.

Peran psikologi keluarga dalam keperawatan sangat luas. Keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi pasien secara fisik maupun mental. Keluarga dengan kondisi psikologis yang positif memberikan lingkungan emosional yang mendukung dan mempercepat proses penyembuhan pasien, sementara kondisi keluarga yang negatif seperti konflik, stres, kecemasan, atau depresi dapat memperlambat pemulihan bahkan menyebabkan komplikasi tambahan bagi pasien. Di sisi lain, keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung emosional utama, membantu pasien dalam mengelola stres, ketakutan, dan tantangan psikologis lainnya melalui komunikasi yang efektif dan empati.

Dalam proses pengambilan keputusan keperawatan, keluarga seringkali memegang peran sentral. Oleh karena itu, perawat harus mampu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara keluarga dengan tim medis agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Selain itu, perawat berperan penting dalam membantu keluarga mengelola emosi, mengidentifikasi masalah psikologis, serta menyediakan dukungan psikososial yang dibutuhkan keluarga selama proses perawatan pasien.

Strategi integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan mencakup beberapa intervensi penting, seperti psikoedukasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang penyakit dan kondisi pasien, pelatihan keterampilan komunikasi terapeutik guna menciptakan suasana emosional yang positif, pendampingan psikologis yang intensif bagi keluarga selama proses perawatan, serta fasilitasi coping adaptif dan resiliensi keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan.

Walaupun sangat bermanfaat, integrasi psikologi keluarga dalam keperawatan menghadapi beberapa tantangan signifikan, seperti hambatan budaya, stigma sosial terhadap masalah psikologis, serta tantangan komunikasi antaranggota keluarga dan antara keluarga dengan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang sensitif budaya, edukasi yang intensif dan berkelanjutan, peningkatan keterampilan komunikasi terapeutik perawat, serta

pelatihan reguler yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam bidang psikologi keluarga dan komunikasi antarbudaya.

Dengan demikian, integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan merupakan elemen esensial yang memastikan tercapainya perawatan holistik, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya bagi pasien tetapi juga seluruh anggota keluarga, melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan komunikasi, dan peningkatan kemampuan keluarga dalam mengelola stres dan emosi. Secara keseluruhan, pendekatan integratif ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan psikologis keluarga.

I. Referensi

- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2022). *Family nursing: Research, theory, and practice* (6th ed.). Pearson Education.
- Giske, T., & Gjengedal, E. (2021). Family involvement and emotional support in nursing care: Promoting health outcomes through family-centered approaches. *Journal of Advanced Nursing*, 77(2), 674–685. <https://doi.org/10.1111/jan.14627>
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2022). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (7th ed.). F.A. Davis Company.
- Kokorelias, K. M., Gignac, M. A., Naglie, G., & Cameron, J. I. (2020). Toward a universal model of family centered care: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 20(1), 564. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05464-7>
- Lor, M., Crooks, N., & Tluczek, A. (2023). Integrating family psychology into nursing practice: Evidence-based strategies for improving patient and family outcomes. *International Journal of Nursing Studies*, 143, 104505. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104505>
- O'Hara, K., McCabe, C., & Whittington, R. (2021). Family communication in health care: A review of strategies to improve outcomes. *Journal of Family Nursing*, 27(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/1074840720976471>
- Patterson, J. M., & Garwick, A. W. (2022). Family stress and coping theory: Applications in nursing practice. *Family Process*, 61(2), 474–489. <https://doi.org/10.1111/famp.12745>
- Svavarsdottir, E. K., Tryggvadottir, G. B., Gisladdottir, M., Olafsdottir, K. V., & Gudmundsdottir, E. (2020). The impact of chronic illness on family members: A systematic review of psychosocial interventions. *Journal of Family Nursing*, 26(3), 206–233. <https://doi.org/10.1177/1074840720936423>
- Walsh, F. (2021). *Normal family processes: Growing diversity and complexity* (5th

ed.). Guilford Press.

Wittenberg, E., Saada, A., & Prosser, L. A. (2022). Enhancing family-centered communication in healthcare: A review of effective strategies. *Patient Education and Counseling*, 105(5), 1247–1256. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.11.017>

Yeh, P. M., & Bull, M. J. (2022). Family systems nursing: Conceptualizing family as the unit of care. *Journal of Nursing Scholarship*, 54(3), 278–286. <https://doi.org/10.1111/jnu.12740>

J. Glosarium

- **Adaptasi**

Kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atau situasi sulit yang dialami, seperti penyakit kronis, perceraian, atau kehilangan anggota keluarga.

- **Asuhan Keperawatan**

Proses pemberian pelayanan keperawatan secara sistematis yang mencakup pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien secara holistik.

- **Coping Adaptif**

Strategi atau kemampuan keluarga untuk menghadapi tekanan atau stres dengan cara yang konstruktif dan positif, yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung proses pemulihan pasien.

- **Depresi Keluarga**

Kondisi psikologis dalam keluarga yang ditandai oleh kesedihan berkepanjangan, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, penarikan diri secara sosial, serta perasaan putus asa akibat situasi sulit yang sedang dihadapi keluarga.

- **Dinamika Keluarga**

Interaksi emosional, sosial, dan perilaku antar anggota keluarga yang memengaruhi hubungan serta kondisi kesehatan fisik dan mental setiap individu dalam keluarga.

- **Family Assessment Device (FAD)**

Instrumen psikologis yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi keluarga, terutama untuk mengidentifikasi masalah dalam komunikasi, interaksi, peran, dan pengelolaan stres dalam keluarga.

- **Family APGAR**

Alat ukur psikologis yang digunakan untuk menilai fungsi dasar keluarga dalam hal Adaptasi, Partnership (kemitraan), Growth (pertumbuhan), Affection (kasih sayang), dan Resolve (penyelesaian masalah).

- **Family-Centered Care**

Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses perawatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan, peran, serta kondisi psikologis dan emosional keluarga.

- **Integrasi Psikologi Keluarga**

Pendekatan multidimensional dalam praktik keperawatan yang menggabungkan aspek psikologis dan emosional keluarga ke dalam proses perawatan pasien, dengan tujuan meningkatkan hasil kesehatan pasien dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

- **Komunikasi Terapeutik**

Komunikasi yang bertujuan mendukung pemulihan fisik dan psikologis pasien, meliputi kemampuan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, memberikan dukungan emosional, serta mengelola konflik secara sehat.

- **Mediator Komunikasi**

Peran perawat sebagai penghubung antara keluarga dengan tim kesehatan, membantu menjelaskan informasi medis, menjembatani kesalahpahaman, serta memfasilitasi pengambilan keputusan terkait perawatan pasien.

- **Observasi Interaksi Keluarga**

Metode pengkajian yang dilakukan perawat dengan memperhatikan pola komunikasi verbal dan non-verbal antar anggota keluarga selama proses perawatan untuk mengidentifikasi masalah psikologis atau emosional.

- **Pendampingan Psikologis Keluarga**

Intervensi keperawatan yang melibatkan pemberian dukungan emosional langsung kepada keluarga selama proses perawatan, melalui konseling, diskusi, atau sesi konsultasi rutin untuk membantu keluarga menghadapi stres dan beban emosional.

- **Pengambilan Keputusan Keluarga**

Proses keluarga dalam menentukan keputusan terkait perawatan pasien, yang meliputi persetujuan tindakan medis, pilihan terapi, serta pengelolaan kondisi pasien secara jangka panjang di rumah.

- **Psikoedukasi Keluarga**

Intervensi edukatif yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi medis pasien serta cara menghadapi aspek emosional dan stres yang muncul akibat kondisi tersebut.

- **Resiliensi Keluarga**

Kemampuan keluarga untuk pulih atau bangkit kembali setelah mengalami situasi sulit atau tekanan berat, dengan mempertahankan fungsi keluarga, menjaga

kesehatan emosional, serta menjadikan tantangan sebagai peluang pertumbuhan keluarga.

- **Sistem Pendukung Emosional**

Peran keluarga sebagai sumber utama dukungan emosional bagi pasien, yang menciptakan lingkungan psikologis positif untuk membantu pasien merasa nyaman, aman, dan termotivasi selama proses perawatan.

- **Stigma Sosial**

Pandangan negatif masyarakat terhadap masalah psikologis atau emosional yang dialami keluarga, yang menyebabkan keluarga enggan untuk mencari atau menerima bantuan psikologis.

- **Teori Perkembangan Keluarga (Family Developmental Theory)**

Teori yang menggambarkan bahwa keluarga mengalami siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahapan, di mana setiap tahap memiliki tantangan serta tugas psikologis khusus yang harus diselesaikan.

- **Teori Sistem Keluarga (Family Systems Theory)**

Teori yang menganggap keluarga sebagai suatu sistem interdependen, di mana perubahan pada salah satu anggota keluarga akan memengaruhi seluruh sistem keluarga secara emosional dan fungsional.

- **Teori Stres dan Coping dalam Keluarga (Family Stress and Coping Theory)**

Teori yang mengkaji bagaimana keluarga menghadapi dan mengelola stres, dengan menekankan pentingnya strategi coping yang adaptif serta ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal dalam keluarga.

PROFIL PENULIS



Ns. M. Agung Akbar, S.Kep., M.Kep lahir di Baturaja, Sumatera Selatan. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi DIII Keperawatan STIKes Al-Ma'arif Baturaja dengan jabatan fungsional Asisten Ahli di bidang Keperawatan Komunitas. Penulis menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, dan saat ini sedang menjalani pendidikan Doktorat Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Penulis saat ini sebagai awardee LPDP Doktor Dalam Negeri Tahun 2023. Beberapa penghargaan akademis dan non-akademis telah penulis raih selama menggeluti dunia akademis. Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif dalam beberapa penulisan artikel kesehatan di media cetak maupun online, terlibat dalam beberapa penelitian dan publikasi ilmiah, editor jurnal ilmiah, reviewer jurnal, hingga presentasi pada seminar nasional maupun konferensi internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: magungakbar24@gmail.com.



Imron Yaman S.Kep, Ns, M.Kes Lahir di Tongke. Luwuk Banggai, 05 Juli 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Biomedik Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1992 bekerja sebagai ASN Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tepatnya Di Puskesmas Tarailu Kab. Mamuju, Tahun 2008 pindah ke Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2010 dari Pemda Beralih ke ASN Kopertis Wilayah IX (L2DIKTI IX) sebagai Dosen DPK. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene, mengampuh mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, KMB, Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imranyaman261@gmail.com/
Motto: "Jangan berkecil hati jika jawaban doamu tidak segera datang pelajailah, renungkan dan tetap berdoa, memiliki iman yang tulus, dan menjalankan perintahNya".

PROFIL PENULIS



Ns. Yenny B. Makahaghi, S. Kep, M. Kes, Lahir di Tahuna, 26 Juli 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2010 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2012 dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 ditempatkan di RSUD Liun Kendage Tahuna, Tahun 1998 ditugaskan sebagai tenaga pendidik di Sekolah Perawat Kesehatan Pemkab Sangihe selanjutnya menjadi Akper Pemkab Sangihe. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Negeri Nusa Utara, mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Metodologi Keperawatan, Manajemen Patient Safety, Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Seminar, Penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta penulis aktif dalam organisasi Profesi Perawat (PPNI). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ymakahaghi@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Pendekatan Multidisipliner menghadirkan rangkaian kajian mendalam mengenai praktik keperawatan keluarga yang dikembangkan melalui pendekatan lintas profesi dan ilmu. Dalam Bab pertama, pembaca diajak memahami pentingnya kolaborasi interprofesional dalam asuhan keperawatan keluarga, dengan penekanan pada peran perawat sebagai pemimpin dalam tim layanan kesehatan. Bab ini juga mengupas manfaat nyata kolaborasi tim serta tantangan yang sering dihadapi dalam praktik, termasuk perspektif pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan.

Bab kedua memperluas cakupan pembahasan ke dalam aspek kejiwaan dan emosional dalam keluarga. Buku ini menyoroti model intervensi keperawatan yang dirancang khusus untuk menghadapi penyakit mental dan gangguan emosional dalam konteks keluarga. Kolaborasi lintas profesi ditekankan sebagai pendekatan strategis dalam memberikan intervensi yang lebih efektif, sembari tetap mempertimbangkan dinamika keluarga sebagai lingkungan utama pemulihan. Penulis juga menggambarkan berbagai tantangan serta solusi implementatif dalam praktik intervensi berbasis keluarga.

Sementara itu, Bab ketiga menekankan pentingnya integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan, menggarisbawahi bahwa kesehatan keluarga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Bab ini mengulas peran perawat dalam mengidentifikasi dan menangani masalah psikologis keluarga serta bagaimana psikologi dapat diintegrasikan dalam proses keperawatan secara holistik. Dengan pendekatan multidisipliner yang menyeluruh, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan yang ingin mengembangkan asuhan keluarga berbasis kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan nyata keluarga Indonesia.

Buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Pendekatan Multidisipliner menghadirkan rangkaian kajian mendalam mengenai praktik keperawatan keluarga yang dikembangkan melalui pendekatan lintas profesi dan ilmu. Dalam Bab pertama, pembaca diajak memahami pentingnya kolaborasi interprofesional dalam asuhan keperawatan keluarga, dengan penekanan pada peran perawat sebagai pemimpin dalam tim layanan kesehatan. Bab ini juga mengupas manfaat nyata kolaborasi tim serta tantangan yang sering dihadapi dalam praktik, termasuk perspektif pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Bab kedua memperluas cakupan pembahasan ke dalam aspek kejiwaan dan emosional dalam keluarga. Buku ini menyoroti model intervensi keperawatan yang dirancang khusus untuk menghadapi penyakit mental dan gangguan emosional dalam konteks keluarga. Kolaborasi lintas profesi ditekankan sebagai pendekatan strategis dalam memberikan intervensi yang lebih efektif, sembari tetap mempertimbangkan dinamika keluarga sebagai lingkungan utama pemulihan. Penulis juga menggambarkan berbagai tantangan serta solusi implementatif dalam praktik intervensi berbasis keluarga. Sementara itu, Bab ketiga menekankan pentingnya integrasi psikologi keluarga dalam asuhan keperawatan, menggarisbawahi bahwa kesehatan keluarga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Bab ini mengulas peran perawat dalam mengidentifikasi dan menangani masalah psikologis keluarga serta bagaimana psikologi dapat diintegrasikan dalam proses keperawatan secara holistik. Dengan pendekatan multidisipliner yang menyeluruh, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan yang ingin mengembangkan asuhan keluarga berbasis kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan nyata keluarga Indonesia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-57-2



9

786347

219572